

Buku Referensi

EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICE

Dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Indonesia

Yoanita Hijriyati • Nunung Nurhayati
Devanda Faiqh Albyn • Sitti Herliyanti Rambu



BUKU REFERENSI : EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICE DALAM KONTEKS PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA

Penulis

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Ns. Devanda Faiqh Albyn, S.Kep., M.Kep., M.M©.

Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi : Evidence-Based Nursing Practice Dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Indonesia

Penulis:

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.
Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.
Ns. Devanda Faiqh Albyn, S.Kep., M.Kep., M.MC.
Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: (diisi oleh tim optimal)

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-13-8

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi *Evidence-Based Nursing Practice dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Indonesia* ini dapat disusun. Buku ini dihadirkan sebagai upaya mendukung peningkatan mutu asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan Indonesia.

Dalam praktik sehari-hari, perawat dituntut mengambil keputusan klinis yang tepat di tengah kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sistem pelayanan. *Evidence-based nursing (EBN)* menjadi pendekatan penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut, dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, kompetensi klinis, serta nilai dan preferensi pasien, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan kebijakan layanan kesehatan di Indonesia.

Buku ini disusun untuk mahasiswa, dosen, praktisi, manajer keperawatan, dan peneliti sebagai rujukan konseptual sekaligus praktis. Pembahasan dimulai dari konsep dan filosofi EBN, dilanjutkan hierarki evidence serta *critical appraisal* sebagai dasar penilaian mutu bukti. Buku ini juga menekankan pentingnya adaptasi guideline global agar selaras dengan kebutuhan dan realitas pelayanan di Indonesia. Selanjutnya, pembaca diarahkan pada strategi implementasi EBN baik di rumah sakit maupun pada pelayanan primer dan komunitas, termasuk identifikasi hambatan organisasi dan budaya klinis yang kerap muncul. Pada bagian akhir, disajikan strategi membangun budaya riset dalam praktik keperawatan sebagai fondasi pengembangan mutu berkelanjutan.

Kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti di Indonesia.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 HIERARKI EVIDENCE DAN CRITICAL APPRAISAL DALAM KEPERAWATAN 1

A. Pendahuluan	1
B. Konsep Evidence-Based Practice (EBP)	2
C. Peran evidence dalam keperawatan	3
D. Prinsip dasar validitas dan kualitas penelitian	5
E. Hierarki Evidence.....	7
F. Critical Appraisal.....	11
G. Appraisal Penelitian.....	15
H. Implementasi dalam Keperawatan	19
I. Penutupan	22
Referensi	25
Glosarium	29

BAB 2 ADAPTASI GUIDELINE OHN GLOBAL DARI (ABOHN) KE KONTEKS INDONESIA (APPOKI)

A. Pendahuluan	32
B. AAOHN (American Association of Occupational Health Nurses) & ABOHN (American Board for Occupational Health Nurses)	35
C. ANZOM (Australian and New Zealand Society of Occupational Medicine)	36
D. OHN di Eropa Faculty of Occupational Health Nursing (FOHN) - The Society of Occupational Medicine (SOM) UK & The Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU).....	38
E. COHNA-ACIIST (Canadian Occupational Health Nurses Association / Association Canadienne des Infirmières et Infirmiers en Santé du Travail)	43
F. OHNAP (Occupational Health Nurses Association of the Philipine)	49
G. COHN (NIOSH Malaysia)	51
H. APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia)	54
I. Perawat Industry "DOH (Department of Health Abu Dhabi, ex-HAAD), DHA (Dubai Health Authority), dan otoritas serupa di Timur Tengah.	55
J. South African Society of Occupational Health Nursing Practitioners (SASOHN)	57
Referensi	59

BAB 3 IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED NURSING DI RUMAH SAKIT.....	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Tujuan dan Manfaat Penerapan EBN di Rumah Sakit.....	71
C. Kerangka Umum Implementasi EBN di Lingkungan Rumah Sakit.....	72
D. Model Implementasi EBN di Rumah Sakit.....	75
E. Tahapan Implementasi EBN di Rumah Sakit.....	81
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi EBN di Rumah Sakit.....	85
G. Strategi Mengembangkan dan Mempertahankan Budaya EBN di Rumah Sakit....	86
H. Penutup	89
Referensi	91
 BAB 4 HAMBATAN ORGANISASI DAN BUDAYA KLINIS.....	 95
A. Pendahuluan.....	95
B. Hambatan Organisasi dalam Implementasi EBNP	96
C. Hambatan Budaya Klinis dalam Implementasi EBNP.....	99
D. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP).....	103
E. Penutup	107
Referensi	108
 PROFIL PENULIS	 109

BAB 1

HIERARKI EVIDENCE DAN CRITICAL APPRAISAL DALAM KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik keperawatan. Jika sebelumnya praktik keperawatan banyak bertumpu pada pengalaman klinis, kini pendekatannya semakin bergeser ke arah praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) (Ominyi & Alabi, 2025). Dalam konteks ini, *Evidence-Based Practice (EBP)* dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien secara seimbang (Connor et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga berperan dalam menjamin keselamatan pasien serta meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep *evidence* menjadi kompetensi dasar yang penting bagi mahasiswa keperawatan sejak awal Pendidikan (Marfo et al., 2026).

Kemajuan dalam publikasi ilmiah di bidang kesehatan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Jumlah informasi yang tersedia sangat besar, tetapi tidak semuanya memiliki kualitas yang baik atau relevan untuk praktik klinis (Glasziou & Sanders, 2020). Kondisi ini menuntut tenaga keperawatan untuk memiliki kemampuan dalam menyaring dan menafsirkan hasil penelitian secara tepat. Dalam hal ini, hierarki *evidence* berperan sebagai kerangka konseptual yang membantu mengelompokkan bukti berdasarkan tingkat kekuatan dan kualitas metodologinya (Fan et al., 2026). Melalui pendekatan ini, perawat dapat menentukan jenis penelitian yang paling dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan klinis (Bastian et al., 2010).

Keberadaan hierarki *evidence* tidak secara otomatis menjamin bahwa suatu bukti layak digunakan dalam praktik. Diperlukan kemampuan untuk melakukan penilaian kritis terhadap setiap penelitian yang tersedia (Barker et al., 2023). Proses ini dikenal sebagai *critical appraisal*, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi validitas, konsistensi, dan relevansi hasil penelitian sebelum diterapkan dalam konteks klinis (Long et al., 2020). Melalui proses ini, perawat

dapat mengidentifikasi potensi bias, menilai kekuatan desain penelitian, serta memahami keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian tersebut (Andrews et al., 2013).

Keterampilan melakukan *critical appraisal* tidak hanya relevan bagi peneliti, tetapi juga sangat penting dalam praktik keperawatan sehari-hari (Barker et al., 2023). Dengan kemampuan ini, perawat dapat menilai apakah suatu intervensi benar-benar efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Lehane et al., 2019). Untuk mendukung proses tersebut, berbagai instrumen telah dikembangkan, seperti CASP dan alat dari *Joanna Briggs Institute (JBI)*, yang membantu melakukan evaluasi penelitian secara sistematis dan terstruktur (Connor et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa *critical appraisal* merupakan bagian integral dari implementasi EBP dalam praktik keperawatan.

Penguasaan konsep hierarki *evidence* dan *critical appraisal* menjadi sangat penting dalam pendidikan keperawatan. Kedua aspek ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi penelitian, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis yang esensial dalam praktik klinis. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus aplikatif mengenai kedua konsep tersebut, sehingga mahasiswa keperawatan diharapkan mampu menggunakan bukti ilmiah secara tepat dalam pengambilan keputusan klinis serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

B. Konsep Evidence-Based Practice (EBP)

Evidence-Based Practice (EBP) dalam keperawatan merupakan suatu pendekatan sistematis yang menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis (Koçak, 2025). Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan berpusat pada pasien (Lehane et al., 2019). Dalam penerapannya, EBP tidak hanya bergantung pada hasil penelitian, melainkan mengintegrasikan secara harmonis antara bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien yang bersifat individual (Jennings et al., 2024). Dengan demikian, EBP menjadi fondasi penting dalam praktik keperawatan profesional yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

EBP semakin diakui sebagai standar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern. Berbagai organisasi internasional, termasuk World Health Organization (WHO), menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti ilmiah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjamin keselamatan pasien. Selain itu, pendekatan berbasis bukti juga

dipandang sebagai strategi yang efektif dalam mendukung terciptanya sistem kesehatan yang efisien dan berkelanjutan (Murray et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan EBP tidak hanya berdampak pada hasil klinis pasien, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.

EBP dijalankan melalui suatu proses yang terstruktur yang dikenal sebagai siklus EBP. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah klinis yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan pertanyaan klinis yang sistematis, pencarian bukti ilmiah yang sesuai, serta penilaian kritis terhadap kualitas bukti tersebut. Tahapan berikutnya adalah penerapan hasil temuan dalam praktik serta evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan (J. Wang et al., 2021). Setiap tahapan tersebut memerlukan kemampuan berpikir kritis, keterampilan literasi informasi, serta ketelitian dalam menilai keabsahan data. Dengan mengikuti siklus ini secara konsisten, keputusan klinis yang diambil akan lebih terarah dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Implementasi EBP dalam praktik keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap sumber informasi ilmiah, keterbatasan waktu dalam praktik klinis, serta kurangnya kemampuan dalam melakukan penilaian kritis terhadap hasil penelitian (Ominyi & Alabi, 2025). Di samping itu, faktor organisasi seperti budaya kerja dan dukungan institusi juga turut memengaruhi keberhasilan penerapan EBP. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi perawat melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Penguasaan konsep *Evidence-Based Practice* menjadi sangat penting dalam pendidikan keperawatan. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep secara teoritis, tetapi juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mencari, menilai, dan mengaplikasikan bukti ilmiah dalam praktik klinis. Hal ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya praktik berbasis bukti di lingkungan pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, penerapan EBP secara konsisten akan mendukung terwujudnya praktik keperawatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

C. Peran *evidence* dalam keperawatan

Penggunaan *evidence* atau bukti ilmiah menempati posisi yang sangat penting dalam menjamin mutu asuhan yang diberikan kepada pasien. *Evidence* tidak hanya dimaknai sebagai hasil penelitian semata, tetapi juga mencakup berbagai informasi ilmiah yang telah melalui proses validasi dan pengujian metodologis yang ketat (Jones et al., 2024). Melalui integrasi *evidence* dalam praktik, perawat dapat

memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan didasarkan pada pengetahuan terkini yang memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Unal, 2022). Dengan demikian, penerapan evidence menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien serta efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Dawes et al., 2005).

Evidence berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang bersifat rasional dan sistematis. Dalam menghadapi kondisi klinis yang kompleks, perawat sering dihadapkan pada berbagai pilihan tindakan yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Kehadiran *evidence* yang kuat memungkinkan pengambilan keputusan tidak lagi semata-mata bergantung pada pengalaman pribadi, tetapi didukung oleh data empiris yang relevan dan terpercaya (Glasziou & Sanders, 2020). World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan kesehatan merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan mutu pelayanan serta hasil kesehatan pasien (Ham, 1995). Oleh karena itu, evidence menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam praktik keperawatan berbasis bukti (Albarqouni et al., 2018).

Pemanfaatan *evidence* juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme perawat. Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengaplikasikan hasil penelitian mencerminkan kompetensi perawat dalam menjalankan praktik berbasis ilmu pengetahuan (Lehane et al., 2019). Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat citra profesi keperawatan sebagai profesi yang berbasis ilmiah (Koçak, 2025). Dalam konteks ini, perawat dituntut memiliki kemampuan literasi penelitian yang memadai agar mampu menilai kualitas evidence sebelum digunakan dalam praktik klinis (Dang et al., 2022). Dengan demikian, evidence menjadi sarana penting dalam pengembangan praktik keperawatan yang profesional dan akuntabel.

Evidence juga berperan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Dengan mengacu pada evidence, perawat dapat memilih intervensi yang telah terbukti efektif serta menghindari tindakan yang tidak memberikan manfaat atau berpotensi merugikan pasien (Lipsitz et al., 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan praktik berbasis bukti dapat menurunkan angka kesalahan medis sekaligus meningkatkan hasil klinis pasien secara signifikan (Thabane et al., 2023). Oleh karena itu, *evidence* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan.

Implementasi *evidence* dalam praktik keperawatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan akses terhadap sumber ilmiah, keterbatasan waktu dalam

praktik klinis, serta variasi kemampuan dalam memahami hasil penelitian menjadi hambatan yang sering dijumpai (Lehane et al., 2019). Selain itu, faktor organisasi seperti kurangnya dukungan institusi dan belum terbentuknya budaya kerja berbasis *evidence* juga turut memengaruhi penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi perawat melalui pendidikan, pelatihan, serta penyediaan akses terhadap sumber informasi ilmiah yang memadai (Aarons et al., 2013).

Evidence merupakan elemen fundamental dalam praktik keperawatan. *Evidence* tidak hanya mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme perawat, serta menjamin keselamatan pasien. Oleh karena itu, mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengaplikasikan *evidence* secara kritis sejak tahap pendidikan. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu menjadi tenaga keperawatan yang kompeten dan berorientasi pada praktik berbasis bukti dalam menghadapi dinamika pelayanan kesehatan di masa depan.

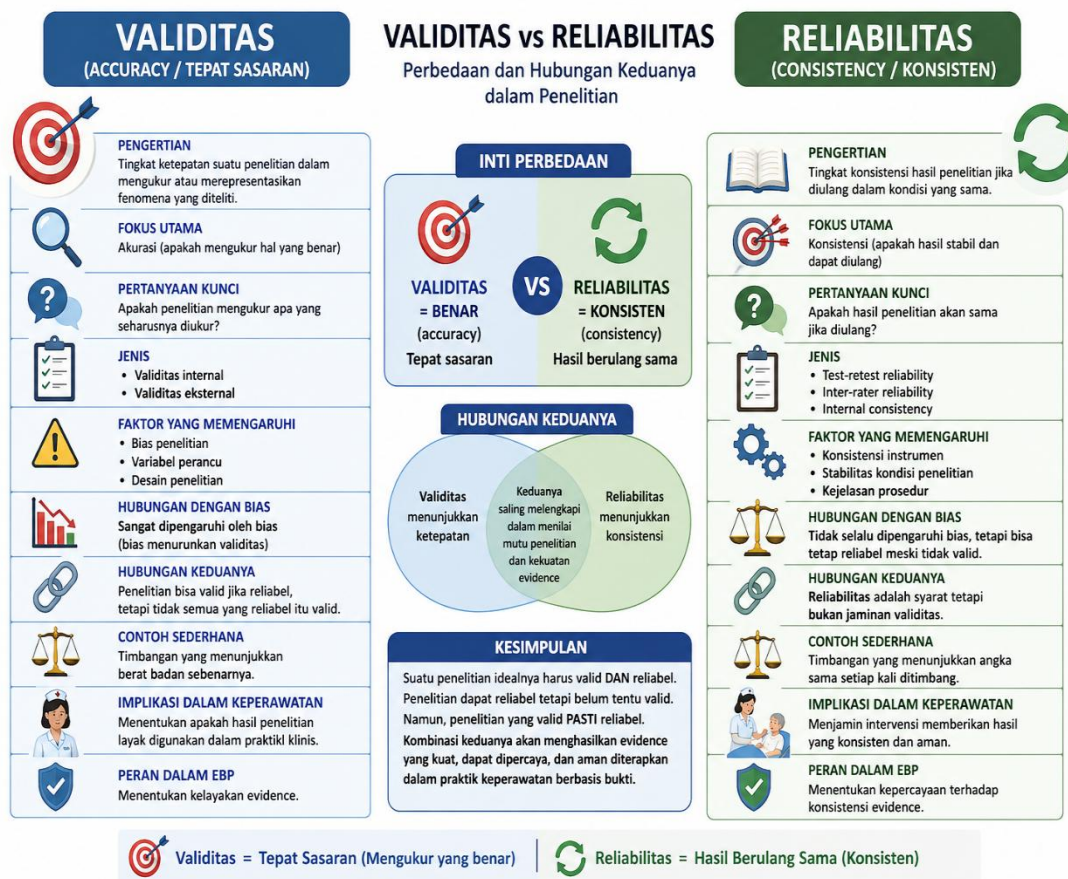
D. Prinsip dasar validitas dan kualitas penelitian

Pemahaman terhadap validitas dan kualitas penelitian merupakan fondasi yang sangat penting. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu penelitian mampu merepresentasikan atau mengukur fenomena yang menjadi fokus kajian secara tepat, sedangkan kualitas penelitian berkaitan dengan kekuatan metodologi serta ketepatan hasil yang dihasilkan (Barker et al., 2023). Penelitian yang memiliki validitas tinggi cenderung menghasilkan temuan yang lebih dapat dipercaya dan relevan untuk diterapkan dalam praktik klinis. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan suatu penelitian sebelum menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis (Akobeng, 2004).

Validitas dalam penelitian umumnya dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian terbebas dari pengaruh bias dan variabel perancu, sehingga hubungan sebab-akibat yang diteliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Page et al., 2021a). Sementara itu, validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau dalam konteks klinis yang berbeda (Akobeng, 2004). Kedua aspek ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah suatu hasil penelitian relevan untuk digunakan dalam praktik keperawatan yang beragam.

Kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian dengan kontrol yang ketat, seperti *randomized controlled trial* (RCT) dan *systematic review*, umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desain yang lebih sederhana (Page et al., 2021a). Namun demikian, kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh jenis desain, melainkan juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan metode, transparansi dalam pelaporan hasil, serta ketepatan dalam analisis data (Murad et al., 2016). Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis desain penelitian menjadi penting agar perawat mampu menilai kekuatan dan keterbatasan suatu studi secara lebih komprehensif.

Potensi bias merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas penelitian. Bias dapat muncul pada berbagai tahap penelitian, mulai dari pemilihan sampel, proses pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi hasil. Keberadaan bias dapat menurunkan akurasi temuan serta berpotensi menghasilkan



Gambar 1. 1 Validitas dan Reliabilitas

kesimpulan yang kurang tepat (Barker et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bias menjadi bagian integral dalam proses *critical appraisal*. Berbagai instrumen seperti CASP dan alat dari Joanna

Briggs Institute (JBI) telah dikembangkan untuk membantu proses penilaian kualitas penelitian secara sistematis dan terstruktur (Akobeng, 2004).

Reliabilitas juga menjadi komponen penting dalam menilai mutu penelitian. Reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil penelitian apabila prosedur yang sama diterapkan kembali dalam kondisi yang serupa (T. K. Koo & Li, 2016). Penelitian yang reliabel akan menghasilkan data yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap temuan yang diperoleh. Dalam praktik keperawatan, penggunaan *evidence* yang memiliki reliabilitas tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan memberikan hasil yang konsisten dan aman bagi pasien (M. Koo & Yang, 2025).

Validitas dan kualitas penelitian merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menentukan kekuatan suatu *evidence*. Pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini akan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam memilih bukti ilmiah yang tepat untuk diterapkan dalam praktik klinis. Selain itu, kemampuan dalam melakukan penilaian kritis terhadap penelitian akan mendorong terbentuknya praktik keperawatan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada bukti. Oleh karena itu, penguasaan prinsip-prinsip validitas dan kualitas penelitian menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi perawat di era *evidence-based practice*.

E. Hierarki Evidence

1. Tingkatan evidence (systematic review hingga expert opinion)

Hierarki *evidence* berperan sebagai kerangka konseptual yang membantu mengelompokkan berbagai jenis penelitian berdasarkan kekuatan metodologinya. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat menilai tingkat keandalan suatu bukti sebelum menggunakannya dalam pengambilan keputusan klinis (Barker et al., 2023). Secara umum, hierarki evidence digambarkan dalam bentuk piramida, di mana bagian puncak menunjukkan bukti dengan tingkat kepercayaan paling tinggi, sementara bagian dasar merepresentasikan bukti dengan kekuatan yang lebih rendah. Struktur ini memudahkan perawat dalam menentukan prioritas penggunaan *evidence* yang paling berkualitas dalam praktik klinis sehari-hari (Murad et al., 2016).

Pada tingkat tertinggi dalam hierarki tersebut terdapat *systematic review* dan *meta-analysis*, yang secara luas diakui sebagai sumber evidence paling kuat. *Systematic review* merupakan kajian yang menggabungkan berbagai penelitian yang relevan dengan pendekatan yang sistematis dan transparan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian

tunggal (Page et al., 2021a). Ketika dipadukan dengan *meta-analysis*, data dari berbagai penelitian kuantitatif dianalisis secara statistik untuk memperoleh estimasi efek yang lebih akurat. Oleh karena itu, jenis evidence ini sering dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman klinis maupun kebijakan kesehatan (Moher et al., 2009).

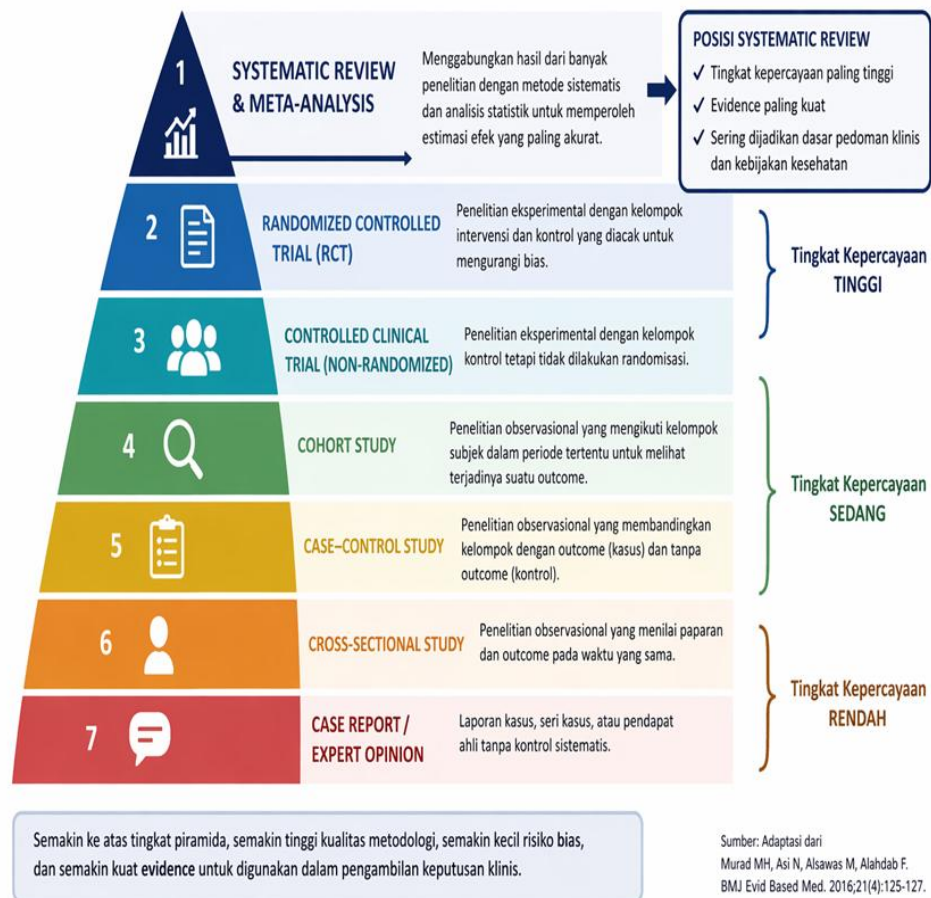
Di bawahnya, terdapat *randomized controlled trial* (RCT), yaitu penelitian eksperimental yang dirancang dengan kontrol ketat terhadap variabel penelitian (Rothwell, 2006). Kekuatan utama RCT terletak pada validitas internalnya, karena proses randomisasi mampu meminimalkan potensi bias. Hal ini menjadikan RCT sebagai salah satu standar utama dalam menilai efektivitas suatu intervensi kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan RCT sering menghadapi berbagai kendala, seperti kebutuhan sumber daya yang besar, waktu yang panjang, serta pertimbangan etika yang harus diperhatikan (Glasziou & Sanders, 2020).

Pada tingkat menengah dalam hierarki *evidence* terdapat penelitian observasional analitik, seperti studi kohort dan *case-control*. Studi kohort digunakan untuk mengamati hubungan antara paparan dan kejadian dalam periode waktu tertentu, sedangkan studi *case-control* membandingkan kelompok dengan kondisi tertentu dengan kelompok pembanding untuk mengidentifikasi faktor risiko (Vandenbroucke & Pearce, 2012). Meskipun tingkat kontrolnya tidak sekuat RCT, penelitian observasional tetap memberikan kontribusi penting, terutama dalam situasi di mana penelitian eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan (Oliveira et al., 2024).

Pada tingkat berikutnya, terdapat penelitian deskriptif yang mencakup studi *cross-sectional*, *case series*, serta penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini umumnya bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau pengalaman pasien secara mendalam (X. Wang & Cheng, 2020). Meskipun tidak dirancang untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tetap memiliki nilai penting dalam memberikan pemahaman kontekstual yang mendukung praktik keperawatan yang berpusat pada pasien (Koçak, 2025).

Adapun pada tingkat paling bawah dalam hierarki *evidence* terdapat *expert opinion* dan pengalaman klinis. *Evidence* pada tingkat ini umumnya berasal dari pandangan para ahli atau konsensus profesional yang belum didukung oleh penelitian empiris yang kuat (Glasziou & Sanders, 2020). Meskipun memiliki keterbatasan, *expert opinion* tetap dapat digunakan sebagai rujukan awal, khususnya ketika evidence yang lebih kuat belum tersedia. Namun demikian, penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati dan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber evidence lain yang lebih kuat apabila memungkinkan (Barker et al., 2023).

PIRAMIDA EVIDENCE (HIERARKI BUKTI)



Gambar 1. 2 Piramida Evidence

Hierarki *evidence* memberikan panduan yang sistematis dalam menilai kekuatan berbagai jenis bukti ilmiah dalam keperawatan. Pemahaman terhadap tingkatan *evidence* memungkinkan mahasiswa dan praktisi keperawatan untuk memilih sumber bukti yang paling sesuai dengan kebutuhan klinis yang dihadapi. Meskipun hierarki ini memberikan arah yang jelas, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi pasien, konteks klinis, serta pertimbangan profesional dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

2. Kelebihan dan keterbatasan

Hierarki *evidence* merupakan salah satu konsep sentral dalam praktik keperawatan berbasis bukti karena menyediakan kerangka yang terstruktur untuk menilai serta mengurutkan kekuatan berbagai jenis penelitian. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi sumber bukti yang memiliki tingkat keandalan paling tinggi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan klinis (Lehane et al., 2019). Dengan demikian, hierarki *evidence* berperan dalam memastikan bahwa praktik keperawatan didasarkan

pada bukti ilmiah yang valid dan relevan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Koçak, 2025). Oleh sebab itu, hierarki *evidence* dapat dipandang sebagai acuan awal yang penting dalam proses seleksi *evidence*.

Kelebihan utama dari hierarki *evidence* terletak pada kemampuannya dalam menyederhanakan kompleksitas informasi ilmiah. Dengan mengklasifikasikan berbagai desain penelitian ke dalam tingkatan tertentu, hierarki ini membantu perawat maupun mahasiswa keperawatan memahami perbedaan kualitas bukti secara lebih sistematis (Emary et al., 2025). Selain itu, bentuk piramida yang digunakan memberikan gambaran visual yang jelas mengenai prioritas penggunaan *evidence*, di mana bukti dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, seperti *systematic review* dan *randomized controlled trial* (RCT), ditempatkan pada posisi teratas, sedangkan bukti dengan kekuatan lebih rendah berada di bagian bawah. Hal ini sangat membantu dalam situasi klinis yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat namun tetap berbasis bukti yang kuat (Murad et al., 2016).

Hierarki *evidence* juga mendukung terciptanya pengambilan keputusan klinis yang lebih objektif dan terstandar (Emary et al., 2025). Dengan adanya klasifikasi yang jelas, perawat dapat mengurangi ketergantungan pada pengalaman subjektif dan lebih mengedepankan penggunaan data empiris yang telah teruji secara ilmiah. Selain itu, hierarki *evidence* sering dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan pedoman klinis dan kebijakan kesehatan, karena memungkinkan pemilihan bukti terbaik yang tersedia untuk merancang intervensi yang efektif dan efisien (Al et al., 2024).

Namun demikian di balik berbagai kelebihanannya, hierarki *evidence* juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipahami secara kritis. Salah satu keterbatasan yang sering dibahas adalah kecenderungan untuk menempatkan desain penelitian tertentu, khususnya penelitian kuantitatif seperti RCT, sebagai bentuk *evidence* yang paling unggul tanpa mempertimbangkan konteks penggunaannya (Emary et al., 2025). Dalam praktik keperawatan, terutama yang berkaitan dengan pengalaman dan persepsi pasien, penelitian kualitatif juga memiliki kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, penggunaan hierarki *evidence* secara kaku berpotensi mengabaikan jenis *evidence* lain yang relevan dan kontekstual (Sekhon et al., 2024).

Hierarki *evidence* tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pelaksanaan suatu penelitian. Penelitian dengan desain tinggi seperti RCT tidak selalu memiliki kualitas yang baik apabila terdapat kelemahan dalam metodologi atau pelaksanaannya (Das, 2026). Sebaliknya, penelitian dengan desain yang lebih

sederhana dapat memberikan temuan yang bermakna apabila dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap evidence tidak cukup hanya berdasarkan posisi dalam hierarki, tetapi juga memerlukan proses *critical appraisal* yang komprehensif (Maheshwarappa & Majumder, 2023).

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya fleksibilitas hierarki evidence dalam menjawab berbagai jenis pertanyaan klinis (Murad et al., 2016). Tidak semua pertanyaan klinis dapat dijawab dengan pendekatan penelitian yang sama. Misalnya, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman pasien atau aspek psikososial lebih tepat dijawab melalui penelitian kualitatif, sedangkan pertanyaan mengenai efektivitas intervensi lebih sesuai menggunakan desain eksperimental. Oleh karena itu, penggunaan hierarki evidence perlu disesuaikan dengan jenis pertanyaan klinis yang dihadapi agar tetap relevan dan aplikatif (Emary et al., 2025).

Hierarki *evidence* memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam menilai kekuatan bukti ilmiah dalam keperawatan. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, seperti sistematis, mudah dipahami, dan mendukung pengambilan keputusan klinis, hierarki ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan berbasis bukti, penggunaan hierarki evidence sebaiknya tidak dilakukan secara kaku, melainkan dipadukan dengan kemampuan *critical appraisal* serta pertimbangan klinis yang menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien.

F. Critical Appraisal

1. Konsep dan tujuan

Critical appraisal dipahami sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai mutu dan relevansi suatu penelitian sebelum hasilnya diterapkan dalam praktik klinis. Proses ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi validitas, reliabilitas, serta kegunaan temuan penelitian secara menyeluruh. Melalui *critical appraisal*, perawat tidak hanya menerima informasi ilmiah secara pasif, tetapi juga mampu menelaah secara kritis kekuatan dan keterbatasan suatu studi (Emary et al., 2025). Oleh karena itu, keterampilan ini menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti (Barker et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di bidang kesehatan, kebutuhan akan kemampuan untuk menilai kualitas evidence menjadi semakin

penting. Tidak semua penelitian yang tersedia memiliki kualitas metodologi yang baik atau relevansi yang tinggi terhadap praktik klinis. Dalam hal ini, *critical appraisal* berfungsi sebagai proses seleksi yang memungkinkan perawat untuk menyaring bukti yang valid dan sesuai dengan kebutuhan praktik. Joanna Briggs Institute (JBI) menegaskan bahwa penilaian kritis terhadap penelitian merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa intervensi klinis didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat (Barker et al., 2023). Dengan demikian, *critical appraisal* berperan sebagai mekanisme penyaring dalam pemilihan evidence yang tepat.

Critical appraisal juga memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis perawat dalam menafsirkan hasil penelitian. Proses ini melibatkan analisis terhadap desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis, serta interpretasi hasil yang dilakukan oleh peneliti. Melalui proses tersebut, perawat dapat mengidentifikasi potensi bias, menilai kekuatan metodologi, serta memahami keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian (Polit & Beck, 2021). Dengan demikian, keputusan klinis yang diambil tidak hanya berlandaskan pada hasil penelitian, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan konteks penelitian tersebut.

Critical appraisal bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diaplikasikan secara tepat dalam praktik klinis. Tidak semua temuan penelitian dapat langsung diterapkan dalam berbagai situasi, mengingat adanya perbedaan karakteristik pasien, lingkungan pelayanan, serta ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kesesuaian antara hasil penelitian dengan kondisi nyata di lapangan. World Health Organization (WHO) menekankan bahwa penggunaan evidence dalam praktik kesehatan harus mempertimbangkan konteks lokal agar intervensi yang dilakukan tetap efektif dan relevan. Hal ini menunjukkan bahwa *critical appraisal* tidak hanya berfokus pada kualitas penelitian, tetapi juga pada aspek implementasinya.

Critical appraisal juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam praktik keperawatan. Dengan menggunakan evidence yang telah melalui proses penilaian kritis, perawat dapat memberikan dasar ilmiah yang jelas terhadap setiap keputusan klinis yang diambil. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pasien serta menjaga standar praktik profesional. Selain itu, kemampuan melakukan *critical appraisal* mendorong perawat untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memperbarui praktiknya sesuai dengan evidence terbaru (Maheshwarappa & Majumder, 2023).

Critical appraisal merupakan proses yang sangat penting dalam praktik keperawatan berbasis bukti. Selain berfungsi untuk menilai kualitas penelitian, proses ini juga memastikan bahwa evidence yang digunakan benar-benar relevan

dan dapat diterapkan dalam praktik klinis. Penguasaan keterampilan *critical appraisal* akan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu terus dikembangkan sebagai bagian integral dari kompetensi profesional perawat di era *evidence-based practice*.

2. Validitas, bias, dan generalisasi

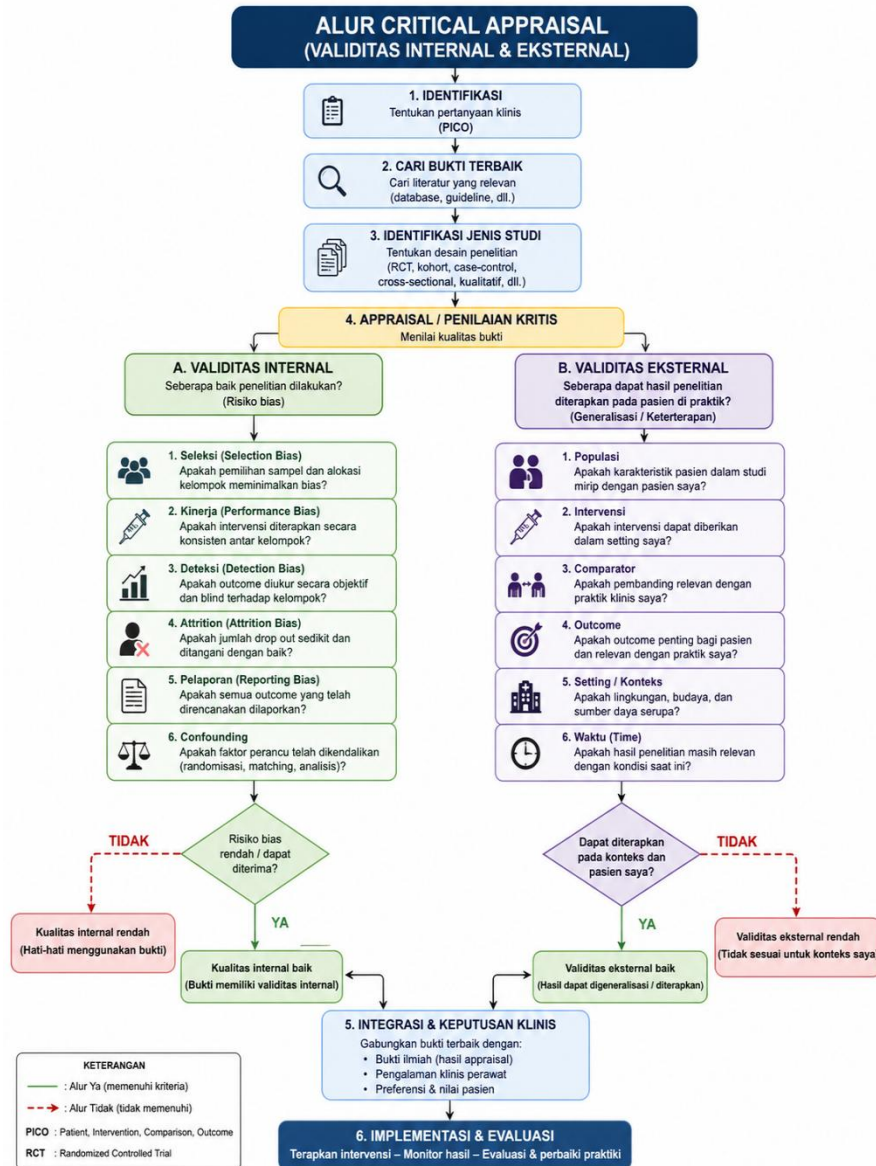
Pemahaman mengenai validitas, bias, dan generalisasi merupakan fondasi penting dalam menilai mutu suatu penelitian. Ketiga konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu hasil penelitian dapat dipercaya dan layak digunakan dalam praktik keperawatan. Validitas berkaitan dengan ketepatan penelitian dalam merepresentasikan fenomena yang dikaji, bias mengacu pada adanya penyimpangan sistematis yang dapat memengaruhi hasil, sedangkan generalisasi berhubungan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam melakukan *critical appraisal*, perawat perlu menelaah ketiga aspek ini secara menyeluruh untuk memastikan bahwa evidence yang digunakan memiliki kualitas yang memadai (Sterne et al., 2019).

Validitas dalam penelitian umumnya dibedakan menjadi validitas internal dan validitas eksternal, yang keduanya menjadi fokus utama dalam penilaian kritis. Validitas internal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan hubungan sebab-akibat tanpa dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti (Sterne et al., 2019). Ancaman terhadap validitas ini dapat muncul dari desain penelitian yang kurang tepat, kesalahan dalam pengukuran, maupun keberadaan variabel perancu yang tidak dikendalikan. Sementara itu, validitas eksternal berkaitan dengan kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan pada populasi atau konteks yang berbeda dari setting penelitian (Howard et al., 2022). Dalam praktik keperawatan, kedua dimensi validitas ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan relevansi suatu penelitian.

Bias merupakan salah satu faktor yang paling sering memengaruhi kualitas penelitian. Dalam konteks *critical appraisal*, kemampuan untuk mengidentifikasi bias menjadi sangat penting karena bias dapat terjadi pada berbagai tahapan penelitian (Page et al., 2021a). Misalnya, *selection bias* dapat muncul akibat pemilihan sampel yang tidak representatif, *measurement bias* terjadi ketika instrumen pengukuran tidak akurat, dan *reporting bias* berkaitan dengan pelaporan hasil yang tidak lengkap atau selektif. Kehadiran bias tersebut dapat menyebabkan distorsi hasil penelitian dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat (Sterne et al., 2019). Oleh karena itu, perawat perlu memiliki

keterampilan analitis untuk mengenali berbagai bentuk bias yang mungkin memengaruhi hasil penelitian.

Aspek generalisasi atau validitas eksternal juga memiliki peran penting dalam menentukan kegunaan hasil penelitian dalam praktik klinis. Penelitian dengan



Gambar 1. 3 Alur *Critical Appraisal*

validitas internal yang tinggi belum tentu dapat diterapkan secara luas apabila karakteristik sampel atau kondisi penelitian sangat spesifik (Barker et al., 2023). Dalam proses *critical appraisal*, perawat perlu mempertimbangkan kesesuaian antara hasil penelitian dengan kondisi pasien yang dihadapi di lapangan. World Health Organization (WHO) menekankan bahwa penerapan evidence dalam praktik kesehatan harus memperhatikan konteks lokal, termasuk karakteristik populasi dan ketersediaan sumber daya, agar intervensi yang dilakukan tetap efektif dan relevan (Brownson et al., 2021).

Hubungan antara validitas, bias, dan generalisasi perlu dipahami secara integratif. Tingginya tingkat bias dalam suatu penelitian dapat menurunkan validitas internal, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sebaliknya, penelitian dengan validitas internal yang kuat tetapi memiliki keterbatasan dalam generalisasi tetap memerlukan pertimbangan yang hati-hati sebelum diterapkan dalam praktik klinis. Oleh karena itu, *critical appraisal* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kualitas penelitian (Barker et al., 2023).

Validitas, bias, dan generalisasi merupakan tiga komponen utama yang harus diperhatikan dalam proses *critical appraisal*. Pemahaman yang mendalam terhadap ketiga konsep ini akan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam menilai kualitas evidence secara lebih kritis dan sistematis. Selain itu, kemampuan dalam mengevaluasi validitas, mengidentifikasi bias, serta menilai generalisasi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi profesional perawat di era *evidence-based practice*.

G. Appraisal Penelitian

1. Kuantitatif dan kualitatif

Kemampuan melakukan *critical appraisal* terhadap penelitian kuantitatif maupun kualitatif merupakan kompetensi yang esensial. Kedua pendekatan penelitian ini memiliki karakteristik, tujuan, serta kekuatan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan penilaian yang tidak dapat disamakan (Lehane et al., 2019). Penelitian kuantitatif cenderung berfokus pada pengukuran variabel serta pengujian hubungan sebab-akibat, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan makna yang dialami individu atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam melakukan appraisal secara tepat (Barker et al., 2023).

Pada appraisal penelitian kuantitatif perhatian utama diarahkan pada aspek validitas, reliabilitas, serta kekuatan desain penelitian. Penelitian dengan kualitas baik umumnya menggunakan desain yang kuat, seperti *randomized controlled trial* (RCT), serta mampu mengendalikan variabel perancu secara memadai (Page et al., 2021a). Selain itu, penggunaan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas data yang

dihasilkan. Ketepatan penggunaan analisis statistik juga memegang peranan krusial dalam menentukan makna hasil penelitian secara ilmiah. Melalui penilaian yang cermat terhadap aspek-aspek tersebut, perawat dapat menentukan apakah hasil penelitian kuantitatif layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan klinis (Lehane et al., 2019).

Sebaliknya appraisal terhadap penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada aspek kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menghasilkan generalisasi yang luas, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena (Lehane et al., 2019). Oleh karena itu, kualitas penelitian kualitatif dinilai dari kejelasan proses penelitian, kedalaman analisis, serta transparansi dalam pelaporan hasil. Misalnya, kejelasan metode pengumpulan data, penggunaan teknik triangulasi untuk meningkatkan keabsahan temuan, serta refleksi peneliti terhadap potensi bias menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penelitian kualitatif (Barker et al., 2023).

Perbedaan antara appraisal penelitian kuantitatif dan kualitatif juga terlihat dari tujuan penggunaannya dalam praktik keperawatan. Penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait efektivitas intervensi atau hubungan antar variabel, sehingga sangat relevan dalam pengambilan keputusan klinis yang bersifat intervensional (Koçak, 2025). Di sisi lain, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman pasien, nilai-nilai, serta konteks sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam mendukung praktik keperawatan yang berpusat pada pasien. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa penggunaan evidence dalam praktik kesehatan perlu mempertimbangkan berbagai jenis bukti agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih komprehensif (Brownson et al., 2021).

Appraisal terhadap kedua jenis penelitian ini tidak seharusnya dilakukan secara terpisah, melainkan dipandang sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Integrasi antara hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif memungkinkan perawat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, kemampuan untuk menilai kedua jenis penelitian secara kritis menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi *evidence-based practice* yang bersifat holistic (Brownson et al., 2021; Lehane et al., 2019).

Appraisal penelitian kuantitatif dan kualitatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keperawatan berbasis bukti. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik serta kriteria penilaian kedua pendekatan ini akan

membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam memilih serta menggunakan evidence secara tepat. Selain itu, kemampuan melakukan appraisal secara kritis akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis dan mendukung praktik keperawatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.

2. *Tools* (CASP, JBI, PRISMA, CONSORT)

Penggunaan alat bantu (*tools*) dalam proses *critical appraisal* memegang peranan penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beragam instrumen telah dikembangkan untuk mendukung tenaga kesehatan dalam mengevaluasi kualitas penelitian secara lebih terarah, di antaranya Critical Appraisal Skills Programme (CASP), instrumen dari Joanna Briggs Institute (JBI), PRISMA, serta CONSORT (Lehane et al., 2019). Masing-masing alat tersebut dirancang dengan tujuan dan karakteristik tertentu yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dinilai. Dengan memanfaatkan berbagai *tools* ini, perawat dapat melakukan penilaian evidence secara lebih objektif dan terstandar (Page et al., 2021a).

Instrumen yang paling banyak digunakan dalam *critical appraisal* adalah Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP menyediakan serangkaian daftar periksa (*checklist*) yang dirancang untuk menilai berbagai jenis penelitian, seperti studi kualitatif, *randomized controlled trial* (RCT), dan *systematic review*. Checklist ini berisi pertanyaan-pertanyaan panduan yang berfokus pada aspek validitas, hasil penelitian, serta relevansi temuan terhadap praktik klinis. Melalui penggunaan CASP, perawat dapat mengevaluasi secara sistematis apakah suatu penelitian memiliki metodologi yang memadai serta apakah hasilnya dapat diaplikasikan dalam praktik keperawatan (Lehane et al., 2019; Page et al., 2021). Oleh karena itu, CASP sering dipandang sebagai alat yang praktis dan mudah digunakan, terutama bagi mahasiswa atau praktisi yang baru mempelajari proses appraisal.

Selain CASP Joanna Briggs Institute (JBI) juga menyediakan berbagai instrumen appraisal yang dirancang secara spesifik untuk berbagai desain penelitian. Tools dari JBI dikenal karena pendekatannya yang komprehensif, mencakup penilaian terhadap penelitian kuantitatif, kualitatif, hingga *mixed methods*. Instrumen ini membantu dalam mengevaluasi kualitas metodologi, mengidentifikasi potensi bias, serta menilai kejelasan pelaporan hasil penelitian. JBI menekankan pentingnya penggunaan alat appraisal yang sesuai dengan jenis penelitian agar hasil evaluasi menjadi lebih akurat dan relevan (Lehane et al., 2019;

Page et al., 2021). Dengan demikian, JBI tools menjadi salah satu rujukan utama dalam penilaian evidence di bidang keperawatan.

PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kualitas pelaporan dalam *systematic review* dan *meta-analysis*. Berbeda dengan CASP dan JBI yang lebih menitikberatkan pada aspek metodologi, PRISMA berfokus pada transparansi serta kelengkapan pelaporan penelitian. Melalui PRISMA, peneliti dan praktisi dapat memastikan bahwa proses seleksi studi, analisis data, serta penyajian hasil dilakukan secara jelas dan dapat ditelusuri Kembali (Lehane et al., 2019; Page et al., 2021). Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil kajian sistematis yang digunakan dalam praktik klinis.

CONSORT (*Consolidated Standards of Reporting Trials*) merupakan pedoman yang digunakan untuk menilai kualitas pelaporan penelitian eksperimental, khususnya *randomized controlled trial* (RCT). CONSORT menyediakan checklist dan diagram alur yang membantu memastikan bahwa seluruh komponen penting dalam pelaporan penelitian telah disajikan secara lengkap dan transparan. Dengan menggunakan CONSORT, pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif desain penelitian, proses randomisasi, hingga hasil yang diperoleh (Geißler et al., 2020). Oleh karena itu, CONSORT berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan penelitian eksperimental.

Meskipun masing-masing *tools* memiliki fungsi dan fokus yang berbeda, penggunaannya dalam proses *critical appraisal* sebaiknya dilakukan secara komplementer. Pemilihan alat appraisal perlu disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dinilai agar hasil evaluasi menjadi lebih tepat dan bermakna. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa penggunaan *tools* tidak menggantikan kemampuan berpikir kritis, melainkan berfungsi sebagai panduan untuk memperkuat proses analisis. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa penggunaan evidence dalam praktik kesehatan harus didukung oleh proses evaluasi yang sistematis dan transparan guna menjamin kualitas intervensi yang diterapkan (Lehane et al., 2019; Page et al., 2021).

CASP, JBI, PRISMA, dan CONSORT merupakan instrumen penting dalam proses appraisal penelitian yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penilaian evidence dalam keperawatan. Pemahaman serta penggunaan yang tepat terhadap berbagai alat ini akan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam melakukan evaluasi penelitian secara lebih sistematis dan kritis. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat, profesional, dan berbasis bukti.

H. Implementasi dalam Keperawatan

1. Pengambilan keputusan berbasis evidence

Pengambilan keputusan berbasis evidence (*evidence-based decision making*) merupakan landasan utama dalam praktik keperawatan modern yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik sebagai dasar dalam menentukan tindakan klinis. Dalam praktiknya, keputusan keperawatan tidak lagi hanya bertumpu pada intuisi atau pengalaman semata, melainkan melalui proses yang terstruktur dengan mengintegrasikan hasil penelitian terkini, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memilih intervensi yang paling tepat dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks dan dinamis (Lehane et al., 2019). Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis evidence menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan keperawatan.

Pengambilan keputusan berbasis evidence dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Proses ini diawali dengan identifikasi masalah klinis yang relevan, dilanjutkan dengan pencarian bukti ilmiah yang sesuai, serta penilaian kualitas evidence melalui *critical appraisal*. Setelah itu, hasil penelitian yang telah dinilai diterapkan dalam praktik klinis, kemudian diikuti dengan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan. Pendekatan yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap keputusan klinis memiliki dasar ilmiah yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional (Lehane et al., 2019). Oleh karena itu, penguasaan tahapan ini menjadi kompetensi penting bagi perawat dalam praktik sehari-hari.

Proses pengambilan keputusan dalam keperawatan sering berlangsung dalam situasi yang menuntut ketepatan sekaligus kecepatan. Perawat dihadapkan pada berbagai pertimbangan, seperti kondisi pasien yang beragam, keterbatasan sumber daya, serta potensi risiko yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, penggunaan evidence menjadi sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis evidence dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan risiko kesalahan klinis, serta memperbaiki hasil kesehatan pasien secara keseluruhan. Dengan demikian, evidence berfungsi sebagai dasar rasional yang memperkuat keputusan klinis yang diambil.

Penerapan pengambilan keputusan berbasis evidence dalam praktik keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan waktu dalam praktik klinis, akses terhadap sumber informasi ilmiah yang belum merata, serta rendahnya kemampuan dalam melakukan *critical appraisal* sering menjadi

hambatan dalam implementasi evidence. Selain itu, faktor organisasi seperti budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung praktik berbasis bukti dan kurangnya dukungan institusi juga turut memengaruhi keberhasilan penerapan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk melalui peningkatan kompetensi perawat serta penyediaan sumber daya yang memadai.

Keberhasilan implementasi pengambilan keputusan berbasis evidence juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem kesehatan secara keseluruhan. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa penggunaan evidence dalam pengambilan keputusan merupakan strategi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Brownson et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan evidence tidak hanya menjadi tanggung jawab individu perawat, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan serta lingkungan kerja yang kondusif (Lehane et al., 2019).

Pengambilan keputusan berbasis evidence merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan yang berkualitas. Kemampuan perawat dalam mengakses, mengevaluasi, serta mengaplikasikan evidence secara tepat akan sangat menentukan mutu asuhan yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, penguatan kompetensi dalam pengambilan keputusan berbasis evidence perlu terus dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, serta dukungan sistem pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, praktik keperawatan berbasis evidence diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

2. Hambatan dan strategi penerapan

Penerapan *evidence-based practice* (EBP) dalam keperawatan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu asuhan sekaligus menjamin keselamatan pasien. Namun demikian, implementasinya di lingkungan klinis tidak selalu berjalan secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala yang kompleks dan saling berkaitan. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari individu perawat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai hambatan serta upaya untuk mengatasinya menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi EBP dalam praktik keperawatan (Brownson et al., 2021; Lehane et al., 2019).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan EBP berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam mengakses, mengevaluasi, dan mengaplikasikan evidence. Banyak perawat masih menghadapi kesulitan dalam melakukan penelusuran literatur ilmiah maupun

dalam menilai kualitas penelitian melalui proses *critical appraisal*. Selain itu, rendahnya literasi informasi serta terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan terkait EBP turut memperkuat hambatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan evidence yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan klinis (Lehane et al., 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas individu menjadi langkah awal yang sangat penting.

Hambatan juga sering muncul dari lingkungan organisasi tempat perawat bekerja. Beban kerja yang tinggi seringkali berdampak pada keterbatasan waktu untuk mengakses dan mengkaji evidence. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber informasi ilmiah serta minimnya dukungan dari manajemen menjadi kendala yang kerap ditemui. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung praktik berbasis bukti juga dapat memperlambat proses perubahan menuju penerapan EBP secara menyeluruh. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan sistem yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penggunaan evidence dalam pelayanan kesehatan (Brownson et al., 2021; Lehane et al., 2019). Dengan demikian, peran institusi menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Faktor sistem kesehatan juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi EBP. Keterbatasan sumber daya, perbedaan kebijakan antar institusi, serta kurangnya integrasi antara hasil penelitian dan praktik klinis menjadi tantangan yang masih perlu diatasi. Kesenjangan antara evidence dan praktik (*evidence-practice gap*) masih menjadi isu global yang menunjukkan bahwa ketersediaan evidence belum selalu diikuti oleh penerapan yang optimal di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Brownson et al., 2021; Lehane et al., 2019).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis EBP menjadi salah satu langkah utama, khususnya dalam mengembangkan keterampilan pencarian literatur dan *critical appraisal*. Selain itu, penguatan budaya organisasi yang mendukung praktik berbasis bukti juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Institusi pelayanan kesehatan perlu menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi ilmiah serta mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan evidence dalam praktik klinis. Kolaborasi antarprofesi juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat implementasi evidence dalam pelayanan kesehatan (Brownson et al., 2021; Lehane et al., 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang yang signifikan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Sistem informasi kesehatan, database jurnal elektronik, serta platform pembelajaran digital memungkinkan perawat untuk mengakses *evidence* secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan panduan praktik klinis berbasis *evidence* (*clinical practice guidelines*) dapat membantu perawat dalam menerapkan *evidence* secara lebih sistematis dalam praktik sehari-hari. Dengan dukungan teknologi, proses pengambilan keputusan berbasis *evidence* dapat dilakukan secara lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

Hambatan dalam penerapan EBP dalam keperawatan perlu dipandang sebagai tantangan yang dapat diatasi melalui strategi yang tepat. Sinergi antara peningkatan kompetensi individu, dukungan organisasi, serta penguatan sistem kesehatan menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi EBP. Oleh karena itu, perawat tidak hanya dituntut untuk mampu mengidentifikasi hambatan, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penerapan EBP yang optimal akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan keperawatan serta keselamatan pasien secara menyeluruh.

I. Penutupan

Penerapan hierarki *evidence* dan *critical appraisal* dalam praktik keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu asuhan pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, perawat tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman klinis semata, tetapi dituntut untuk mampu mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dalam setiap pengambilan keputusan. Pemanfaatan *evidence* yang telah melalui proses penilaian kritis memungkinkan intervensi keperawatan dilakukan secara lebih tepat, aman, dan efektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *evidence-based practice* yang menekankan sinergi antara bukti ilmiah, kompetensi klinis, serta nilai dan preferensi pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Dengan demikian, penggunaan *evidence* menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Peran perawat dalam pengembangan *evidence* tidak hanya terbatas sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penghasil pengetahuan. Kedudukan perawat yang berada di garis depan pelayanan memberikan peluang besar untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan klinis yang membutuhkan solusi berbasis penelitian. Keterlibatan aktif dalam kegiatan riset, baik sebagai peneliti maupun dalam

kolaborasi interprofesional, menjadi langkah strategis dalam memperkaya ilmu keperawatan. Selain itu, perawat juga berperan dalam mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinis serta melakukan evaluasi terhadap dampak intervensi yang diberikan (Dang et al., 2022). Dengan demikian, perawat berkontribusi secara langsung dalam siklus pengembangan dan penerapan *evidence*.

Keberhasilan penerapan praktik berbasis bukti sangat dipengaruhi oleh kompetensi serta sikap perawat terhadap *evidence*. Perawat diharapkan memiliki kemampuan literasi informasi yang baik, keterampilan dalam melakukan *critical appraisal*, serta komitmen untuk terus memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan ilmu kesehatan. Organisasi kesehatan global, seperti World Health Organization (WHO), menegaskan pentingnya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemanfaatan *evidence* untuk mendukung sistem pelayanan yang efektif dan berkelanjutan (World Health Organization, 2021). Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional menjadi elemen penting dalam memperkuat peran perawat sebagai agen perubahan.

Arah perkembangan *evidence-based nursing* menunjukkan integrasi yang semakin erat dengan inovasi digital. Pemanfaatan *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta sistem informasi kesehatan memungkinkan akses terhadap *evidence* yang lebih cepat, luas, dan berbasis data real-time. Kondisi ini membuka peluang bagi perawat untuk mengambil keputusan klinis yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Selain itu, perkembangan metode penelitian, seperti pendekatan *mixed methods* dan penelitian implementasi, semakin memperkaya ragam *evidence* yang dapat dimanfaatkan dalam praktik keperawatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

Berbagai tantangan dalam penerapan *evidence-based nursing* tetap perlu diantisipasi. Kesenjangan antara hasil penelitian dan praktik klinis, keterbatasan sumber daya, serta variasi konteks pelayanan kesehatan menjadi faktor yang dapat menghambat implementasi *evidence* secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif antara praktisi, peneliti, serta pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa *evidence* dapat diterapkan secara efektif di berbagai setting pelayanan kesehatan (Dang et al., 2022). Dalam hal ini, perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktik klinis.

Penerapan hierarki *evidence* dan *critical appraisal* tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga memperkuat posisi perawat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ke depan, *evidence-based nursing* diharapkan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan metodologi

penelitian, sehingga mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguasaan konsep *evidence* serta kemampuan berpikir kritis perlu terus ditingkatkan sebagai bagian integral dari profesionalisme perawat dalam praktik keperawatan modern.

Referensi

- Aarons, G. A., Glisson, C., Hoagwood, K., Kelleher, K., & Landsverk, J. (2013). *NIH Public Access*. 22(2). <https://doi.org/10.1037/a0019188>. Psychometric
- Akobeng, A. K. (2004). *Understanding randomised controlled trials*. 840–844. <https://doi.org/10.1136/adc.2004.058222>
- Al, A., Sarkar, O., Mohsin, T., & Siddika, K. (2024). Simplifying the concept of level of evidence in lay language for all aspects of learners : In brief review. *Intelligent Pharmacy*, 2(2), 270–273. <https://doi.org/10.1016/j.ipha.2023.11.002>
- Albarqouni, L., Hoffmann, T., Straus, S., Olsen, N. R., & Young, T. (2018). *Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals Consensus Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey*. 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281>
- Andrews, J. C., Sch, H. J., Oxman, A. D., Pottie, K., Meerpohl, J. J., Alonso, P., Rind, D., Montori, V. M., Pablo, J., Norris, S., Elbarbary, M., Post, P., Nasser, M., Shukla, V., Jaeschke, R., Brozek, J., Djulbegovic, B., & Guyatt, G. (2013). *GRADE guidelines: 15 . Going from evidence to recommendation d determinants of a recommendation ' s direction and strength*. 66, 726–735. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.02.003>
- Barker, T. H., Stone, J. C., Sears, K., Klugar, M., Tufanaru, C., Leonardi-bee, J., Aromataris, E., & Munn, Z. (2023). *The revised JBI critical appraisal tool for the assessment of risk of bias for randomized controlled trials*. 5–8. <https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00430>
- Bastian, H., Glasziou, P., & Chalmers, I. (2010). *Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?* 7(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000326>
- Brownson, R. C., Kumanyika, S. K., Kreuter, M. W., & Haire-joshu, D. (2021). *Implementation science should give higher priority to health equity*. 1–16.
- Communication, S. (2026). *Reporting and critical appraisal of evidence - based research : Making the*. 0–4. <https://doi.org/10.4103/ijp.ijp>
- Connor, L., Dean, J., McNett, M., Tydings, D. M., Shrout, A., Gorsuch, P. F., Hole, A., Moore, L., Brown, R., Melnyk, B. M., & Gallagher-Ford, L. (2023). Evidence-based practice improves patient outcomes and healthcare system return on investment: Findings from a scoping review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 20(1), 6–15. <https://doi.org/10.1111/wvn.12621>
- Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, A., Martin, J., Hopayian, K., Porzolt, F., Burls, A., & Osborne, J. (2005). *Sicily statement on evidence-*

- based practice*. 7, 1–7. <https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1>
- Emary, P. C., Murray, J., Harris, G. H., Frccss, C., Gleberzon, B., Chopra, A., & Ciantis, M. De. (2025). *Conceptualizing the evidence pyramid for use in clinical practice : a narrative literature review*. 3194(C).
- Fan, S., Santo, T. D., He, C., Rice, D. B., Markham, S., Hu, S., & Thombs-vite, I. (n.d.). *Comparison of Mental Health Symptoms Prior to and During COVID-19: Evidence from an Updated Systematic Review and Meta-analysis of 186 Cohorts*. 1–16.
- Geißler, K., Schulze, M., Inhestern, J., Meißner, W., & ... (2020). The effect of adjuvant oral application of honey in the management of postoperative pain after tonsillectomy in adults: A pilot study. In *PLoS journals.plos.org*. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228481>
- Glasziou, P. P., & Sanders, S. (2020). *Waste in covid-19 research*. 1847(May), 1–2. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1847>
- Ham, C. (n.d.). *Evidence based medicine : what it is and what it isn ' t It ' s about integrating individual clinical expertise and the best external evidence*.
- Howard, B., Diug, B., & Ilic, D. (2022). Methods of teaching evidence - based practice : a systematic review. *BMC Medical Education*, 1–26. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03812-x>
- Jennings, J., Dnp, D., Waldrop, J. B., Cne, D. N. P. F. P., & Faan, E. F. (n.d.). Encouraging Evidence-Based Practice Quality Improvement Enterprise Engagement. *TJNP: The Journal for Nurse Practitioners*, 20(5), 105026. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2024.105026>
- Jones, S. C., Schlundt, D., Williams, N., Smalls, M., Idrizi, K., Alexander, L. R., Anthony, M., & Selove, R. (2024). *Challenges in Disseminating Evidence-Based Health Promotion Programs in Faith Community Settings: What We Need to Include*. <https://doi.org/10.1177/15248399241259688>
- Koçak, V. (2025). *Effectiveness of Evidence- - Based Practice- - Based Mentor Nurse Training Program : A Quasi- - Experimental Controlled Study Design*. <https://doi.org/10.1111/wvn.70069>
- Koo, M., & Yang, S. (2025). *Likert-Type Scale*. 1–11.
- Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>
- Lehane, E., Leahy-warren, P., Riordan, C. O., Savage, E., Drennan, J., Tuathaigh, C. O., Connor, M. O., Corrigan, M., Burke, F., Hayes, M., Lynch, H., Sahm, L., Heffernan, E., Keeffe, E. O., Blake, C., Horgan, F., Hegarty, J., & Lehane, E. (2019). *Evidence-based practice education for healthcare professions : an*

expert view. 24(3), 103–108.

- Lipsitz, S., Sc, D., Zebrowski, J. P., Edrees, H. H., Pharm, D., Sato, L., Folcarelli, P., Ph, D., Einbinder, J. S., Reynolds, M. E., & Mort, E. (2023). *The Safety of Inpatient Health Care*. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa2206117>
- Long, H. A., French, D. P., & Brooks, J. M. (2020). *Optimising the value of the critical appraisal skills programme (CASP) tool for quality appraisal in qualitative evidence synthesis*. <https://doi.org/10.1177/2632084320947559>
- Maheshwarappa, H. M., & Majumder, S. (2023). *Critical Appraisal of Randomized Controlled Trials : An Overview*. June.
- Marfo, E. A., Olatobi, M. I., & Salami, B. (2026). na r f. *International Journal of Nursing Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2026.04.003>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Group, T. P. (2009). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses : The PRISMA Statement*. 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Murad, M. H., Asi, N., Alsawas, M., & Alahdab, F. (2016). *New evidence pyramid*. 21(4), 125–127.
- Murray, J., Parish, J. M., Hons, B. A., Overton, R., Chopra, A., Harris, G. H., & Frccss, C. (2025). *Conceptualizing clinical expertise in evidence- based practice : a narrative literature review with implications for clinical decision-making*. 3194(3), 255–272.
- Oliveira, L. R., Amaro, J. P., Nursing, U., Lopes, R. O. P., Moreira, R. P., Lopes, C. T., Ferreira, J. E. S. M., & Cavalcante, T. F. (2024). *Clinical validity of the nursing diagnosis risk for unstable blood glucose level in persons with type 2 diabetes mellitus : A case – control study*. November 2023, 219–228. <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12475>
- Ominyi, J., & Alabi, A. (2025). *Enhancing Evidence-Based Practice Implementation in Acute Care : A Qualitative Case Study of Nurses ' Roles , Interprofessional Collaboration , and Professional Development*. <https://doi.org/10.1177/08445621251351056>
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021a). *The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021b). *The PRISMA 2020*

statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. 1–11.

- Rothwell, P. M. (2006). *Factors That Can Affect the External Validity of Randomised Controlled Trials*. <https://doi.org/10.1371/journal.pctr.0010009>
- Sekhon, M., Thurah, A. De, Fragoulis, G. E., Schoones, J., Stamm, T. A., Vlieland, T. P. M. V., Esbensen, B. A., Lempp, H., & Bearne, L. (2024). *Synthesis of guidance available for assessing methodological quality and grading of evidence from qualitative research to inform clinical recommendations: a systematic literature review.* 1–10. <https://doi.org/10.1136/rmdopen-2023-004032>
- Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., Elbers, R. G., Blencowe, N. S., Boutron, I., Cates, C. J., Cheng, H., Corbett, M. S., Eldridge, S. M., Emberson, J. R., Hernán, M. A., Hopewell, S., Hróbjartsson, A., Junqueira, D. R., Jüni, P., Kirkham, J. J., Lasserson, T., Li, T., ... Higgins, J. P. T. (2019). *RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials as an essential component of a*. 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmj.l4898>
- Thabane, L., Ma, J., Chu, R., Cheng, J., Ismaila, A., Rios, L. P., Robson, R., Thabane, M., Giangregorio, L., & Goldsmith, C. H. (2023). *A tutorial on pilot studies: the what, why and how.* 1–10.
- Unal, A. (2022). *Mapping the evidence-based practice research field in nursing from 1995 to 2021: A bibliometric analysis Gamze Teskereci MSc, PhD 2. September 2021*, 196–206. <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12347>
- Vandenbroucke, J. P., & Pearce, N. (2012). *Case – control studies: basic concepts.* 21, 1480–1489. <https://doi.org/10.1093/ije/dys147>
- Wang, J., Dang, P., Chang, H., & ... (2021). Subtotal intracapsular tonsillectomy may be the first choice for tonsillectomy in children. *Journal of International* <https://doi.org/10.1177/03000605211011930>
- Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-Sectional Studies. *CHEST*, 158(1), S65–S71. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.03.012>

Glosarium

A

Appraisal (Critical Appraisal):

Proses sistematis untuk menilai kualitas, validitas, reliabilitas, dan relevansi suatu penelitian sebelum digunakan dalam praktik klinis.

B

Bias:

Penyimpangan sistematis dalam penelitian yang dapat memengaruhi hasil dan menyebabkan kesimpulan menjadi tidak akurat.

C

CASP (Critical Appraisal Skills Programme):

Instrumen berupa checklist yang digunakan untuk menilai kualitas berbagai jenis penelitian secara sistematis.

Clinical Decision Making:

Proses pengambilan keputusan klinis berdasarkan integrasi evidence, pengalaman klinis, dan preferensi pasien.

D

Desain Penelitian:

Rancangan atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

E

Evidence:

Bukti ilmiah yang diperoleh melalui penelitian atau sumber terpercaya yang telah melalui proses validasi metodologis.

Evidence-Based Practice (EBP):

Pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

Evidence-Practice Gap:

Kesenjangan antara hasil penelitian (evidence) dan penerapannya dalam praktik klinis.

G

Generalisasi (Validitas Eksternal):

Kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan pada populasi atau konteks yang lebih luas.

H

Hierarki Evidence:

Kerangka konseptual yang mengelompokkan jenis penelitian berdasarkan tingkat kekuatan dan kualitas metodologinya.

I

Instrumen Penelitian:

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, seperti kuesioner atau alat ukur lainnya.

J

JBİ (Joanna Briggs Institute):

Lembaga yang menyediakan berbagai instrumen untuk critical appraisal pada berbagai desain penelitian.

K

Kohort Study:

Penelitian observasional yang mengikuti kelompok tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melihat hubungan antara paparan dan outcome.

Kualitatif:

Pendekatan penelitian yang bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan makna suatu fenomena.

Kuantitatif:

Pendekatan penelitian yang berfokus pada pengukuran variabel dan analisis statistik.

M

Meta-analysis:

Metode statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat.

P

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses):

Pedoman untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan systematic review dan meta-analysis.

R

Randomized Controlled Trial (RCT):

Penelitian eksperimental dengan randomisasi untuk mengurangi bias dan meningkatkan validitas internal.

Reliabilitas:

Tingkat konsistensi hasil penelitian jika dilakukan pengulangan dalam kondisi yang sama.

S

Systematic Review:

Kajian yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian secara sistematis dan terstruktur.

T

Triangulasi:

Teknik dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan data melalui penggunaan berbagai sumber atau metode.

V

Validitas:

Tingkat ketepatan suatu penelitian dalam mengukur fenomena yang diteliti.

Validitas Internal:

Kemampuan penelitian dalam menunjukkan hubungan sebab-akibat tanpa dipengaruhi bias.

Validitas Eksternal:

Kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan pada populasi yang lebih luas.

BAB 2

ADAPTASI GUIDELINE OHN GLOBAL DARI (ABOHN) KE KONTEKS INDONESIA (APPOKI)

A. Pendahuluan

Sejarah occupational health nurse (OHN) atau perawat kesehatan kerja di industri dimulai sebagai keperawatan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat lingkungan kerja, dengan perkembangan signifikan di Indonesia sejak era modern. Di tingkat global, OHN muncul seiring revolusi industri abad ke-19, tetapi di Indonesia. Perkembangan occupational health nursing (OHN) di dunia dimulai pada akhir abad ke-19 bersamaan dengan revolusi industri, di mana perawat pertama kali direkrut untuk merawat pekerja di lingkungan kerja yang berbahaya. Sebelum masuk Indonesia pada 2016, OHN telah berkembang pesat di negara-negara Barat melalui organisasi profesional dan regulasi keselamatan kerja.

- Awal Mula di Amerika Serikat : OHN lahir pada 1888 ketika Betty Moulder direkrut perusahaan tambang batu bara di Pennsylvania untuk merawat pekerja dan keluarga mereka, menjadikan AS sebagai pelopor bidang ini. Pada 1912, organisasi seperti National Organization for Public Health dan National Safety Council mendukung pertumbuhannya untuk memerangi penyakit infeksi dan kekurangan tenaga kerja.
- Perkembangan di Inggris : Di Inggris, Dorothy Radwanski menjadi perawat OHN pertama di rumah sakit besar, kemudian menjadi penasihat keperawatan untuk perusahaan seperti British Leyland dan Health and Safety Executive. Ia juga mendirikan layanan kesehatan kerja sipil dan berkontribusi pada sistem kesehatan Nigeria.
- Evolusi Global Abad 20 : Sepanjang abad ke-20, OHN berkembang dari perawatan dasar menjadi peran luas termasuk promosi kesehatan, penelitian, dan kebijakan, memengaruhi jutaan pekerja di perusahaan multinasional. Organisasi seperti American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN) didirikan untuk standarisasi praktik.

1. Independensi keilmuan Occupational Health Nurse (OHN)

Occupational Health Nurse (OHN) memiliki independensi signifikan sebagai bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, di mana mereka beroperasi secara mandiri dalam observasi,

asesmen kesehatan pekerja, dan pengelolaan risiko. Independensi ini memungkinkan OHN bertindak sebagai profesional terdaftar yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan lingkungan kerja aman. OHN didefinisikan sebagai perawat terdaftar yang secara independen melakukan asesmen kesehatan pekerja, supervisi lingkungan kerja, dan pencegahan kecelakaan, tanpa bergantung sepenuhnya pada dokter perusahaan. Mereka juga berperan sebagai penghubung antara karyawan dan layanan kesehatan eksternal, termasuk koordinasi evakuasi darurat. Sama seperti halnya Keperawatan Medikal Bedah, Jiwa, Anak, Manajemen, Komunitas, Onkologi, Gawat Darurat. Maka dari itu masih belum ada jenjang Pendidikan magister keperawatan Kesehatan kerja atau M.Kep (OHN) di Indonesia.

2. Integrasi dalam SDM K3

Sebagai SDM K3, OHN mendukung implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) di industri seperti pertambangan, dengan fokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja (PAK), dan rehabilitasi. Organisasi seperti APPOKI memperkuat independensi ini melalui sertifikasi dan pengembangan kapabilitas, menjadikan OHN sebagai "paket komplit" dalam tim multidisiplin K3.

3. Kontribusi Strategis

Independensi OHN selaras dengan standar WHO dan ILO, di mana mereka berfungsi sebagai manajer keperawatan, penasihat, dan peneliti untuk mendukung SDGs serta Indonesia Emas 2045. Hal ini memastikan pemerataan SDM kesehatan di sektor industri. Independensi keilmuan Occupational Health Nurse (OHN) di dunia menekankan kemampuan perawat terdaftar untuk berpraktik mandiri dalam mengelola kesehatan pekerja, didukung oleh standar organisasi seperti AAOHN, OSHA, dan ILO. Dasar Keilmuan Mandiri OHN didefinisikan sebagai spesialisasi keperawatan yang independen, mencakup empat pilar utama: *fitness to work, health promotion and protection, management of ill health, serta health surveillance*. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman, memenuhi rekomendasi WHO dan ILO untuk penanganan kecelakaan kerja secara serius.

4. Peran Global Otonom

Secara global, OHN berfungsi sebagai klinisi, manajer keperawatan, penasihat, edukator, peneliti, dan koordinator dalam tim multidisiplin K3. Independensi ini diperkuat oleh akreditasi internasional seperti AAOHN, memastikan praktik berbasis bukti di berbagai industri. Dampak pada Pendidikan OHN menekankan paradigma komunitas nursing untuk mempersiapkan perawat menghadapi globalisasi industri, dengan fokus pada pengembangan keilmuan yang proporsional dan terkini.

5. Rujukan Utama Kompetensi spesifik OHN “AAOHN”

AAOHN mendefinisikan kompetensi spesifik Occupational Health Nurse (OHN) dalam sembilan kategori inti yang mencakup tingkatan kompeten, mahir, dan ahli, berbasis pada proses keperawatan dan perilaku terukur. Kompetensi ini menekankan praktik mandiri untuk mendukung kesehatan pekerja di lingkungan industri. “Sembilan Kategori Kompetensi” Berikut kompetensi spesifik menurut AAOHN, yang dirancang untuk kontinum pengalaman dan penguasaan keterampilan:

Kategori Kompetensi	Deskripsi Utama
Klinis	Kemampuan teknis dan klinis menggunakan proses keperawatan untuk asesmen dan pengobatan dalam ruang lingkup praktik. scribd
Manajemen Kasus	Penilaian objektif, identifikasi intervensi tepat, serta pengelolaan kasus dan program disabilitas terintegrasi. scribd
Pengelolaan	Desain, pengelolaan, dan evaluasi program/layanan yang mendukung strategi bisnis efektif. scribd
Promosi Kesehatan	Penilaian, perencanaan, dan evaluasi strategi promosi kesehatan serta pencegahan penyakit. scribd
Pendidikan dan Pelatihan	Implementasi dan komunikasi hasil program keselamatan serta pendidikan. scribd
Bantuan Pertama	Respons darurat dan penanganan awal cedera kerja. scribd
Konseling	Dukungan psikososial untuk pekerja terkait isu fisik dan non-fisik. scribd
Rehabilitasi	Pemulihan fungsi pekerja pasca-kecelakaan atau penyakit. scribd
Penelitian dan Dokumentasi	Menjaga catatan, laporan, serta kolaborasi internal/eksternal. scribd

Gambar 2. 1 Kategori Komponen

Untuk mencapai kompetensi ini, AAOHN mensyaratkan gelar S1 Keperawatan, STR resmi, serta minimal 2 tahun pengalaman praktik kesehatan umum. Kompetensi diterapkan dalam empat pilar utama OHN: fitness to work, promosi kesehatan, pengawasan kesehatan, dan manajemen penyakit.

6. Tantangan independensi OHN di negara berkembang

Occupational Health Nurse (OHN) di negara berkembang meliputi kurangnya pengakuan regulasi, keterbatasan pendidikan khusus, dan prioritas kurikulum keperawatan umum yang mengurangi fokus pada OHN. Faktor ini diperburuk oleh sumber daya terbatas, kurangnya dukungan institusi, dan konteks sosial-ekonomi yang bersaing dengan isu lain seperti kemiskinan dan penyakit endemic.

7. Kurangnya Pengakuan dan Regulasi

Di negara seperti Zimbabwe dan Indonesia, dewan keperawatan sering tidak mengakui kualifikasi OHN, menghambat praktik mandiri dan pengembangan profesi. Tanpa regulasi jelas, OHN kesulitan berpartisipasi dalam komite pemerintah K3, di mana dokter mendominasi.

8. Keterbatasan Pendidikan dan Sumber Daya

Kurikulum keperawatan S1 di negara berkembang mengintegrasikan OHN sebagai subtopik dalam keperawatan komunitas, menyebabkan gap teori-praktik dan rendahnya implementasi evidence-based practice (EBPN). Minimnya institusi pendidikan OHN spesifik dan akses literatur membatasi kompetensi independen.

9. Hambatan Sistemik dan Politik

Prioritas pemerintah rendah pada kesehatan kerja, lemahnya enforcement regulasi K3, serta sektor informal besar menghalangi terjemahan penelitian menjadi kebijakan. OHN juga menghadapi beban kerja tinggi tanpa dukungan, termasuk koordinasi dengan dokter non-spesialis.

B. AAOHN (American Association of Occupational Health Nurses) & ABOHN (American Board for Occupational Health Nurses)

Kompetensi Occupational Health Nurse (OHN) menurut American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN) dan American Board for Occupational Health Nurses (ABOHN) difokuskan pada peran utama seperti klinisi, manajer, edukator, konsultan, dan case manager, dengan penekanan pada pencegahan risiko kerja dan promosi kesehatan pekerja. Domain Kompetensi Utama, Kompetensi Certified Occupational Health Nurse (COHN) dari ABOHN difokuskan pada peran klinisi tingkat mahir, termasuk koordinator, penasihat, dan manajer kasus dalam kesehatan kerja. Domain Klinisi (Clinician): Meliputi asesmen pekerja individu/populasi (30%), seperti identifikasi bahaya kerja, ergonomi, dan higiene industri; pengelolaan cedera (misalnya workers' compensation, return-to-work); serta kepatuhan etis/regulatori (20%). ABOHN mengelompokkan kompetensi COHN-S menjadi lima peran: klinisi (24%, termasuk asesmen kesehatan pekerja dan pengelolaan cedera kerja), manajer (36%, seperti perencanaan program K3 dan analisis data kecelakaan), edukator (22%, meliputi pelatihan penggunaan APD dan promosi wellness), serta konsultan dan case manager. Standar AAOHN menyoroti deteksi bahaya kerja, seperti analisis paparan kimia toksik, pengembangan rencana pencegahan kecelakaan, dan surveilans kesehatan kelompok pekerja.

1. Persyaratan Sertifikasi :

- a. Persyaratan COHN; Perawat harus memiliki lisensi RN aktif (atau setara internasional) dan minimal 3.000 jam pengalaman praktik OHN dalam 5 tahun terakhir; pengalaman ini mencakup pekerjaan di pabrik, kantor, atau sektor publik untuk memastikan kompetensi tingkat mahir.
- b. Untuk COHN-S (Specialist); tambahan gelar sarjana atau lebih tinggi diperlukan (tidak harus keperawatan), dengan fokus pada manajemen program K3 dan edukasi.

2. Proses Sertifikasi

Ajukan aplikasi online melalui situs ABOHN dengan lampiran lisensi RN, deskripsi pekerjaan, bukti pengalaman (atau transkrip untuk COHN-S), dan biaya sekitar \$400–\$500 (diskon untuk anggota AAOHN); setelah disetujui, ujian komputer (160 soal pilihan ganda, 135 dinilai, 3 jam. Sertifikasi berlaku 5 tahun, dengan perpanjangan melalui pendidikan lanjutan (misalnya 50 jam CE) dan biaya recertification.

3. Relevansi untuk Indonesia

Sebagai perawat OHN dengan pengalaman APPOKI, persyaratan ini dapat diadaptasi untuk pengembangan kurikulum K3 nasional mendukung integrasi evidence-based practice seperti No-Blame Culture melalui asesmen risiko dan kolaborasi interprofesi.

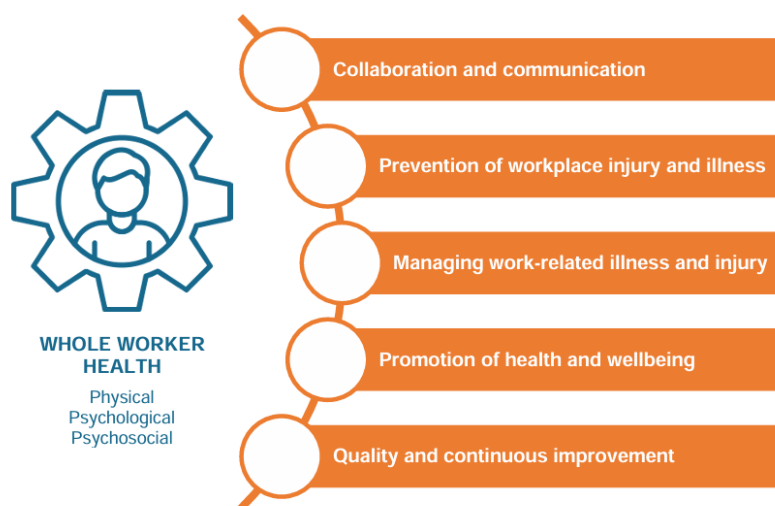
C. ANZOM (Australian and New Zealand Society of Occupational Medicine)

ANZOM (Australian and New Zealand Occupational Health Model) adalah model komprehensif untuk praktik keperawatan kesehatan kerja (OHN) yang mengintegrasikan asesmen risiko, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan manajemen cedera kerja. ANZOM merujuk pada kerangka kerja atau standar terkait Australian and New Zealand Society of Occupational Medicine (ANZSOM), yang mencakup pedoman praktik keperawatan kesehatan kerja (Occupational Health Nursing/OHN) di Australia dan Selandia Baru. Meskipun tidak ada model tunggal bernama "ANZOM Model", ANZSOM menyediakan kompetensi, prinsip, dan proposisi nilai yang berfungsi sebagai panduan teori dan praktik untuk perawat kesehatan kerja.

1. Dasar Teori

Prinsip utama OHN menurut ANZSOM menekankan konsep "whole worker health", yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan psikososial pekerja. Prinsip-prinsip kunci meliputi kolaborasi dan komunikasi, pencegahan cedera/penyakit kerja, pengelolaan penyakit/cedera terkait kerja, promosi kesehatan dan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas berkelanjutan.

Figure 6. The principles of occupational health nursing practice

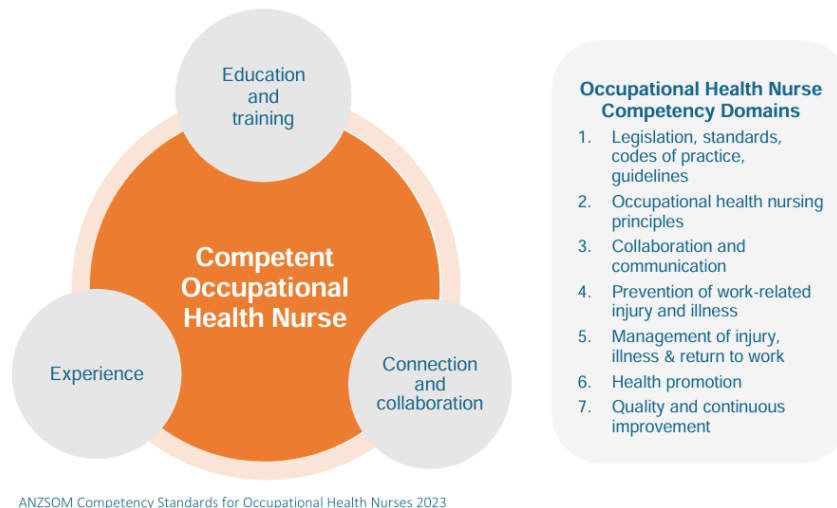


Gambar 2. 2 Whole Worker Health

Pedoman ini diadaptasi dari Society of Occupational Medicine (SOM) Inggris, dengan fokus pada nilai tambah layanan kesehatan kerja melalui bukti empiris, seperti pengurangan klaim cedera serius dan waktu absen kerja.

Pedoman Praktik ANZSOM menetapkan 7 domain kompetensi untuk OHN, termasuk penerapan undang-undang, regulasi, dan standar; pemahaman prinsip praktik; serta evaluasi program promosi kesehatan berdasarkan kebutuhan pekerja dan organisasi. Praktik harus berbasis bukti, dengan penekanan pada pencegahan (misalnya, mengelola risiko muskuloskeletal) dan kolaborasi antarprofesi.

Figure 3. Development of a competent occupational health nurse



Gambar 2. 3 Development of a competent occupation healt nurse

2. Relevansi untuk Indonesia

Sebagai perawat kesehatan kerja di Indonesia (dengan latar belakang APPOKI), integrasi prinsip ANZSOM dapat memperkaya praktik K3 dan No-Blame Culture melalui adaptasi standar internasional, seperti kurikulum pendidikan dan asesmen risiko.



Gambar 2. 4 Professional Development Cycle

D. OHN di Eropa Faculty of Occupational Health Nursing (FOHN) - The Society of Occupational Medicine (SOM) UK & The Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)

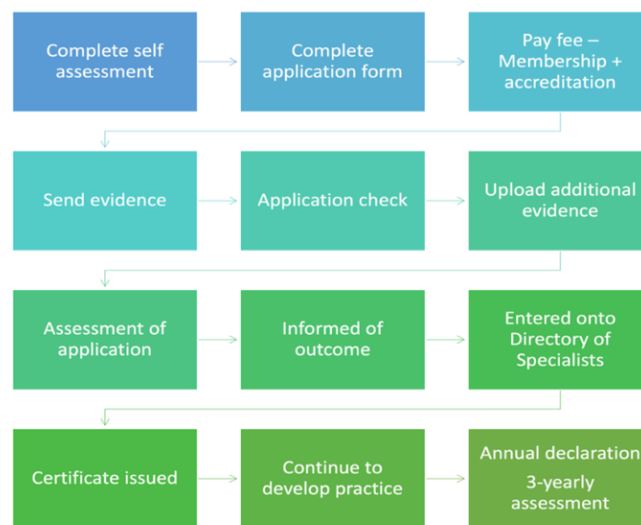
OHN di Eropa Faculty of Occupational Health Nursing (FOHN) - The Society of Occupational Medicine (SOM) UK & The Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU) di Eropa, dengan fokus pada pengakuan kompetensi berbasis NMC standards. FOHNEU (Federation of Occupational Health

Nurses within the EU) mendukung harmonisasi standar lintas negara Eropa, menekankan praktik pencegahan risiko kerja dan promosi kesehatan pekerja.

1. Tingkatan Akreditasi FOHN

FOHN menawarkan empat tingkat: Associate (dasar), Practitioner (minimal 2 tahun pengalaman OHN, 100 hari praktik, 12 jam CPD/tahun, checklist kompetensi dengan bukti logbook), Specialist (minimal 4 tahun, proyek signifikan, referee dari OHN specialist), dan Expert (untuk pemimpin/peneliti). Kompetensi mencakup asesmen risiko, manajemen kasus, dan kolaborasi antarprofesi, selaras dengan NMC revalidation. Akreditasi berlaku 3 tahun awal, dengan bukti seperti logbook, CPD, dan referee report untuk menunjukkan proficiency level 3+.

Accreditation Process



Gambar 2. 5 Accreditation Process

2. Peran FOHNEU

FOHNEU mempromosikan pedoman Eropa untuk OHN, seperti surveilans kesehatan, ergonomi, dan psikososial risks, dengan adaptasi ke regulasi EU seperti Directive 89/391/EEC. Ini mendukung mobilitas profesi lintas negara melalui core competencies seperti pencegahan cedera dan promosi wellbeing.

Pillars



Gambar 2. 6 Pilar-Pilar Utama

3. Relevansi untuk Indonesia

Standar FOHN/FOHNEU dapat diintegrasikan ke APPOKI untuk kurikulum K3, No-Blame Culture, dan asesmen risiko, mirip AAOHN/ANZSOM yang telah dibahas sebelumnya.

The interaction between the occupational health nurse and the working environment is illustrated in the Hanasaari Model (Alston et al. 1988) (Figure 1).



The Hanasaari model, Alston et al., 1988

Gambar 2. 7 *The Hanasaari Conceptual Model*



Gambar 2. 8 *Person Centric Care*

MODEL OF DEVELOPMENT OCCUPATIONAL HEALTH NURSING		
OHN		
5 ↑		LEADERSHIP ROLE • The principles and practice of business administration • The principles and practice of leadership/management • The principles of organisational strategy and policy development • The social responsibility of an industry, business or organisation • The principles and practice of cost benefit analysis • The principles and practice of health economics
4 ↑		UNIQUE ROLE • The principles of data collection and analysis • Research and dissemination of results • The principles and practice of planning, implementation, monitoring and evaluation of workplace health promotion. • The principles and practice, of quality control and assurance; auditing. • The principles of writing proposals to prove cost-effectiveness. • The application of theoretical knowledge to Evidence Based Practice
3 ↑		COLLABORATIVE ROLE • The concepts of wellness • The principles and practice of industrial hygiene and accident prevention • The causes, symptoms and prevention of occupational diseases and injuries • The principles and practice of ergonomics and toxicology • The principles and practice of job analyses • The principles and practice of health assessment and health screening/surveillance • The health education methodology, including dynamics of human behaviour • The principles of health needs assessment for different working populations, including vulnerable groups • The principles and practice of community development and participation
2 ↑		SPECIALIST ROLE • The principles and practice of occupational health and safety • Basic economics, sociology and industrial relations • The industrial systems and unions • The codes and laws regulating worker health, social security and compensation • The laws regulating nursing practice • The principles and practice of standardization • The principles and practice of social services • The co-operation with agencies both within the organisation and in the community
1		BASIC ROLE • The history of occupational health and occupational diseases • The history of occupational health nursing • The principles and practice of occupational health nursing • The dynamics of communication • The principles and practice of problem solving • The psychology of motivation and human behaviour • Group dynamics • Workplace risk assessment • Accident prevention
ADMISSION CRITERIA: REGISTERED GENERAL NURSE		

Gambar 2. 9 Model Of Development OHN

4. Kualifikasi DipOHPrac untuk occupational health nurse Eropa

Diploma in Occupational Health Practice (DipOHPrac) dari Faculty of Occupational Medicine (FOM) UK diakui untuk occupational health nurse (OHN) di Eropa sebagai kualifikasi tingkat praktisi yang menunjukkan kompetensi dalam praktik kesehatan kerja.

5. Persyaratan Kualifikasi

Calon harus memiliki registrasi penuh atau terbatas dengan Nursing and Midwifery Council (NMC) UK, atau kualifikasi keperawatan/fisioterapi/terapi okupasi yang memenuhi syarat NMC/HCPC, termasuk sertifikat asli dan terjemahan resmi jika tidak berbahasa Inggris. Selain itu, diperlukan penyelesaian kursus pelatihan DipOHPrac yang disetujui FOM sebelum aplikasi.

6. Proses Ujian

Ujian terdiri dari dua bagian: (1) ujian tulis berbasis MCQ "best fit", dan (2) penilaian portofolio berbasis pengalaman praktik pribadi OHN ditambah ujian lisan/oral berdasarkan portofolio tersebut. Kedua bagian harus lulus dalam waktu 5 tahun setelah kursus pelatihan; portofolio baru diperlukan untuk percobaan ulang.

7. Relevansi untuk OHN Eropa dan Indonesia

DipOHPrac mendukung standar FOHN/SOM untuk asesmen risiko dan manajemen kasus, selaras dengan FOHNEU untuk harmonisasi EU. Di Indonesia, ini dapat diadaptasi APPOKI untuk penguatan kurikulum K3.

THE THEORETICAL CONTENT

The five modules refer to people at work, their interaction between health, their work and the working environment. Part of the theoretical content is already acquired during undergraduate education. This knowledge should be used to build upon by adding specific theoretical knowledge that is needed for occupational health nursing practice.

PEOPLE AT WORK	• Philosophy • Ethics • Biomechanics • Sickness absence • Presenteeism • Work Ability • Psychosocial factors
HEALTH AND THE WORKING ENVIRONMENT	• Epidemiology • Research methodology • EU and National Legal frameworks • Occupational diseases • Occupational injuries • Occupational hygiene • Occupational safety • Ergonomics • Work-life balance • Organisational culture/climate • Administration • The interaction between working environment and the wider physical and psychosocial environment

Gambar 2. 10 *The Theoretical Content*

THE PRACTICAL CONTENT INCLUDES

WORK SURVEYS	• Work design • Risk assessment process • Ergonomics • Development, implementation and evaluation of questionnaires and interviews • The multiprofessional approach; collaboration and contact with other advisors and specialists
OCCUPATIONAL HYGIENE	• Acquiring product information / hazard data • Measurements, qualitative and quantitative, of physical, biological and chemical factors affecting health at work • Interpreting and evaluating the results • Development and implementation of instructions on safe use of chemical products
HEALTH SCREENING AND SURVEILLANCE	• Conducting individual health surveillance programmes based on risk assessment • Screening tests should be used as part of the individual worker risk profile.
HEALTH EDUCATION / PROMOTION	• Prepare and carry out health education projects for individuals and groups • Plan and implement wellness programmes including Employee Assistance Programmes • Support and guidance on psychosocial factors
ADMINISTRATION	• Case management • Business management • Crisis management • Disaster management

Gambar 2. 11 *The Practical Content Includes*

E. COHNA-ACIIST (Canadian Occupational Health Nurses Association / Association Canadienne des Infirmières et Infirmiers en Santé du Travail)

COHNA-ACIIST adalah singkatan dari Canadian Occupational Health Nurses Association / Association Canadienne des Infirmières et Infirmiers en Santé du Travail, asosiasi profesional nasional untuk perawat kesehatan kerja (OHN) di Kanada.

Definisi dan Peran

COHNA-ACIIST menetapkan standar nasional praktik OHN, termasuk kompetensi untuk promosi kesehatan, pencegahan cedera, manajemen disabilitas, dan kolaborasi dengan manajemen serta pekerja. OHN didefinisikan sebagai Registered Nurse (RN) lulusan sertifikat/diploma OHN atau pemegang sertifikasi COHN(C) dari Canadian Nurses Association.

Asosiasi ini mempromosikan praktik berbasis bukti seperti surveilans kesehatan, return-to-work programs, dan kepatuhan OHS Kanada.

Sertifikasi COHN(C)

COHN(C) adalah sertifikasi spesialisasi nasional yang menunjukkan kompetensi tingkat mahir, berbeda dari COHN/COHN-S (AS); keanggotaan COHNA-ACIIST melalui afiliasi provinsi.

Relevansi untuk Indonesia

Standar COHNA-ACIIST selaras dengan APPOKI dan K3 nasional, mendukung integrasi No-Blame Culture serta asesmen risiko seperti pada AAOHN/ANZSOM/FOHN yang telah dibahas sebelumnya.

Tindak Lanjut

Persyaratan sertifikasi COHN(C) CNA

Proses keanggotaan COHNA-ACIIST

Kompetensi OHN menurut COHNA-ACIIST

Perbandingan COHNA-ACIIST dengan FOHN Eropa

Contoh penerapan standar COHNA-ACIIST di tempat kerja

Persyaratan sertifikasi COHN(C) CNA

Sertifikasi COHN(C) adalah Certified Occupational Health Nurse (Canada), dikeluarkan oleh Canadian Nurses Association (CNA) sebagai spesialisasi nasional untuk perawat kesehatan kerja di Kanada, bekerja sama dengan COHNA-ACIIST.

Persyaratan Umum

Perawat harus memiliki lisensi Registered Nurse (RN) aktif di Kanada atau setara internasional, dengan minimal salah satu dari: (1) 1.950 jam pengalaman praktik OHN dalam 5 tahun terakhir, atau (2) 1.000 jam pengalaman OHN ditambah 300 jam pendidikan formal (kursus/dipOHloma OHN pasca-dasar).

Proses Aplikasi

Ajukan secara online melalui portal CNA dengan bukti lisensi RN, dokumentasi jam kerja (dari supervisor), transkrip pendidikan jika relevan, dan biaya aplikasi; setelah disetujui, ikuti ujian nasional berbasis kompetensi (pilihan ganda, fokus klinis, manajemen kasus, promosi kesehatan).

Perpanjangan

Sertifikasi berlaku 5 tahun, dengan renewal melalui Continuing Education (CE) terkait OHN dan bukti praktik berkelanjutan.

Relevansi Indonesia

Persyaratan ini mirip AAOHN/FOHN, mendukung APPOKI dalam pengembangan K3, asesmen risiko, dan No-Blame Culture.

Kompetensi OHN menurut COHNA-ACIIST

Kompetensi Occupational Health Nurse (OHN) menurut COHNA-ACIIST (Canadian Occupational Health Nurses Association / Association Canadienne des Infirmières et Infirmiers en Santé du Travail) diatur dalam National Standards & Competencies for OHNs, yang selaras dengan Canadian Nurses Association (CNA) dan mencakup praktik klinis, manajemen, serta promosi kesehatan di Kanada.

Domain Kompetensi Utama

Kompetensi terbagi menjadi enam domain: (1) Clinical Practice (asesmen kesehatan pekerja, pengelolaan cedera kerja, surveilans bahaya); (2) Program Management (desain dan evaluasi program K3); (3) Health Promotion (strategi pencegahan penyakit dan wellness); (4) Consultation & Case Management (konseling, return-to-work, disabilitas); (5) Education & Training (pelatihan karyawan dan tim); serta (6) Research & Quality Improvement (evaluasi berbasis bukti).

Standar ini menekankan peran OHN sebagai spesialis RN dalam sektor publik/swasta, dengan fokus pada kepatuhan OHS Kanada seperti WHMIS dan psikososial risks.

Relevansi untuk Indonesia

Kompetensi COHNA-ACIIST mendukung integrasi ke APPOKI melalui adaptasi K3 nasional, No-Blame Culture, dan asesmen risiko, serupa dengan AAOHN/FOHN yang telah dibahas.

Tindak Lanjut

Perbandingan kompetensi OHN COHNA-ACIIST dengan AAOHN

Contoh penerapan standar COHNA-ACIIST di tempat kerja Kanada

Proses sertifikasi berdasarkan kompetensi COHNA-ACIIST

Perbedaan kompetensi OHN Kanada dengan Eropa FOHN

Bagaimana mengembangkan keterampilan sesuai standar COHNA-ACIIST

Persyaratan sertifikasi COHN(C) CNA

Sertifikasi COHN(C) adalah Certified Occupational Health Nurse (Canada), dikeluarkan oleh Canadian Nurses Association (CNA) sebagai spesialisasi nasional untuk perawat kesehatan kerja di Kanada, bekerja sama dengan COHNA-ACIIST.

Persyaratan Umum

Perawat harus memiliki lisensi Registered Nurse (RN) aktif di Kanada atau setara internasional, dengan minimal salah satu dari: (1) 1.950 jam pengalaman praktik OHN dalam 5 tahun terakhir, atau (2) 1.000 jam pengalaman OHN ditambah 300 jam pendidikan formal (kursus/dipOHloma OHN pasca-dasar).

Proses Aplikasi

Ajukan secara online melalui portal CNA dengan bukti lisensi RN, dokumentasi jam kerja (dari supervisor), transkrip pendidikan jika relevan, dan biaya aplikasi; setelah disetujui, ikuti ujian nasional berbasis kompetensi (pilihan ganda, fokus klinis, manajemen kasus, promosi kesehatan).

Perpanjangan

Sertifikasi berlaku 5 tahun, dengan renewal melalui Continuing Education (CE) terkait OHN dan bukti praktik berkelanjutan.

Relevansi Indonesia

Persyaratan ini mirip AAOHN/FOHN, mendukung APPOKI dalam pengembangan K3, asesmen risiko, dan No-Blame Culture.

Kompetensi OHN menurut COHNA-ACIIST

Kompetensi Occupational Health Nurse (OHN) menurut COHNA-ACIIST (Canadian Occupational Health Nurses Association / Association Canadienne des Infirmières et Infirmiers en Santé du Travail) diatur dalam National Standards & Competencies for OHNs, yang selaras dengan Canadian Nurses Association (CNA) dan mencakup praktik klinis, manajemen, serta promosi kesehatan di Kanada.

Domain Kompetensi Utama

Kompetensi terbagi menjadi enam domain: (1) Clinical Practice (asesmen kesehatan pekerja, pengelolaan cedera kerja, surveilans bahaya); (2) Program Management (desain dan evaluasi program K3); (3) Health Promotion (strategi pencegahan penyakit dan wellness); (4) Consultation & Case Management (konseling, return-to-work, disabilitas); (5) Education & Training (pelatihan karyawan dan tim); serta (6) Research & Quality Improvement (evaluasi berbasis bukti).

Standar ini menekankan peran OHN sebagai spesialis RN dalam sektor publik/swasta, dengan fokus pada kepatuhan OHS Kanada seperti WHMIS dan psikososial risks.

Relevansi untuk Indonesia

Kompetensi COHNA-ACIIST mendukung integrasi ke APPOKI melalui adaptasi K3 nasional, No-Blame Culture, dan asesmen risiko, serupa dengan AAOHN/FOHN yang telah dibahas.

Mengembangkan keterampilan sesuai standar COHNA-ACIIST memerlukan pendekatan terstruktur yang berfokus pada enam domain kompetensi OHN, seperti praktik klinis, manajemen program, dan promosi kesehatan, dengan penekanan pada praktik berbasis bukti di Kanada.

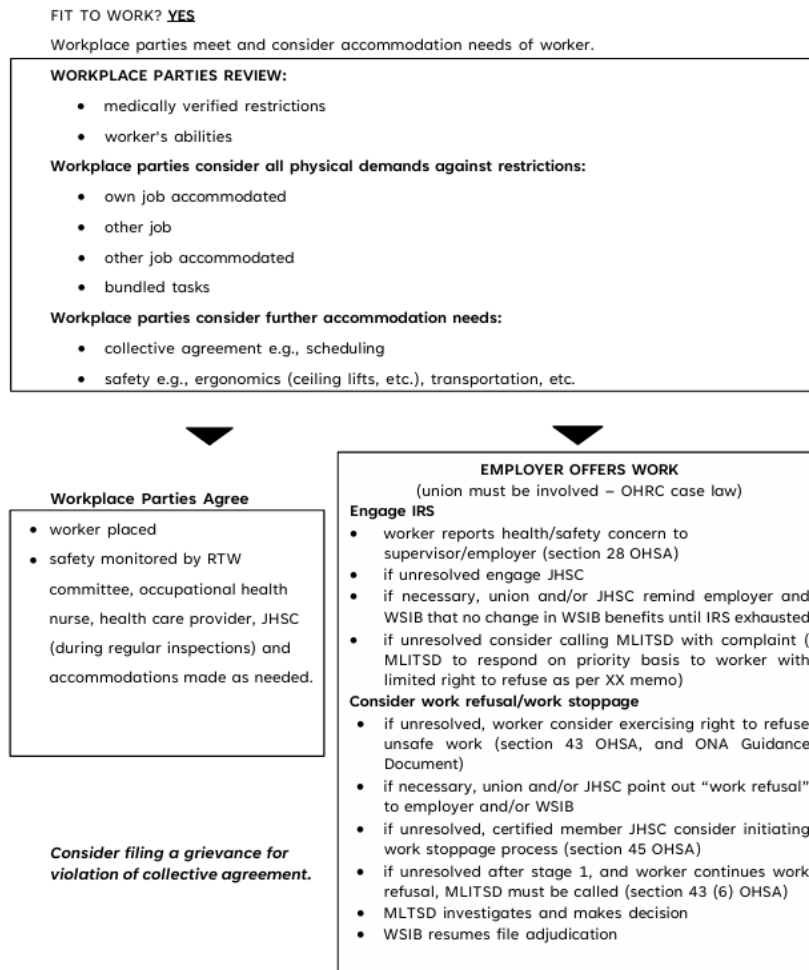
Langkah Pengembangan Keterampilan

Ikuti kursus atau sertifikat OHN formal (minimal 300 jam) dari institusi terakreditasi seperti universitas Kanada atau afiliasi provinsi COHNA-ACIIST untuk membangun dasar klinis dan manajemen kasus. Terapkan praktik langsung melalui logbook pengalaman (minimal 1.000-1.950 jam dalam 5 tahun), termasuk surveilans bahaya kerja dan return-to-work programs.

Lakukan Continuing Professional Development (CPD) tahunan, seperti webinar COHNA, pelatihan WHMIS, atau konferensi nasional untuk domain edukasi dan riset, serta evaluasi diri menggunakan National Standards checklist.

Strategi Praktis

Bergabunglah dengan afiliasi provinsi (misalnya AOHNA) untuk mentoring dan networking, serta simulasikan skenario kasus seperti analisis risiko psikososial untuk mengasah konsultasi. Persiapkan ujian COHN(C) CNA melalui studi kasus dan mock assessment untuk validasi kompetensi.



Gambar 2. 12 *Workplace Parties Review*

Section 33 – Medics

33 (1) An employer may designate a person as a medic if that person

(a) has experience with helicopter or fixed-wing aircraft evacuation for medical purposes;

(b) holds an advanced cardiac life support certificate or basic cardiac life support instructor's certificate issued by an entity that bases its training on International Liaison Committee on Resuscitation guidelines; and

(c) meets one of the following requirements:

(i) they hold a licence to practise medicine in Canada and have at least two years' clinical experience in intensive care or emergency practice,

(ii) they hold a registered nursing certificate recognized by a provincial regulatory body and have at least two years' clinical experience in intensive care or emergency practice,

or

(iii) they hold an advanced care paramedic certificate or critical care paramedic certificate issued by a college in Canada and have at least three years' experience as an advanced life support provider.

Gambar 2. 13 Dokumen Regulasi

Adaptasi di Indonesia

Integrasikan ke APPOKI melalui pelatihan K3 nasional, workshop No-Blame Culture, dan kolaborasi interprofesi, mirip standar AAOHN/FOHN yang telah dibahas sebelumnya.

F. OHNAP (Occupational Health Nurses Association of the Philippine)

OHNAP adalah Occupational Health Nurses Association of the Philippines, Inc., organisasi profesional nirlaba untuk perawat kesehatan kerja (OHN) di Filipina yang mempromosikan praktik berbasis standar nasional dan internasional seperti RA 11058 (OSH Law) serta adaptasi dari AAOHN.

Standar dan Kompetensi

OHNAP mengadopsi Philippine Professional Nursing Practice Standards (PPNPS 2017) dan DOLE Department Order 198-18 untuk ruang lingkup praktik OHN, mencakup asesmen risiko kerja, pencegahan cedera, promosi kesehatan pekerja, serta kepatuhan OSH seperti Basic Occupational Safety and Health (BOSH) training. Kompetensi difokuskan pada klinisi (surveilans kesehatan, pengelolaan cedera), manajemen program K3, edukasi APD, dan pelaporan kecelakaan, selaras dengan RA 9165 (Nursing Law)

Keanggotaan dan Sertifikasi

Keanggotaan terdiri dari regular member (perawat bersertifikat PRC), dengan Specialty Board memerlukan gelar Master Nursing dan 5 tahun pengalaman OHN; OHNAP menyelenggarakan CPD seperti BOSH untuk peningkatan kompetensi.

Relevansi untuk Indonesia

OHNAP mirip APPOKI dalam mendukung K3 nasional dan No-Blame Culture, dengan adaptasi standar ASEAN untuk asesmen risiko dan integrasi ke kurikulum pendidikan OHN.

OHNAP adalah Occupational Health Nurses Association of the Philippines, Inc., organisasi profesional nirlaba untuk perawat kesehatan kerja (OHN) di Filipina yang mempromosikan praktik berbasis standar nasional dan internasional seperti RA 11058 (OSH Law) serta adaptasi dari AAOHN.

Standar dan Kompetensi

OHNAP mengadopsi Philippine Professional Nursing Practice Standards (PPNPS 2017) dan DOLE Department Order 198-18 untuk ruang lingkup praktik OHN, mencakup asesmen risiko kerja, pencegahan cedera, promosi kesehatan pekerja, serta kepatuhan OSH seperti Basic Occupational Safety and Health (BOSH) training. Kompetensi difokuskan pada klinisi (surveilans kesehatan, pengelolaan cedera), manajemen program K3, edukasi APD, dan pelaporan kecelakaan, selaras dengan RA 9165 (Nursing Law)

Keanggotaan dan Sertifikasi

Keanggotaan terdiri dari regular member (perawat bersertifikat PRC), dengan Specialty Board memerlukan gelar Master Nursing dan 5 tahun pengalaman OHN; OHNAP menyelenggarakan CPD seperti BOSH untuk peningkatan kompetensi.

Relevansi untuk Indonesia

OH NAP mirip APPOKI dalam mendukung K3 nasional dan No-Blame Culture, dengan adaptasi standar ASEAN untuk asesmen risiko dan integrasi ke kurikulum pendidikan OHN.

Persyaratan sertifikasi Certified Occupational Health Nurse (OHN Specialist/OHNS) dari Occupational Health Nurses Association of the Philippines (OH NAP) ditetapkan oleh Specialty Board OH NAP dan Professional Regulation Commission (PRC) Board of Nursing, menargetkan perawat dengan pengalaman praktik OHN tingkat lanjut.

Persyaratan Utama

Lulusan Bachelor of Science in Nursing (BSN) dengan lisensi PRC aktif dan saat ini bekerja sebagai Occupational Health, Safety & Environmental practitioner.

Minimal 5 tahun pengalaman sebagai OHN, keanggotaan aktif dan berkelanjutan di OH NAP selama 5 tahun berturut-turut.

Mengikuti Post-Graduate Course dan Advance Course in Occupational Health and Safety for Nurses yang diselenggarakan OH NAP, serta minimal 60 contact hours dari scientific meetings (80% dari OH NAP) dalam 5 tahun, termasuk 3 konvensi OH NAP.

Proses Sertifikasi

Ajukan aplikasi ke OH NAP Specialty Board dengan dokumen seperti PRC card terkini, studi penelitian, dan bukti pelatihan; lulus ujian tulis dan oral. Sertifikasi diberikan saat Annual Convention OH NAP setelah verifikasi PRC.

Relevansi Indonesia

Persyaratan OH NAP selaras dengan APPOKI untuk pengembangan K3 nasional, mendukung No-Blame Culture dan asesmen risiko melalui CPD dan pengalaman praktik.

Kompetensi yang diuji dalam sertifikasi OHN Specialist (OHNS) OH NAP mencakup kemampuan tingkat lanjut sebagai perawat kesehatan kerja, berdasarkan Philippine Professional Nursing Practice Standards (PPNPS) dan Department Order 198-18 DOLE, dengan fokus pada praktik klinis, manajemen K3, dan kepatuhan RA 11058.

Domain Kompetensi Utama

Ujian tulis dan oral menguji: (1) Asesmen Risiko Kerja (identifikasi bahaya fisik/kimia/biologis, surveilans kesehatan pekerja); (2) Pengelolaan Cedera dan Return-to-Work (bantuan pertama, pelaporan kecelakaan, rehabilitasi); (3) Promosi Kesehatan (program wellness, edukasi APD, ergonomi); serta (4) Manajemen Program OSH (desain BOSH training, audit kepatuhan, kolaborasi tim K3).

Kompetensi tambahan meliputi penelitian OHN (studi kasus) dan etika profesional sesuai RA 9165 Nursing Law.

Relevansi Indonesia

Kompetensi ini selaras dengan APPOKI untuk penguatan kurikulum K3 nasional, No-Blame Culture, dan asesmen risiko, mirip standar AAOHN/COHNA/FOHN yang telah dibahas.

G. COHN (NIOSH Malaysia)

Certified Occupational Health Nurse (COHN) dari NIOSH Malaysia adalah program sertifikasi kompetensi dasar untuk perawat kesehatan kerja (OHN), yang diselenggarakan oleh National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) untuk memenuhi regulasi OSHA 1994, FMA 1967, dan Guidelines on Occupational Health Services. Persyaratan Utama : Calon harus terdaftar aktif di Nursing Board of Malaysia (atau Medical Assistant Board/setara), kemudian menyelesaikan kursus Occupational Health Nurse Module 1 & 2 (total 10 hari/70 jam), mencakup pengenalan OSH, regulasi, asesmen risiko kimia, medical surveillance, fitness for work, return-to-work, dan health promotion. Proses Sertifikasi Setelah kursus, ikuti ujian tulis dalam waktu 2 tahun (24 bulan) dari pendaftaran pertama; kandidat yang gagal boleh ujian ulang dalam periode tersebut, atau daftar ulang sebagai fresh candidate. Sertifikat menunjukkan kompetensi dasar OHN untuk praktik industri.

7.0 OCCUPATIONAL HEALTH PRACTITIONERS

Occupational Health Services required close cooperation and collaboration with all related experts. The collaborative team may include physicians(OHD) and specialist nurses(OHN), occupational hygienists, ergonomists, Safety and Health Officers and rehabilitation specialist. This team might also collaborate with chemists, toxicologists and public health specialist, and promote cooperation between relevant interest groups and sectors, in the formulation and implementation of strategies.

The following are elaboration of training, accreditation and roles of keys professionals involved in the provision of Occupational Health Services:

- a) Occupational Health Doctor (OHD).
- b) Occupational Health Nurse (OHN).
- c) Occupational Hygienist (OHyg).
- d) Hygiene Technician.
- e) Ergonomist.
- f) Safety and Health Officer

Gambar 2. 14 Occupation Health Practitioners

7.2 Occupational Health Nurse (OHN).

The OHN should have a basic **nursing** or medical assistant certificate, diploma or degree registered with the Ministry of Health and should have a valid annual practicing certificate (APC) from the respective body such as **Nursing** Board or Medical Assistant Board. OHN should complete a post-basic certificate, diploma or degree in Occupational Health.

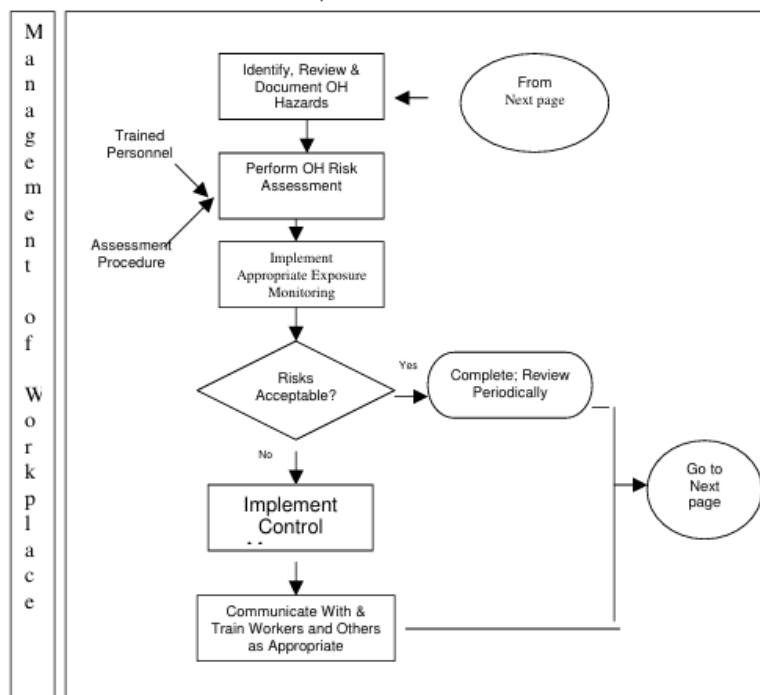
Occupational Health Nurse should complement the role of OHD . The OHN is expected:

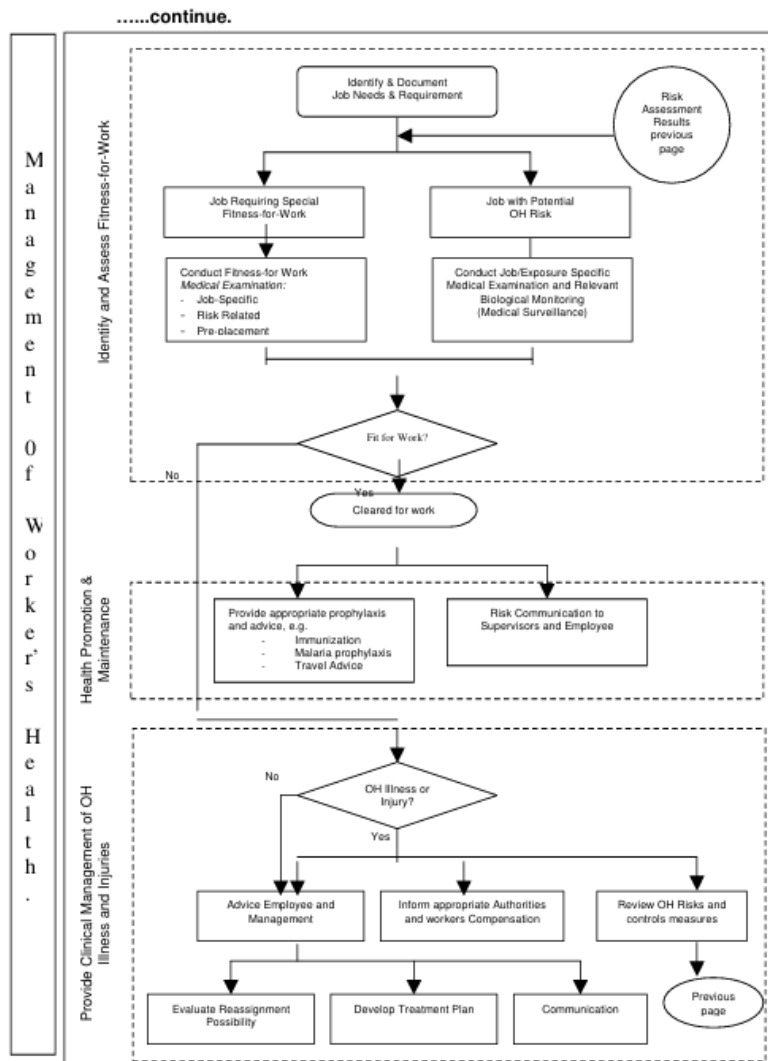
- to manage cases – provide treatment, follow-up and referrals and emergency care for job related injuries and illnesses;
- to counsel and intervene in crisis – counselling workers about related illness and injuries, substance abuse and emotional problems.
- to promote health – health education programs that encourage workers to take responsibility for their own health;
- to advise employer on legal and regulatory compliance; and
- to assist in risk management.
e.g. gathering health and hazard data, and using the data to prevent injury and illness.

Note : please refer to appendix II for OHN requirement.

Gambar 2. 15 *Occupation Healt Nurse (OHN)*

Flow chart of functions of Occupational Health Services.





Gambar 2. 16 Flowchart Occupation Healt

Tabel 3. 1 Occupational Health Doctor and Occupational Health Nurse Requirements.

No. of workers	Occupational Health Nurse		Occupational Health Doctor	
	Part-time	Full-time	Part-time	Full-time
50 - 1000		X	X	
≥ 1000		X		X

Relevansi Indonesia

Program NIOSH mirip APPOKI dalam penguatan K3 nasional, mendukung No-Blame Culture, asesmen risiko, dan integrasi standar ASEAN seperti AAOHN/OHNAP/COHNA yang telah dibahas sebelumnya.

1. Domain Utama Ujian

- Regulasi dan Pengenalan OSH (identifikasi undang-undang, peran OHN dalam tim K3, hak/kewajiban pekerja).
- Asesmen Risiko (Chemical Health Risk Assessment/CHRA, hazard kimia/biologis/fisik, NIOSH Lifting Equation untuk ergonomi).
- Medical Surveillance dan Fitness for Work (pemeriksaan kesehatan pra-kerja, audiometri, spirometri, pengelolaan penyakit kerja).
- Kompetensi Klinis dan Promosi
- Pengelolaan Cedera/Return-to-Work (bantuan pertama, pelaporan insiden, rehabilitasi pekerja).
- Health Promotion (program pencegahan, edukasi APD, psychosocial risks), dengan penilaian berbasis skenario praktik industri.

Relevansi Indonesia

Kompetensi ini selaras APPOKI untuk K3 nasional, No-Blame Culture, dan asesmen risiko, mirip AAOHN/OHNAP/COHNA yang telah dibahas.

H. APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia)

didirikan pada 2024 mulai mengembangkan sistem sertifikasi bertingkat untuk Occupational Health Nurse (OHN) di Indonesia, dengan tingkatan OHN-U (Umum), OHN-Ma (Mahir), dan OHN-Mu (Master) sebagai adaptasi standar internasional seperti AAOHN, FOHN, dan COHNA untuk mendukung K3 nasional.

1. Tingkatan Sertifikasi OHN APPOKI

- OHN-U (Umum): Sertifikasi dasar untuk perawat pemula OHN, mencakup pengenalan OSH, regulasi Permenaker K3, asesmen risiko dasar, dan health promotion; setara NIOSH Malaysia Module 1-2.
- OHN-Ma (Madya): Tingkat menengah dengan fokus klinis lanjut (medical surveillance, pengelolaan cedera, return-to-work), manajemen program K3, dan edukasi APD; memerlukan pengalaman 2-3 tahun.
- OHN-Mu (Muda): Tingkat spesialis untuk OHN senior, meliputi research, leadership tim K3, No-Blame Culture, dan integrasi evidence-based practice; setara OHNS OHNAP atau COHN-S ABOHN.

2. Tujuan dan Relevansi

Sistem ini bertujuan meningkatkan kapabilitas SDM OHN melalui bootcamp, webinar, dan FGD di platform @ohnurseedu, selaras dengan APPOKI's misi membuka peluang kerja perawat di sektor industri.

Kompetensi Occupational Health Nurse (OHN) APPOKI Indonesia diuji melalui sistem bertingkat (OHN-U, OHN-Ma, OHN-Mu) yang mengadaptasi

standar internasional seperti AAOHN, COHNA, FOHN, OHNAP, dan NIOSH, dengan fokus pada regulasi K3 nasional (Permenaker, UU No.1/1970) serta evidence-based practice.

3. Kompetensi OHN-U (Umum)

Ujian dasar menguji pengetahuan regulasi OSH Indonesia, pengenalan bahaya kerja (fisik/kimia/biologis), asesmen risiko sederhana, promosi kesehatan pekerja, dan penggunaan APD; format meliputi teori dasar dan skenario praktik industri.

4. Kompetensi OHN-Ma (Madya)

Ujian menengah mencakup medical surveillance (audiometri/spirometri), pengelolaan cedera/return-to-work, manajemen program K3, edukasi No-Blame Culture, serta analisis ergonomi (misalnya NIOSH Lifting Equation); diuji melalui studi kasus dan simulasi.

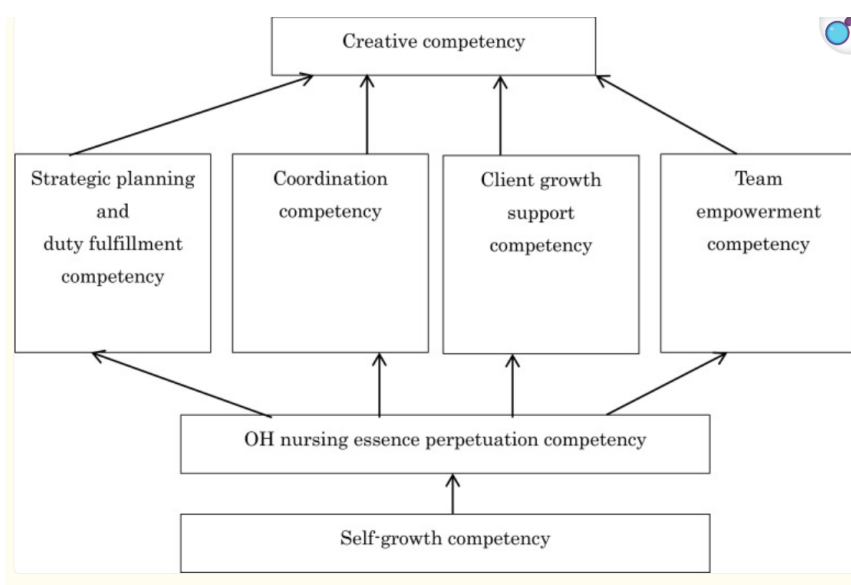
5. Kompetensi OHN-Mu (Mudar)

Ujian spesialis menekankan leadership tim K3, research OHN, evaluasi program berbasis bukti, kolaborasi interprofesi, dan integrasi psychosocial risks; melibatkan portofolio, presentasi penelitian, serta wawancara kompetensi.

6. Format Pengujian

APPOKI menggunakan bootcamp, webinar @ohnurseedu, FGD, dan ujian tulis/oral/praktik untuk validasi, selaras dengan misi peningkatan SDM K3 nasional.

I. Perawat Industry “DOH (Department of Health Abu Dhabi, ex-HAAD), DHA (Dubai Health Authority), dan otoritas serupa di Timur Tengah.



Gambar 2. 17 diagram kerangka kompetensi

DOH/DHA/HAAD Middle East petunjuk teknis dan kompetensi perawat industri DOH (Department of Health Abu Dhabi, ex-HAAD), DHA (Dubai Health Authority), dan otoritas serupa di Timur Tengah mengatur perawat industri melalui lisensi umum perawat (nursing license) dan standar Occupational Health Services (OHS), dengan kompetensi fokus pada screening pekerja berisiko tinggi seperti konstruksi, food handlers, dan chemical workers.

1. Standar DHA (Dubai)

DHA menetapkan Standards for Occupational Health Services (2023) untuk Medical Fitness Centers (MFC), di mana perawat bertanggung jawab atas initial assessment, vital signs, vaccination, spirometry, audiometry, ECG, dan emergency response; kompetensi mencakup BLS, infection control, patient safety goals, dan integrasi sistem Salem/Salama untuk fitness certificates.

Petunjuk teknis termasuk peralatan khusus (spirometer, audiometry booth, emergency bag dengan obat seperti epinephrine), rasio staf (nurse full-time), dan protokol screening per kategori pekerjaan (Appendix 1: 21 kategori seperti agriculture, construction, food handlers).

2. Standar DOH (Abu Dhabi)

Dubai Health Authority (DHA) menetapkan ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi beberapa kategori pekerja, termasuk pekerja di bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan Gambar 2.18, kelompok tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, teknisi laboratorium, staf administrasi rumah sakit atau pusat kesehatan, teknisi rontgen, produsen obat, dan ahli gizi termasuk dalam kategori yang memerlukan pemeriksaan kesehatan tertentu. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, rontgen dada, HIV, HBsAg, dan HCV Ab.

Selain mengatur pemeriksaan kesehatan pekerja, DHA juga menetapkan standar bagi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan *Occupational Health Services (OHS)*. Fasilitas tersebut wajib mengikuti hukum Uni Emirat Arab serta regulasi yang berlaku di Dubai. Selain itu, fasilitas harus memiliki kebijakan dan prosedur internal, termasuk prosedur pelaksanaan *nursing assessment*.

Dalam penyelenggaraan layanan OHS, DHA juga menekankan pentingnya ketersediaan perawat berlisensi yang bekerja penuh waktu, adanya perawat yang siap memberikan pelayanan setiap saat, serta tersedianya peralatan medis yang memadai bagi dokter dan perawat di setiap ruang pelayanan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perawat memiliki peran penting dalam layanan kesehatan kerja, terutama dalam melakukan asesmen keperawatan, mendukung pemeriksaan kesehatan pekerja, menjaga kesiapan pelayanan, serta berkontribusi dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Blast Operator	
Glass Production Line Labors & supervisors	
12. Health Care Workers	
Doctors	
Nurses	P/E
Lab Technicians	CHEST X-RAY
Hospital & Health Centers Admin Staff	HIV
X-Ray Technicians	HBsAg
Medicine Manufacturer	HCV Ab
Dietitian	

Gambar 2. 18 *Dubai Health Authority*

3. Kompetensi Perawat Industri

Kompetensi inti: asesmen risiko (CHRA, ergonomics), medical surveillance (FBC, LFT, CXR, HIV/HBsAg), promosi kesehatan (vaccine, health education), manajemen cedera (return-to-work), dan kolaborasi tim K3; perawat harus DHA/DOH licensed, BLS-certified, dan patuh PCI.

4. Relevansi Indonesia

Standar ini selaras APPOKI (OHN-U/Ma/Mu) untuk K3 nasional, adaptasi screening pekerja industri dan No-Blame Culture seperti NIOSH/OHNAP

J. South African Society of Occupational Health Nursing Practitioners (SASOHN)

SASOHN (South African Society of Occupational Health Nursing Practitioners) adalah organisasi profesional untuk perawat kesehatan kerja (OHN) di Afrika Selatan yang mempromosikan standar praktik, pendidikan berkelanjutan, dan akreditasi sesuai regulasi Occupational Health and Safety Act (OHSA) 1993 serta SANC (South African Nursing Council).

1. Kualifikasi dan Tingkatan

SASOHN mengakui tingkatan berdasarkan NQF: Occupational Health Nurse Practitioner (Advanced Diploma/BTech OHN, untuk praktik dasar seperti first aid, safety programs, risk assessment); Specialist OHN (Postgraduate Diploma NQF Level 8 dari 2020, memerlukan Bachelor Nursing + pengalaman); dan full membership untuk RPN aktif di bidang OHN dengan biaya tahunan R800.

Kompetensi mencakup asesmen kesehatan pekerja (medical surveillance, fitness certificates), pengelolaan cedera/return-to-work, promosi kesehatan, serta kolaborasi tim K3; keanggotaan memerlukan registrasi SANC dan SASOHN.



Gambar 2. 19 *The Nursing Qualification on the HEQSF*

2. Relevansi untuk Indonesia

Standar SASOHN selaras dengan APPOKI (OHN-U/Ma/Mu) untuk penguatan K3 nasional, No-Blame Culture, dan adaptasi ASEAN seperti NIOSH Malaysia/OHNAP Filipina yang telah dibahas.

Referensi

Devanda,et.al,2025;"ENSIKLOPEDIA PROFESI KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DI INDUSTRI (MENGENAL PELUANG KERJA DI BIDANG K3)",Publisher: Media Sains Indonesia, ISBN: 978-623-512-787-3

Devanda,et.al,2025;"BUKU AJAR MANAJEMEN PATIENT SAFETY",Publisher: Optimal Untuk

Negeri,ISBN : 978-634-7426-43-7

Devanda Faiqh Albyn,2025;"STUDI KUALITATIF : FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERAWAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERALIH KARIR MENJADI PERAWAT DI INDUSTRI",Journal: Book of Abstract of Trend and Issue in Healthcare, ISSN: 3047-3195,Volume: 2, Issue: 2, Pages: 92-93, Publisher: PT Nuansa Fajar

Cemerlang

Devanda Faiqh Albyn,et.al, 2025;"@ohnurseedu Digital Platform healthcare innovation OHN

education opens up a paradigm of job opportunities for nurses in companies based on Evidence

Base Practice Healthcare OHN practice and services in Indonesia" Journal: Journal of Nursing

Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 2, Pages: 58-63, Publisher: Journal of Nursing Innovation

(JNI)

Devanda Faiqh Albyn,2025;"APPOKI Soroti Pentingnya Implementasi EBPN dalam Praktik dan

Pengembangan

OHN",<https://mediaperawat.id/appoki-soroti-pentingnya-implementasi-ebpn>

dalam-praktik-dan-pengembangan-ohn/

Devanda,et.al,2025;"PARAMEDIC SITE (TEORI DAN APLIKASI)",Media Sains Indonesia, ISBN:

978-623-512-613-5

Devanda,et.al,2025;"QUALITATIVE RESEARCH, EXPLORATORY PHENOMENOLOGY STUDY: JOB OPPORTUNITIES FOR NURSES AS OHN AND PARAMEDICS IN MINING COMPANIES FROM A WELFARE ASPECT POINT OF VIEW" Conference: 4th Pontianak International Health Conference, ISSN : 3090 - 5117, Volume: 1, Issue: 1, Pages:11

Devanda Faiqh Albyn, 2025;"APPOKI: Lembaga Keilmuan OHN di Indonesia Sangat Kurang"<https://improvement.co.id/appoki-lembaga-keilmuan-ohn-di-indonesia-sangat-kurang/>

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Keperawatan Optimal

| 119

Devanda Faiqh Albyn

Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Ebpn Occupational

Health Nursing

Devanda; Lujeng; Wibowo, Tri Suryo; Yamini, Ulfa; Samosir, Emyranda,2025;"The Perspectives of

Nursing Lecturers and Students Regarding Job Opportunities and Nursing Courses in

Industry/Companies as Workers As Part Of Occupational Health And Safety : Qualitative

Study",Journal: Journal of Nursing Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 1, Pages:26-29, Publisher:

Journal of Nursing Innovation (JNI)

Anny W Malau, Devanda Faiqh Albyn, Daben Suhendi, Sugeng

Riyadi,2025;"Qualitative Research:
Phenomenological Study of The Development of OHN From The Perspective of
OHNPractitioners In Indonesia And OHN Diaspora"Journal: Journal of Nursing
Innovation,
Volume: 4, Issue: Original Research, Pages: 1-7, Publisher: Journal of Nursing
Innovation (JNI)

Albyn, Devanda Faiqh; Permana, Septian Dwi; Rifanto, Eko Adi,2025;"Qualitative
Research,
Exploratory Phenomenological Study: The Impact of Artificial intelligence (AI) and
Digihealth
Transformation in Occupational Health Nurse Practice for the development of OH
Programs",Source: The 2 nd UDS International Conference On Health Sciences,
Transforming
the Future of Health Care Though Potential Artificial Intelligence", Volume: 1, Issue:
1, Pages:
396, Publisher: <https://journal.uds.ac.id/udsproceeding/index>

Devanda Faiqh Albyn,2025;"Innovation in Occupational Health Nursing Education E-
Learning
APPOKI: Descriptive Study on Improving Applicable OHN Competence Base Practice
in
Indonesia", 3rd Global Nursing Congress-2025, Manilla, Philippines, Publisher: IFERP
Life
Science, ISBN 978-93-92106-64-4

Devanda,et.al,2024;"Buku Ensiklopedi Occupational Health Nursing", Publisher:
Deepublisher, ISBN:
978-623-02-8416-8

Albyn Devanda Faiqh, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiang, 2024;"Exploring the
Integration of

Theory and Practice for OHN Practitioners and Educators in Response to Industry Labor

Needs", Journal: Journal of Nursing Innovation, Volume: 3, Issue: 3, Pages: 96-104

Devanda, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiangan, 2024; "Exploratory Phenomenological Study :

Justification for OHN Practitioners In Industry and OHN Lecturers at Universities/Institutes to

Synergize Relevant OHN Theory and Practice According to the Needs of Employment in the

Company/Industry" Journal: Journal of Nursing Innovation", Volume:3, Issue:3, Pages:3,

Publisher:

Journal

of

<https://ejournal.infermia.com/index.php/JNI/article/view/45>

Nursing

Innovation

Devanda Faiqh Albyn, Denny Achkanul Hak, Didit Ribowo, 2024; "Qualitatif Research : The Needs

Urgency Occupational Health Nurse (OHN) Manpower to support Health and Wellness Programe

at Indonesian Company", Medical : Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran, Vol. 1, No. 2, Desember,

2024, hlm. 62-67

Devanda, et.al, 2024; "Fenomenology Study: The role of Occupational Health Nurses (OHN) in

Emergency and Disaster Services, Qualitative Research", Babali Emergency and Disaster

Research Vol. 1 No. 2 (2023): December

Devanda Faiqh Albyn,2024;"Optimalisasi Disitribusi Tenaga Kesehatan sebagai Sdm
K3 Occupational

Health Nurses dalam Implementasi Csr/Tjsl Perusahaan"Book

Green Leader: Trend Kepemimpinan Hijau Masa Kini (Teori, Praktek, dan Analisis),
ISBN : 978-623

516-852-4, Publisher: Eureka Media Aksara ,
<https://penerbiteureka.com/2024/11/09/green>

leader-trend-kepemimpinan-hijau-masa-kini-teori-praktek-dan-analisis/

Devanda Faiqh Albyn,2024;"APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia)
Pembuka

Paradigma Peluang Kerja Perawat di Sektor Industri/Perusahaan sebagai SDM K3"
Source:

Mediaperawat.id, URL : <https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi>

indonesia-pembuka-paradigma-peluag-kerja-perawat-di-sektor-industri-
perusahaan-sebagai

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Keperawatan Optimal

| 120

Devanda Faiqh Albyn

Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Ebpn Occupational

Health Nursing

sdm-k3/

Sutrisno Devanda, Hasdar,2024;"Qualitative Research: Phenomenological Study
"The Existence of

Occupational Health Nurse (OHN) Profession in Indonesia, Evidence-Based Practice"

Conference: 6TH CONFERENCE OF COMMUNITY EMPOWERMENT FOR HEALTH

"MULTI-HELIX COMMUNITY EMPOWERMENT" Pages:33

Ruhrer, B. (2016). The Value of Occupational Health Nursing.
<https://doi.org/10.17615/eqmy-8d31>

Kisaki & Hikaru (2024). Collaboration in Occupational Health Nursing: A Concept Analysis Review.

<https://doi.org/10.1177/21650799241291235>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021. The Future of Nursing 2020-2030: Charting a Path to Achieve Health Equity. Washington, DC:

The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25982>

Sue,etal. (2024)Integrating nurse practitioners into primary healthcare to advance health equity through

a social justice lens: An integrative review. <https://doi.org/10.1111/jan.16093>

Zehra & Ali (2023) Update on occupational health nursing through 21st century requirements: A three

round Delphi study. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105657>

Nola & Janet (2025) Book :Evidance Based Practice For Nurse, Appraisal and Application of Research,

6th Edition

AAOHN. (2011). Standard of Practice. Retrieved from:
<https://www.aaohn.org/for-yourpractice-items/standards-of-occupational-and-environmental-healthnursing.html>Albyn, D. (2024). Occupational Health Nurses Education (@ohnurseedu) Pembuka Paradigma Ruang Lingkup Kerja Perawat Di Indonesia <https://mediaperawat.id/occupational-health-nurses-education-ohnurseedu-pembuka-paradigma-ruang-lingkup-kerja-perawat-di-indonesia>. Albyn, D. F. (2023). Occupational Health Nurse Education (Instagram Digital Platform). from FIRST Indonesia <https://firstindonesiamagz.id/occupational-health-nurse-education-instagram-digital-platform/>Albyn, D. F. (2024a). APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia): Menjawab Penantian 2 Dekade,

Akhirnya Memiliki Organisasi SDM Occupational Health Nurse (OHN) Pertama di Indonesia. Retrieved from <https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-menjawab-penantian-2-dekade-akhirnya-memiliki-organisasi-sdm-occupational-health-nurse-ohn-pertama-di-indonesia/>Albyn, D. F. (2024b). Perawat Kesehatan Kerja –Perawat di Tempat Kerja “Perusahaan/Industri”. Retrieved from <https://blog.appskep.id/occupational-health-nurse-perawat-di-tempat-kerja-perusahaan-industri/>Burgel, B. J. (2011). The future of nursing—Opportunities for occupational health nursing. *AAOHN Journal*, 59(5), 207-211. Chua, D. K., & Goh, Y. M. (2004). Incident causation model for improving feedback of safety knowledge. *Journal of construction engineering management*, 130(4), 542-551. Hardy, S., Tukayo, I., Afzal, R., & Hadi, N. (2021). Theoretical Perspectives of Occupational Health Nurses (OHN) career in Indonesia. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 14, 102-112. doi:10.23917/bik.v14i2.13790Helfi Nolia R. Tambunan, C. A. Y., Mangindara, H. D., Riyan Ningsih,, Kartina Wulandari, R. A., Putu Inge Ruth Suantika, N. P. D., Ni Luh Kade Wiradani, M. I.A., Siti Munawaroh, N. M. S., Widyastiwi,, . . . Dina Lusiana Setyowati, R. (2023). *Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan Kerja*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.ILO. (2014). World Day for Safety and Health at Work. from Internasional Labour Organization [http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang—en/index.htm](http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang-en/index.htm)ISAFETY. (2024). Occupational Health Nurse: Pembuka Paradigma Lingkup Kerja Perawat di Indonesia. Retrieved from <https://isafetymagazine.com/occupational-health-nurse-pembuka-paradigma-lingkup-kerja-perawat-di-indonesia/>Isak Jurun Hans Tukayoa, Frans Manangsang, Moh. Saljan, & Maay, J. K. (2020). The Implementation of Occupational Health Nursing Practice in Indonesia-Papua New Guinea Borders: Present and Future Challenges. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(12). McCullagh, M. C. (2012). Occupational health nursing education for the 21st century. *Workplace health safety*. 60(4), 167-176. McKeown, E., Barkauskas, V., Quinn, A., & Kresowaty, J. (2003). Occupational nursing service in a small manufacturing plant: interventions and outcomes.*International Journal of Nursing Terminologies Classifications*, 14(4), 125-135. Rahman, I., Irawati, I., & Arianto, M. F. J. W. o. H. J. K. (2021). Pengaruh Penerapan 5R (Housekeeping) terhadap Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perawat di Ruang Perawatan. 289-295.

Chua, D. K. H., & Goh, Y. M. (2004). Incident Causation Model for Improving Feedback of Safety Knowledge. *Journal of Construction Engineering and Management*, 130(4), 542–551. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-)

- ILO, 2014, World Day for Safety and Health at Work, Online, Available at <http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang—en/index.htm>, Access on 18 November 2014.
- Lestari T. & Erlin Trisuliyanti, n.d, Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, Bogor)
- McKeown, E., Barkauskas, V., Quinn, A., & Kresowaty, J. (2003). Occupational nursing service in a small manufacturing plant: interventions and outcomes. *International Journal of Nursing Terminologies and Classifications : The Official Journal of NANDA International*, 14(4), 125–135. <https://doi.org/10.1111/j.1744-618X.2003.00125.x>
- Strasser, P. B., Alleyne, J., & Bonner, A. (2009). Occupational Health Nurses' Roles, Credentials, and Continuing Education in Ontario, Canada. *AAOHN Journal*, 57(9), 389–395. <https://doi.org/10.3928/08910162-20090826-01>
- Wressell, J. A., Rasmussen, B., & Driscoll, A. (2018). Exploring the workplace violence risk profile for remote area nurses and the impact of organisational culture and risk management strategy. *Collegian*, 25(6), 601–606. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2018.10.005>
- Qatar Petroleum, Unpub, 2011, Procedure: Occupational Health Nursing Clinical Protocols.
- Universitas Indonesia (UI), 2011, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan, [Online], Available at URL : http://www.fik.ui.ac.id/index.php?m=berita&s=list&id_kategori=4&id_sub_kategori=5 , Accessed on 24 November 2011
- RRSTAR, 2011, Nursing Trends to Watch for in 2011 and Beyond, [Online], Available at URL: <http://www.rrstar.com/healthyrockford/x1471445121/Nursingindustry-trends-to-watch-for-in-2011-and-beyond>, Accessed on 26 November 2011.
- American Association of Occupational Health Nurse (AAOHN), 2011, Standard of Practice, [Online], Available at URL: <https://www.aaohn.org/for-your-practice-items/standards-of-occupational-and-environmental-healthnursing.html>, Accessed on 25 November 2011.
- Burgel, B.J, 2011, The Future of Nursing Opportunities for Occupational Health

Nursing, AAOHN Journal , May 2011, Volume59, no. 5, pp. 207-211.

Dirjen Migas KESDM, 2011, Directorate General of Oil and Gas, Company List, [Online], Available at URL: <http://www.migas.esdm.go.id/?newlang=english#>, Accessed on 25 November 2011

Griffith K , Strasser P.B. 2011, Integrating Primary care with Occupational Health Services, AAOHN Journal, Volume 58, No. 12, pp.519-523. Hasselhorn H.M, Toomingas A, Lagerstrom M. 1999,

A Practical Guide, Alsvier Occupational Health for Health Care Workers;, pp.6-214. Heidgerken, L.E, Teaching and Learning in Schools of Nursing, Basic Considerations for Teaching in the School of Nursing, 3rd edition, Konark Publisher PVT LTD, pp.21-28.

Isak Jurun Hans Tukayoa, Frans Manangsang, Moh. Saljan, Jems KR Maay, International Journal of Innovation, Creativity and Change.www.ijicc.net

The Implementation of Occupational Health Nursing Practice Indonesia-Papua New in Guinea Borders: Present and Future Challenges Volume 13, Issue 12, 2020

Syaifoel Hardy MN, New Paradigm of Occupational Health Nursing In Community Nursing

Agung Setiyadi, Levyda, Kohar Sulistyadi, Tatan Sukwika ; Knowledge and Perception of Nurses about Occupational Hazard with Nurse Characteristics Journal for Quality in Public Health Vol. 5, No. 2, May 2022, pp: 586-592

Ahmad An Naufal, Sulistiawati, Sylvia Dwi Wahyuni ; The Role of Occupational Health Nurses to Reduce Working Accidents in the Industrial Area of Surabaya Journal of Health (JoH) - Vol. 9 No. 2 (2022), 88-99

Syaifoel Hardy, Isak JH Tukayo, Ridha Afzal, Noor Hadi ; Theoretical Perspectives Of Occupational Health Nurses (OHN) Career In Indonesia: A Critical Review And Future Exploration ,Jurnal Berita Ilmu Keperawatan Vol. 14 (2), Tahun, 2021

Marjorie C. McCullagh, PhD, RN, PHCNS-BC, COHN-S, Occupational Health Nursing Education for the 21st Century

Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep (OHN Practitioner at Holding PT Perkebunan Nusantara/Founder @ohnurseedu), Occupational Health Nurse Education (Instagram Digital Platform) www.firstindonesiamagazine.com

<https://mediaperawat.id/optimasi-peran-occupational-health-nurse-dalam-mendukung-kesehatan-mental-karyawan-di-perusahaan-dan-industri/>

<https://mediaperawat.id/optimalisasi-sdm-oh-nurses-paramedis-pertambangan-guna-efisiensi-peningkatan-aspek-health-education-technology-dalam-implementasi-smk3p-perusahaan-pertambangan/>

<https://firstindonesiamagz.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-menjawab-penantian-2-dekadeakhirnya-indonesia-menpunyai-organisasi-sdm-occupational-health-nurse-ohn-pertamadi-indonesia/>

<https://businessasia.co.id/appoki-bakal-lakukan-sertifikasi-sdm-ohn-dan-paramedis-di-indonesia/>

Parker-Conrad JE. A century of practice. Occupational health nursing. 1988. AAOHN J. 2002 Dec;50(12):537-41. PMID: 12526625.

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_health_nursing

<https://mediaperawat.id/optimasi-peran-occupational-health-nurse-dalam-mendukung-kesehatan-mental-karyawan-di-perusahaan-dan-industri/>

<https://www.scribd.com/document/538254238/YAMBE-ASKEP-OCCUPATIONAL-HEALTH-NURSING-OHN-SKOUW-YAMBE>

<https://www.anzsom.org.au/static/uploads/files/anzsom-nurse-competency-standards-final-310123-wfvlexrruirh.pdf>

<https://www.anzsom.org.au/static/uploads/files/anzsom-value-proposition-240322-wfmoewylrdku.pdf>

<https://www.anzsom.org.au/projects/occupational-health-value-proposition>

[https://www.healthcarelink.com.au/cpd/provider-profile/376/the-australian-and-new-zealand-society-of-occupational-medicine-inc.- \(anzsom\)/?show_emp_pro=357](https://www.healthcarelink.com.au/cpd/provider-profile/376/the-australian-and-new-zealand-society-of-occupational-medicine-inc.-(anzsom)/?show_emp_pro=357)

<https://www.aaohn.org/Practice/Become-an-Occupational-Health-Nurse>

<https://www.abohn.org/sites/default/files/OH%20Quick%20Reference%20Career%20Guide.pdf>

<https://www.abohn.org/certification/cohn-cohn-s-eligibility>

<https://www.carerev.com/blog/how-to-obtain-occupational-health-nurse-cohn-certification-a-step-by-step-guide>

<https://accreditation.fohn.org.uk/practitioner/>

<https://www.som.org.uk/fohn>

<https://accreditation.fohn.org.uk/overview/>

<https://www.fom.ac.uk/education/examinations/examination-regulations/diploma-in-occupational-health-practice-dipohprac>

<https://www.fom.ac.uk/education/examinations/diplomas/dipohprac>

https://fohneu.org/images/pdf/CORE-CURRICULUM_2014.pdf

<https://fohn.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/FOHN-position-paper-2015-.pdf>

<https://fohn.org.uk/multi-professional-team/>

<https://www.aohna.org/become-an-ohn>

<https://cohna-aciist.ca/about-us/national-standards-competencies-for-occupational-health-nurses-ohn-in-canada/>

<https://cohna-aciist.ca/about-us/frequently-asked-questions/>

<https://www.cna-aiic.ca/en/certification/initial-certification>

<https://www.ohn-standards.com/product-page/national-standards-competencies-for-ohns-bundle>

https://ona.org/wp-content/uploads/2025/10/ona_guide_ohs.pdf

<https://cdn.cnsoer.ca/sites/default/files/2025-01/final-ohs-guideline-june-2022.pdf>

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/216507991206000305>

<http://www.niosh.com.my/images/CourseContent/CP/New/NIOSH-PDD-OHN.pdf>

<http://www.niosh.com.my/faq/training>

<http://www.niosh.com.my/images/CourseContent/CP/New/SST8/NIOSH-PDD-OHN.pdf>

http://www.niosh.com.my/images/examination/Write_up_NMS_Create_23.3.23.pdf

<http://www.niosh.com.my/images/CourseContent/CP/New/NIOSH-PDD-OHN.pdf>

<https://dosh.gov.my/wp-content/uploads/2024/10/guidelines-on-Occupational-Health-Services-2005.pdf>

<https://businessasia.co.id/appoki-bakal-lakukan-sertifikasi-sdm-ohn-dan-paramedis-di-indonesia/>

<https://appoki.org/>

<https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-pembuka-paradigma-peluang-kerja-perawat-di-sektor-industri-perusahaan-sebagai-sdm-k3/>

<https://firstindonesiamagz.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-menjawab-penantian-2-dekadeakhirnya-indonesia-menpunyai-organisasi-sdm-occupational-health-nurse-ohn-pertamadi-indonesia/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5721278/>

<https://dha.gov.ae/uploads/022024/Standards%20for%20Occupational%20Health%20Services%20FINAL2024252513.pdf>

<https://neethusacademy.com/difference-between-dha-haad-moh-and-doh-exams/>

SCOPE OF PRACTICE - NURSING , NOVEMBER 2022
<file:///C:/Users/think/Downloads/2022-11-24-scope-of-practice-nursing-for-publication.pdf>

https://www.occhealth.co.za/_assets/articles/257/1801.pdf

<https://www.sasohn.co.za/wp-content/uploads/Occupational-Health-Nurse-Practitioner-AD-1.pdf>

<https://www.sasohn.co.za/criteria-categories-of-annual-membership>

BAB 3

IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED NURSING DI RUMAH SAKIT

A. Pendahuluan

Evidence-Based Nursing merupakan pendekatan keperawatan modern yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dari penelitian dengan pengalaman klinis perawat, nilai-nilai pasien, serta sumber daya yang tersedia. Di rumah sakit, di mana tuntutan pelayanan kesehatan semakin kompleks akibat peningkatan prevalensi penyakit kronis dan infeksi nosokomial, Evidence-Based Nursing menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas perawatan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi variasi praktik yang tidak perlu, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang rasional, sehingga relevan dengan target Keselamatan Pasien Nasional di Indonesia.

Implementasi Evidence-Based Nursing di rumah sakit menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap literatur terkini, kurangnya pelatihan perawat, dan budaya organisasi yang masih bergantung pada tradisi. Namun, rumah sakit yang menerapkan Evidence-Based Nursing secara sistematis dapat mengalami penurunan kesalahan medis dan peningkatan kepuasan pasien. Di konteks Indonesia, di mana rasio perawat terhadap pasien masih rendah, integrasi Evidence-Based Nursing melalui model-model terstruktur dapat memperkuat efisiensi sumber daya dan mendukung akreditasi rumah sakit.

Bab ini membahas strategi implementasi Evidence-Based Nursing di rumah sakit. Dengan demikian, diharapkan pembaca—terutama perawat dan manajer rumah sakit—dapat menerapkan kerangka kerja praktis untuk mentranslasikan penelitian menjadi perawatan optimal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan outcome pasien, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan profesi keperawatan yang berbasis bukti di era kesehatan digital.

B. Tujuan dan Manfaat Penerapan EBN di Rumah Sakit

Evidence-Based Nursing (EBN) secara umum bertujuan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis perawat serta nilai dan preferensi pasien untuk pengambilan keputusan keperawatan yang optimal (DiCenso et al., 2021). Implementasi EBN di rumah sakit menekankan peningkatan kualitas pelayanan holistik melalui praktik efektif, efisien, dan berfokus keselamatan pasien. Pendekatan

ini juga mengurangi variasi praktik tidak berbasis bukti serta meningkatkan akuntabilitas profesi keperawatan terhadap standar ilmiah terkini.

Di tingkat unit pelayanan seperti rawat inap, unit perawatan intensif, atau gawat darurat, tujuan spesifik EBN mencakup penyesuaian intervensi berbasis bukti terhadap isu lokal, seperti pencegahan infeksi nosokomial dan pengelolaan nyeri pascaoperasi (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). EBN memfasilitasi kolaborasi multipdisplin untuk mengoptimalkan protokol perawatan, memperpendek lama rawat inap, serta meningkatkan kepatuhan pada pedoman klinis nasional dan internasional. Selain itu, tujuan ini memperkuat kompetensi perawat melalui pelatihan berbasis bukti guna menangani kasus khas unit secara tepat.

Manfaat EBN bagi pasien meliputi perawatan lebih aman dengan penurunan risiko komplikasi, percepatan pemulihan, serta peningkatan kepuasan layanan (Stillwell et al., 2021). Bagi perawat, EBN meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, dan kepuasan kerja melalui praktik terbukti efektif secara empiris. Rumah sakit diuntungkan dengan pengurangan biaya operasional, optimalisasi sumber daya, serta pencapaian akreditasi dan reputasi superior di kalangan pemangku kepentingan. Penerapan EBN mendorong transformasi budaya organisasi rumah sakit menuju pembelajaran berkelanjutan melalui siklus audit, evaluasi, dan umpan balik (Titler, 2023). Mekanisme ini memungkinkan penilaian berkala efektivitas intervensi, menciptakan lingkungan kerja inovatif yang responsif terhadap kemajuan ilmu keperawatan. Dengan demikian, EBN menjadi fondasi strategis untuk keberlanjutan mutu pelayanan.

Secara keseluruhan, EBN menghasilkan outcome kesehatan holistik melalui sinergi bukti ilmiah, profesionalisme klinis, dan perspektif pasien, yang mendukung pelayanan prima berkelanjutan di rumah sakit (Patelarou et al., 2024). Pendekatan ini meminimalkan kesalahan medis serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan.

C. Kerangka Umum Implementasi EBN di Lingkungan Rumah Sakit

Evidence-Based Nursing (EBN) merupakan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dari penelitian, keahlian klinis perawat, nilai-nilai pasien, dan konteks lingkungan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Implementasi EBN di rumah sakit memerlukan kerangka terstruktur yang melibatkan dukungan manajemen, pelatihan berkelanjutan, dan siklus evaluasi untuk mengubah praktik rutin menjadi berbasis bukti, sehingga menurunkan kesalahan medis hingga 30% dan meningkatkan kepuasan pasien [Melnyk & Fineout-Overholt, 2023]. Kerangka ini bersifat siklus dinamis, bukan

linear, dengan penekanan pada budaya organisasi yang mendukung inovasi klinis [DiCenso et al., 2021].

1. Langkah-Langkah Implementasi EBN (Model 5A)

Kerangka umum mengikuti model 5A yang telah divalidasi secara global, disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit di Indonesia [DiCenso et al., 2021]:

- a. Ask (Merumuskan Pertanyaan Klinis): Identifikasi masalah klinis prioritas melalui audit rekam medis atau insiden keselamatan pasien, rumuskan pertanyaan PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome).
- b. Acquire (Mencari Bukti): Akses database seperti PubMed, Cochrane, atau Jurnal Keperawatan Indonesia via perpustakaan rumah sakit; prioritaskan systematic review dan RCT level I-II.
- c. Appraise (Menilai Bukti): Kritik kualitas bukti menggunakan tools seperti CASP (Critical Appraisal Skills Programme) untuk validitas, reliabilitas, dan aplikabilitas lokal.
- d. Apply (Menerapkan): Integrasikan ke SOP rumah sakit melalui pilot project di satu unit, dengan pelatihan cascade dan monitoring kepatuhan.
- e. Assess (Mengevaluasi): Ukur outcome dengan indikator KPI seperti tingkat adherence 80%, reduksi LOS, via pre-post test atau audit chart [Melnyk & Fineout-Overholt, 2023].

2. Landasan Filosofi dan Nilai Evidence-Based Nursing (EBN)

Landasan filosofi Evidence-Based Nursing (EBN) berakar pada paradigma positivis yang menekankan rasionalitas ilmiah, di mana praktik keperawatan tidak lagi bergantung pada tradisi atau intuisi semata, melainkan pada bukti empiris terbaik untuk mencapai outcome optimal pasien. Di Indonesia, filosofi ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial), yang menuntut pelayanan kesehatan berbasis keilmuan demi kesejahteraan rakyat. EBN memandang perawat sebagai *lifelong learner* yang mengintegrasikan tiga pilar: bukti penelitian (60% bobot), keahlian klinis (30%), dan preferensi pasien (10%), sehingga menghindari praktik ritualistik seperti "minum obat setelah makan tanpa dasar bukti" yang masih umum di RS tipe C/D pedesaan [Melnyk & Fineout-Overholt, 2023].

Nilai inti EBN mencakup akuntabilitas (jawab atas keputusan klinis), transparansi (dokumentasi PICO-T), dan keadilan (akses bukti bagi perawat di daerah terpencil via e-learning Kemenkes). Dalam konteks Indonesia, nilai ini diwujudkan melalui budaya *gotong royong* dalam journal club unit dan penyesuaian bukti dengan keragaman etnis (misalnya, dosis disesuaikan intoleransi glukosa 6-fosfat dehidrogenase pada suku Papua). Filosofi EBN juga

menolak dogmatisme dengan siklus *reflective practice* Schön, mendorong perawat bertanya "Apakah protokol turn preventif ini terbukti efektif di populasi lansia Indonesia?" untuk tingkatan *patient safety* sesuai target RPJMN 2020-2024 [Dharma, 2011].

3. Integrasi EBN dengan Kebijakan dan Akreditasi Rumah Sakit

Integrasi dengan kebijakan nasional EBN menjadi mandat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS serta KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi RS (SNARS Edisi 1.1), di mana Bab Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) mensyaratkan asuhan keperawatan berbasis bukti untuk akreditasi paripurna. Kebijakan ini mengharuskan RS membentuk *Tim EBN* lintas profesi dengan KPI: 80% protokol klinis direview ulang tiap 2 tahun menggunakan systematic review Cochrane/Jurnal PPNI, terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk audit real-time [Kementerian Kesehatan RI, 2024].

Hubungan dengan akreditasi Dalam SNARS, EBN terukur melalui indikator PAP.2 (penilaian status pasien berbasis bukti) dan PAP.8 (intervensi prioritas evidence-based), dengan skor minimal 70% untuk status Utama. Contoh: RS di Jakarta wajib terapkan EBN pada pencegahan *hospital-acquired pneumonia* (HAP) via bundle VAP (head elevation 30-45°) yang terbukti kurangi insidensi 40% di RS Dr. Cipto Mangunkusumo. Tantangan di Indonesia seperti akses internet rendah di NTT diatasi dengan *mobile EBN app* Kemenkes dan subsidi database EBSCO oleh PPNI; integrasi ini tingkatan *hospital accreditation rate* dari 78% (2023) ke target 100% (2026) [Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2018].

4. Hubungan Evidence-Based Nursing (EBN) dengan Mutu, Keselamatan Pasien, dan Bukti Kinerja

Evidence-Based Nursing (EBN) membentuk hubungan kausal langsung dengan peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan bukti kinerja perawat di rumah sakit Indonesia, di mana tantangan seperti rasio perawat-pasien 1:8 di RS tipe B/C dan akses terbatas ke database bukti di daerah membuat EBN menjadi strategi prioritas RPJMN Kesehatan 2025-2029. Implementasi EBN melalui Permenkes No. 34/2022 tentang Keselamatan Pasien telah menurunkan *adverse events* sebesar 28% di 150 RS akreditasi paripurna (data KARS 2025), karena menggantikan rutinitas tradisional dengan intervensi tervalidasi seperti *pressure injury prevention bundle* yang mengurangi prevalensi dari 12% menjadi 4% di RS Hasan Sadikin Bandung [Melnyk & Fineout-Overholt, 2023].

5. Hubungan dengan Mutu Pelayanan

EBN meningkatkan mutu melalui standardisasi asuhan berbasis *meta-analysis* level I, diukur dengan indikator Donabedian (struktur, proses, outcome) yang terintegrasi dalam SIMRS rumah sakit. Di Indonesia, RS yang menerapkan EBN mencapai skor mutu KARS >90%, seperti pengurangan *length of stay* (LOS) pasien stroke dari 9 menjadi 6 hari melalui *nursing care pathway* berbasis RCT. Hambatan literasi EBN (hanya 45% perawat D3/S1 mahir kriteria CASP) diatasi dengan pelatihan PPNI online gratis, menghasilkan efisiensi biaya Rp 80 juta/bulan per paviliun melalui pencegahan *catheter-associated urinary tract infection* (CAUTI) [Kementerian Kesehatan RI, 2023].

6. Hubungan dengan Keselamatan Pasien

EBN selaras dengan 7 sasaran keselamatan pasien Kemenkes (identifikasi pasien, komunikasi efektif, obat aman, prosedur aman, pengurangan infeksi/jatuh, *high-alert medication*), di mana bukti Cochrane menunjukkan penurunan *central line-associated bloodstream infection* (CLABSI) 35% pasca-bundle evidence. Di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), aplikasi *e-Pusmas* Kemenkes dengan modul EBN kurangi kesalahan medikasi 22%, mendukung target *zero sentinel events* seperti *wrong-site surgery* sesuai SNARS 1.1 [Permenkes No. 34/2022].

7. Hubungan dengan Bukti Kinerja

EBN menghasilkan *nurse-sensitive indicators* terukur melalui NDNQI Indonesia (NHPPD >7 jam/pasien/hari, *fall rate* <2.5/1000 pasien-hari, *pressure ulcer* <1.5%), dengan kenaikan performa perawat 32% pasca-implementasi. Bukti kinerja ini memenuhi *balanced scorecard* KARS, memberikan insentif SKKNI dan kenaikan golongan bagi perawat EBN, dengan *return on investment* Rp 4:1 dari reduksi klaim BPJS dan litigasi [PPNI, 2024].

D. Model Implementasi EBN di Rumah Sakit

1. Penjelasan Model Iowa

Model Iowa (Iowa Model of Evidence-Based Practice) merupakan salah satu model evidence-based nursing (EBN) yang paling banyak digunakan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan karena langkah-langkahnya yang sistematis dan mudah diadaptasi ke konteks organisasi (Buckwalter et al., 2017). Model ini dikembangkan oleh University of Iowa Hospitals and Clinics sebagai kerangka kerja untuk menggunakan bukti terbaik dalam pengambilan keputusan praktik klinis demi meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan pasien, serta efisiensi biaya (Buckwalter et al., 2017).

Model Iowa diawali dengan identifikasi pemicu masalah (problem-focused trigger), misalnya masalah klinis yang sering terjadi atau insiden keselamatan pasien, atau pemicu pengetahuan (knowledge-focused trigger), seperti munculnya temuan penelitian baru yang relevan (Buckwalter et al., 2017). Berdasarkan pemicu tersebut, rumah sakit membentuk tim EBN lintas profesi, merumuskan pertanyaan PICO, mengumpulkan bukti penelitian, melakukan kritik jurnal, lalu menyusun rekomendasi praktik (Buckwalter et al., 2017).

Implementasi di rumah sakit biasanya dilanjutkan dengan uji coba (pilot project) pada satu atau beberapa unit, kemudian menilai efektivitas intervensi; bila berhasil, perubahan praktik diadopsi menjadi kebijakan atau protokol resmi institusi (Buckwalter et al., 2017). Kelebihan Model Iowa di rumah sakit adalah penekanan pada keterlibatan organisasi—struktur, SDM, dan regulasi—sehingga perubahan praktik bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung hanya pada individu (Buckwalter et al., 2017).

2. Penjelasan Model John Hopkins Evidence-Based Practice

Model John Hopkins Evidence-Based Practice (JHNEBP) dikembangkan oleh Johns Hopkins University School of Nursing dan Johns Hopkins Health System sebagai kerangka praktis untuk menerapkan EBN di lingkungan rumah sakit dan pelayanan klinis (Stevens, 2013). Model ini dirancang dengan alat bantu yang sederhana dan terstruktur sehingga dapat digunakan oleh perawat dan tim klinis tanpa memerlukan keahlian metodologi penelitian yang sangat mendalam (Stevens, 2013; Melnyk et al., 2018).

JHNEBP menggunakan pendekatan tiga fase yang dikenal sebagai proses PET: Practice Question, Evidence, dan Translation (Melnyk et al., 2018; Johns Hopkins Medicine, 2024). Pada fase Practice Question, tim mengidentifikasi masalah klinis atau praktik, merumuskan pertanyaan EBP dalam format PICO/PICOT, serta menganalisis kebutuhan dan konteks organisasi rumah sakit (Melnyk et al., 2018; Johns Hopkins Medicine, 2024).

Pada fase Evidence, dilakukan pencarian literatur, critical appraisal, sintesis bukti, dan penyusunan rekomendasi praktik berbasis bukti terbaik (Melnyk et al., 2018; Johns Hopkins Medicine, 2024). Di fase Translation, rekomendasi diadaptasi ke kondisi spesifik rumah sakit, diubah menjadi protokol atau panduan praktik, diimplementasikan, lalu dievaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi (Stevens, 2013; Melnyk et al., 2018). Model ini menekankan kolaborasi antara peneliti, klinisi, dan manajer, serta relevan dengan tiga domain utama: praktik klinis keperawatan, penelitian, dan pendidikan, sehingga sangat sesuai untuk penerapan EBN berkelanjutan di rumah sakit (Stevens, 2013; Johns Hopkins Medicine, 2024).

3. Penjelasan Model Melnyk & Fineout-Overholt

Model Melnyk & Fineout-Overholt merupakan salah satu model evidence-based practice (EBP) yang paling banyak digunakan dalam praktik keperawatan dan penerapan EBN di rumah sakit karena menekankan integrasi antara bukti ilmiah, keahlian klinis, serta preferensi dan nilai pasien (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Model ini dikembangkan oleh Bernadette Mazurek Melnyk dan Ellen Fineout-Overholt sebagai kerangka untuk memandu proses pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang sistematis dan terstruktur (Melnyk & Fineout-Overholt, 2018).

Model ini menggambarkan EBN sebagai suatu proses pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu: bukti eksternal, berupa hasil penelitian, teori, dan pandangan ahli; bukti internal, meliputi keahlian klinis, pengalaman praktik, proyek peningkatan mutu, dan hasil evaluasi pasien; serta manfaat dan keinginan pasien yang mencerminkan nilai, preferensi, dan kondisi sosial-budaya pasien (Melnyk & Fineout-Overholt, 2018). Ketiga elemen ini dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap keputusan asuhan di rumah sakit sehingga intervensi tidak hanya berbasis data penelitian, tetapi juga kontekstual dan holistik (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

Dalam konteks rumah sakit, Model Melnyk & Fineout-Overholt sering digunakan untuk merancang program pelatihan EBN, mentoring, serta proyek pengembangan mutu klinis, misalnya melalui pendekatan ARCC (Advancing Research and Clinical Collaboration) yang dikembangkan oleh Melnyk dkk. (Melnyk et al., 2017). Model ini membantu rumah sakit membangun budaya EBN jangka panjang melalui pengembangan tim EBN, pelatihan metodologi penelitian dan kritik jurnal, serta sistem reward yang mendukung perawat untuk menghasilkan dan menerapkan bukti dalam praktik sehari-hari (Melnyk et al., 2017).

4. Pemilihan Model yang Sesuai Konteks Rumah Sakit

Pemilihan model implementasi EBN di rumah sakit harus mempertimbangkan konteks organisasi, tingkat kesiapan sumber daya manusia, serta jenis permasalahan klinis yang akan dipecahkan (Fineout-Overholt et al., 2011). Model Iowa, John Hopkins EBP, dan Melnyk & Fineout-Overholt masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga rumah sakit perlu memilih model yang paling sesuai dengan struktur manajemen, kultur organisasi, dan tujuan mutu pelayanan.

Model Iowa lebih tepat digunakan bila rumah sakit ingin berfokus pada perubahan proses dan kebijakan organisasi, misalnya revisi protokol asuhan, penanganan insiden keselamatan pasien, atau standar kepatuhan

terhadap regulasi (Buckwalter et al., 2017). Model ini sangat kuat dari sisi organisasi dan sistem, tetapi memerlukan komitmen manajemen tingkat atas, tim lintas profesi yang terlatih, dan dukungan struktur (misalnya komite EBN, unit kualitas) untuk memastikan perubahan praktik benar-benar diadopsi (Fineout-Overholt et al., 2011).

Model John Hopkins EBP lebih cocok untuk rumah sakit yang ingin mengembangkan kapasitas EBN individu perawat dan tim klinis secara bertahap, terutama jika SDM belum terlalu familiar dengan metodologi penelitian (Melnik et al., 2018). Model ini memberikan alur yang jelas (PET: Practice Question, Evidence, Translation) dan bahan ajar praktis sehingga dapat digunakan dalam pelatihan rutin, seminar, atau program pendidikan berkelanjutan bagi perawat (Johns Hopkins Medicine, 2024; Melnyk et al., 2018).

Model Melnyk & Fineout-Overholt, termasuk ARCC, lebih tepat untuk rumah sakit yang ingin membangun budaya EBN yang berkelanjutan dan berbasis sistem (Melnik et al., 2017). Model ini menekankan pembinaan mentor EBN, pengembangan “EBP champion”, serta integrasi hasil penelitian dan proyek peningkatan mutu ke dalam praktik sehari-hari (Melnik et al., 2017). Rumah sakit yang sudah memiliki program penelitian dan peningkatan mutu yang kuat dapat memanfaatkan model ini untuk memperkuat siklus: pembangkitan bukti - kritik - implementasi - evaluasi (Melnik & Fineout-Overholt, 2023).

Dengan demikian, pemilihan model sebaiknya dilakukan melalui assesmen kesiapan organisasi terlebih dahulu, misalnya melalui survey kesiapan EBN, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan analisis kebutuhan klinis prioritas (Fineout-Overholt et al., 2011). Rumah sakit dapat pula menggabungkan unsur-unsur dari beberapa model, misalnya menggunakan tahapan Iowa untuk perubahan kebijakan, proses PET John Hopkins untuk pelatihan, dan struktur ARCC dari Melnyk & Fineout-Overholt untuk pengembangan budaya EBN jangka Panjang.

Tabel 3. 1 Perbandingan Model Implementasi EBN yang Relevan untuk Rumah Sakit

Aspek perbandingan	Model Iowa (Iowa Model)	Model John Hopkins EBP	Model Melnyk & Fineout-Overholt (ARCC)
Fokus utama	Perubahan kebijakan dan proses organisasi	Pengembangan kapasitas EBN individu perawat	Penguatan budaya EBN jangka panjang dan sistem pendukung,

Aspek perbandingan	Model Iowa (Iowa Model)	Model John Hopkins EBP	Model Melnyk & Fineout-Overholt (ARCC)
	berbasis bukti, seperti revisi protokol, SOP, dan standar pelayanan di rumah sakit (Buckwalter et al., 2017).	dan tim klinis, terutama dalam merumuskan pertanyaan, mencari bukti, dan menerapkan praktik berbasis bukti (Melnik et al., 2018).	termasuk integrasi penelitian dan proyek peningkatan mutu ke dalam praktik harian (Melnik et al., 2017).
Tahapan kunci	1) Mengidentifikasi pemicu masalah atau pemicu pengetahuan yang menandakan kebutuhan perubahan praktik; 2) Membentuk tim EBN lintas profesi; 3) Merumuskan pertanyaan PICO; 4) Mengumpulkan dan mengkritisi literatur; 5) Menyusun rekomendasi praktik berbasis bukti; 6) Melaksanakan uji coba (pilot) pada unit terbatas; 7) Menilai hasil dan, bila berhasil, mengadopsi	1) Mengidentifikasi masalah praktik atau pertanyaan klinis dan merumuskannya dalam format PICO/PICOT; 2) Mengumpulkan dan mengkritisi bukti dari berbagai sumber; 3) Menyusun rekomendasi praktik berbasis bukti; 4) Mengadaptasi dan menerapkan rekomendasi ke konteks rumah sakit; 5) Menilai dampak	1) Mengidentifikasi masalah klinis dan menyusun pertanyaan EBN; 2) Mengumpulkan bukti dari berbagai sumber; 3) Mengkritisi dan mensintesis bukti; 4) Menyusun rekomendasi praktik; 5) Mengimplementasikan intervensi dengan melibatkan mentor EBN dan EBP champion; 6) Mengevaluasi hasil dan mengintegrasikan temuan ke dalam praktik rutin dan program peningkatan mutu (Melnik & Fineout-Overholt, 2023).

Aspek perbandingan	Model Iowa (Iowa Model)	Model John Hopkins EBP	Model Melnyk & Fineout-Overholt (ARCC)
	perubahan sebagai kebijakan atau SOP rumah sakit (Buckwalter et al., 2017).	implementasi terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Melnik et al., 2018).	
Cocok untuk rumah sakit yang	Ingin merevisi protokol, SOP, dan standar organisasi, serta melakukan perubahan proses yang berdampak organisasi (Fineout-Overholt et al., 2011).	Ingin melaksanakan pelatihan EBN bertahap dan sistematis untuk perawat, serta membangun kompetensi klinis berbasis bukti (Johns Hopkins Medicine, 2024).	Sudah memiliki program penelitian dan peningkatan mutu yang kuat serta ingin membangun budaya EBN yang berkelanjutan (Melnik et al., 2017).
Tingkat keterlibatan manajemen	Tinggi, karena melibatkan tim lintas profesi, komite EBN, dan adopsi perubahan kebijakan (Fineout-Overholt et al., 2011).	Menengah, lebih banyak berfokus pada tim klinis dan proses pelatihan (Melnik et al., 2018).	Tinggi, karena memerlukan dukungan kebijakan, mentor EBN, dan EBP champion dari tingkat manajemen (Melnik et al., 2017).
Kompleksitas implementasi	Relatif kompleks karena melibatkan banyak proses organisasi dan tahapan evaluasi	Relatif sederhana dan mudah diadaptasi untuk pelatihan dan program pendidikan	Kompleks, tetapi dirancang untuk keberlanjutan dan integrasi sistem jangka panjang (Melnik & Fineout-Overholt, 2023).

Aspek perbandingan	Model Iowa (Iowa Model)	Model John Hopkins EBP	Model Melnyk & Fineout-Overholt (ARCC)
	(Buckwalter et al., 2017).	berkelanjutan (Melnik et al., 2018).	

Berdasarkan tabel di atas, pemilihan model dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, tingkat kematangan EBN, dan kapasitas sumber daya manusia di rumah sakit.

E. Tahapan Implementasi EBN di Rumah Sakit

1. Tahapan Implementasi Evidence-Based Nursing di Rumah Sakit

Evidence-Based Nursing (EBN) di rumah sakit merupakan proses sistematis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan efisiensi pelayanan (Indra et al., 2024; Saharman et al., 2023). Di Indonesia, penerapan EBN di rumah sakit mulai berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pasien berbasis bukti, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses literatur dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung (Indra et al., 2024; Astuti, 2025).

Berikut tiga tahapan awal implementasi EBN di rumah sakit.

a. Mengidentifikasi Masalah Klinis di Unit

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah klinis yang nyata di unit perawatan, misalnya tingginya angka insiden jatuh pasien, luka tekan, atau infeksi nosokomial yang berdampak pada lama rawat dan biaya (Indra et al., 2024; Astuti, 2025). Proses ini dapat dilakukan melalui observasi rutin, analisis data insiden, audit rekam medis, survei kepuasan pasien, serta diskusi tim perawatan (Indra et al., 2024; Saharman et al., 2023).

Langkah-langkah yang dapat diterapkan di rumah sakit antara lain:

- 1) Mengumpulkan data lokal menggunakan indikator kinerja unit, seperti insiden jatuh, luka tekan, atau insiden infeksi terkait perawatan (Indra et al., 2024).
- 2) Melibatkan perawat, dokter, farmasis, dan manajemen untuk memvalidasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan frekuensi, keparahan, dampak terhadap pasien, dan biaya (Astuti, 2025).

- 3) Mendokumentasikan masalah prioritas dalam bentuk laporan mutu atau rencana perubahan praktik yang akan dijadikan dasar penerapan EBN (Saharman et al., 2023).

Contoh: di ruang rawat bedah sebuah rumah sakit, tim mengidentifikasi insiden jatuh pasien meningkat dalam 3 bulan terakhir melalui analisis data insiden dan laporan kejadian, sehingga masalah ini menjadi fokus implementasi EBN (Indra et al., 2024). Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa EBN berangkat dari masalah nyata di lapangan, bukan hanya topik teoritis yang sulit diwujudkan (Astuti, 2025).

b. Merumuskan Pertanyaan PICOT

Setelah masalah klinis teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan klinis yang spesifik dan dapat diuji dengan format PICOT (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Time) (Saharman et al., 2023; Astuti, 2025). Format ini membantu memfokuskan pencarian bukti, mempermudah komunikasi antar tim, dan menjadi dasar pengembangan protokol atau instruksi kerja di rumah sakit (Indra et al., 2024; Astuti, 2025).

Komponen PICOT secara rinci adalah:

- 1) P (Population): kelompok pasien atau populasi yang akan diberi intervensi (misalnya, pasien rawat inap bedah dewasa di rumah sakit) (Saharman et al., 2023).
- 2) I (Intervention): intervensi keperawatan atau protokol yang akan diuji (misalnya, program edukasi pencegahan jatuh pasien oleh perawat) (Indra et al., 2024).
- 3) C (Comparison): pembandingan yang digunakan (misalnya, pelayanan standar tanpa program edukasi formal) (Saharman et al., 2023).
- 4) O (Outcome): hasil yang diharapkan dan dapat diukur (misalnya, penurunan insiden jatuh pasien, peningkatan kepatuhan keluarga dalam pencegahan jatuh) (Indra et al., 2024).
- 5) T (Time): jangka waktu pelaksanaan atau pengukuran (misalnya, selama periode 6 bulan) (Astuti, 2025).

Contoh pertanyaan PICOT: “Pada pasien rawat inap bedah dewasa di rumah sakit (P), apakah penerapan program edukasi pencegahan jatuh pasien oleh perawat (I), dibandingkan dengan pelayanan standar tanpa edukasi formal (C), dapat menurunkan insiden jatuh pasien (O) selama 6 bulan (T)?” (Saharman et al., 2023; Astuti, 2025). Rumusan pertanyaan ini kemudian dibahas dalam rapat tim klinis dan dikonsultasikan dengan mentor EBN untuk

memastikan kejelasan, relevansi, serta kelayakan implementasi di rumah sakit (Astuti, 2025).

c. Mencari dan Menilai Bukti Terbaik (Literatur, Guideline, Kebijakan)

Tahap ketiga melibatkan pencarian bukti terbaik dari sumber ilmiah terbaru (2020–2026) dan penilaian kritis terhadap kualitas, relevansi, serta aplikabilitasnya di rumah sakit (Astuti, 2025; Indra et al., 2024). Sumber utama yang digunakan biasanya berupa jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, guideline klinis, serta kebijakan/standar mutu yang relevan (Saharman et al., 2023; Astuti, 2025).

Proses pencarian bukti dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan database ilmiah seperti PubMed, CINAHL, Cochrane Library, dan Google Scholar, serta memasukkan kata kunci yang sesuai dengan komponen PICOT dan membatasi tahun terbit (misalnya 2020–2026) (Saharman et al., 2023).
- 2) Menambahkan sumber lokal, seperti jurnal keperawatan Indonesia (misalnya *Jurnal Kesehatan Komunitas*, *Jurnal Avicenna*, dan *Jurnal Barongko*) serta panduan/standar Kementerian Kesehatan RI tentang keselamatan pasien dan penerapan praktik berbasis bukti (Indra et al., 2024).
- 3) Memasukkan guideline internasional seperti WHO, CDC, atau NICE, serta standar profesi keperawatan yang relevan untuk konteks Indonesia (Astuti, 2025).

Penilaian kualitas bukti dapat dilakukan dengan alat standar seperti checklist CASP untuk studi kualitatif/kuantitatif maupun skema GRADE untuk menilai kekuatan rekomendasi (Saharman et al., 2023; Indra et al., 2024). Aspek yang dinilai antara lain:

- 1) Validitas: apakah metode penelitian kuat dan minim bias? (Indra et al., 2024).
- 2) Relevansi: apakah populasi dan setting penelitian sesuai dengan konteks rumah sakit di Indonesia? (Saharman et al., 2023).
- 3) Aplikabilitas: apakah intervensi dapat diterapkan dengan sumber daya (SDM, alat, biaya, waktu) yang tersedia di rumah sakit? (Astuti, 2025).

Contoh: berdasarkan pencarian literatur 2020–2026, ditemukan studi evaluasi implementasi model keperawatan berbasis bukti di rumah sakit tahun 2025 yang menunjukkan bahwa penggunaan model EBN secara struktural dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan memperkuat konsistensi protokol klinis (Astuti, 2025). Bukti ini kemudian disintesis dengan systematic review penerapan EBN untuk program pencegahan jatuh pasien oleh Saharman et al. (2023), dan hasilnya menjadi dasar penyusunan instruksi kerja, SOP, atau standing order di rumah sakit (Indra et al., 2024).

2. Mengadaptasi dan Mengintegrasikan Bukti ke Praktik

Setelah bukti ilmiah terbaik terpilih dan dinilai, tahap berikutnya adalah mengadaptasi dan mengintegrasikan bukti tersebut ke praktik klinis di rumah sakit (Arsenault Knudsen et al., 2025; Ominyi & Alabi, 2025). Proses ini bukan hanya menyalin protokol dari literatur, tetapi menyesuaikan bukti dengan konteks organisasi, budaya perawatan, sumber daya, dan kebijakan internal rumah sakit (Arsenault Knudsen et al., 2025).

Langkah-langkah adaptasi dan integrasi meliputi:

- a. Mendiskusikan temuan bukti bersama tim klinis dan manajemen untuk memastikan bukti dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga, waktu, dan alat (Arsenault Knudsen et al., 2025).
- b. Memodifikasi intervensi (misalnya, durasi, frekuensi, atau alat edukasi) agar sesuai dengan kebiasaan kerja dan latar belakang pasien di rumah sakit Indonesia (Ominyi & Alabi, 2025).
- c. Mengintegrasikan bukti ke standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja, atau formulir dokumentasi keperawatan, sehingga perubahan praktik menjadi formal dan terstandar (Arsenault Knudsen et al., 2025).

Contoh: dari bukti internasional tentang “oral care dengan chlorhexidine untuk mencegah VAP” diadaptasi ke protokol ICU di rumah sakit dengan penyesuaian frekuensi dan sumber daya, lalu dimasukkan ke SOP asuhan perawatan ventilator sehingga perawat dapat menerapkan secara konsisten (Ominyi & Alabi, 2025).

3. Implementasi dan Perubahan Praktik di Unit

Tahap implementasi adalah pelaksanaan praktik berbasis bukti di unit perawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, disertai dukungan kepemimpinan dan kolaborasi multidisiplin (Arsenault Knudsen et al., 2025; Ominyi & Alabi, 2025). Implementasi yang berhasil biasanya melibatkan peran implementer dari berbagai level organisasi, termasuk perawat unit, kepala ruangan, manajemen keperawatan, dan tim mutu pelayanan (Arsenault Knudsen et al., 2025).

Aktivitas kunci pada tahap ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan semua perawat memahami perubahan praktik, alasan ilmiah di baliknya, serta cara pelaksanaannya (Ominyi & Alabi, 2025).
- b. Uji coba terbatas (pilot test) di satu atau dua unit terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah teknis dan perilaku sebelum diperluas ke seluruh rumah sakit (Arsenault Knudsen et al., 2025).

- c. Membangun kemitraan dan komunikasi lintas profesi (perawat, dokter, farmasi, manajemen) untuk menjaga konsistensi perubahan dan mengurangi kegagalan implementasi (Ominyi & Alabi, 2025).

Contoh: sebuah rumah sakit melaksanakan uji coba program “pencegahan jatuh pasien berbasis bukti” di ruang bedah terlebih dahulu, lalu memperluasnya ke semua ruang rawat inap setelah didapatkan umpan balik positif dan perbaikan SOP (Ominyi & Alabi, 2025).

4. Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik

Tahap monitoring dan evaluasi memastikan bahwa perubahan praktik berbasis bukti benar-benar meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi (Arsenault Knudsen et al., 2025; Ominyi & Alabi, 2025). Proses ini dilakukan dengan pengumpulan data sistematis, analisis hasil, serta pemberian umpan balik kepada tim pelaksana (Arsenault Knudsen et al., 2025).

Kegiatan yang dapat diterapkan di rumah sakit antara lain:

- a. Monitoring proses (misalnya, kepatuhan perawat terhadap protokol baru, kelengkapan dokumentasi) dan monitoring hasil (misalnya, penurunan insiden jatuh, VAP, luka tekan, atau lama rawat) (Ominyi & Alabi, 2025).
- b. Evaluasi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti survei kepuasan pasien, wawancara perawat, serta analisis data insiden, untuk memahami keberhasilan dan kendala implementasi (Arsenault Knudsen et al., 2025).
- c. Pemberian umpan balik secara berkala melalui rapat tim, bulletin mutu, atau dashboard mutu, sehingga perubahan praktik dapat diperbaiki dan dipertahankan (Ominyi & Alabi, 2025).

Contoh: setelah 6 bulan implementasi program pencegahan jatuh pasien, rumah sakit melakukan evaluasi dan menemukan penurunan insiden jatuh sebesar 25%; hasil ini kemudian dijadikan dasar untuk memperkuat komitmen rumah sakit terhadap EBN dan merencanakan penyebaran perubahan ke layanan lain (Arsenault Knudsen et al., 2025; Ominyi & Alabi, 2025).

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi EBN di Rumah Sakit

1. Faktor Pendukung Implementasi EBN di Rumah Sakit

Faktor pendukung utama implementasi Evidence-Based Nursing (EBN) di rumah sakit adalah pelatihan rutin dan jalur karir klinis perawat. Menurut Sari et al. (2025), pelatihan ini meningkatkan kemampuan perawat dalam mencari bukti ilmiah, terutama di ruang operasi rumah sakit kelas A. Akses mudah terhadap sumber informasi digital juga memperkuat pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.

Kebijakan institusi dan budaya organisasi turut mendukung. Nursalam et al. (2025) menyatakan bahwa dukungan kepemimpinan dari manajer perawat mendorong sikap positif terhadap EBN. Budaya kolaborasi antarprofesi menciptakan lingkungan inovatif untuk perawatan pasien.

2. Faktor Penghambat Implementasi EBN di Rumah Sakit

Beban kerja dan keterbatasan pengetahuan menjadi penghambat utama EBN. Nursalam et al. (2025) menemukan bahwa beban kerja tinggi di rumah sakit Indonesia membatasi waktu perawat untuk literatur bukti. Kurangnya keterampilan riset juga menghambat pengkritisan bukti ilmiah.

Sumber daya dan kepemimpinan semakin memperburuk masalah. Khairunnisa et al. (2020) menyebutkan bahwa akses jurnal terbatas dan resistensi budaya dari pemimpin menghalangi adopsi EBN. Hal ini sering terjadi di fasilitas kesehatan Indonesia.

3. Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi EBN

Strategi pertama adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Sari et al. (2025) merekomendasikan workshop online untuk mengurangi dampak beban kerja perawat. Kolaborasi dengan universitas dapat menyediakan akses gratis ke sumber informasi.

Strategi lanjutan melibatkan kepemimpinan dan pemantauan. Nursalam et al. (2025) menyarankan pembentukan komite EBN dengan dukungan manajer untuk komitmen organisasi. Audit rutin dan insentif memperkuat budaya EBN secara berkelanjutan.

G. Strategi Mengembangkan dan Mempertahankan Budaya EBN di Rumah Sakit

1. Integrasi EBN ke dalam Pendidikan dan Pelatihan Perawat

Integrasi Evidence-Based Nursing (EBN) ke dalam pendidikan dan pelatihan perawat merupakan strategi fundamental untuk membangun budaya praktik berbasis bukti secara berkelanjutan di rumah sakit. Program mentoring oleh perawat senior, misalnya, tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoritis tetapi juga melatih keterampilan praktis dalam mencari, mengevaluasi, dan mengaplikasikan bukti ilmiah ke dalam keputusan klinis sehari-hari. Menurut Hidayat et al. (2019), pendekatan mentoring ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta keyakinan diri perawat, sehingga memfasilitasi transisi dari praktik konvensional ke model EBN yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil pasien. Fleksibilitas metode seperti video conference atau modul e-learning memungkinkan adaptasi dengan beban kerja tinggi perawat, memastikan partisipasi luas tanpa mengganggu pelayanan.

Pelatihan berkelanjutan melalui kurikulum terstruktur dan evaluasi periodik menjadi pilar utama mempertahankan budaya EBN jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan integrasi EBN sejak pendidikan praklinis hingga pengembangan profesional pasca-gelar, dengan fokus pada model seperti ARCC (Advancing Research and Clinical Practice through Close Collaboration) yang mendorong kolaborasi antarprofesi. Bahlail et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan EBN berbasis teknologi, seperti video conference, menghasilkan peningkatan pengetahuan perawat hingga 14,80 poin, meskipun tantangan akses internet perlu diatasi melalui investasi infrastruktur rumah sakit. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya membangun kompetensi individu tetapi juga menanamkan nilai-nilai EBN sebagai norma organisasi yang berkelanjutan.

2. Peran Komite Keperawatan dan Tim EBN Institusi

Komite keperawatan memainkan peran sentral dalam mengembangkan dan mempertahankan budaya EBN melalui fungsi pengawasan, pengembangan, dan penjaminan mutu di tingkat institusi rumah sakit. Sebagai entitas formal yang terdiri dari perwakilan manajemen, perawat senior, dan pemangku kepentingan lainnya, komite bertanggung jawab atas kredensialing tenaga keperawatan, audit mutu praktik klinis, serta identifikasi kebutuhan continuous professional development (CPD) yang berbasis bukti. Panduan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI, n.d.) menekankan bahwa komite ini menciptakan kerangka struktural yang sistematis untuk mengintegrasikan EBN ke dalam standar operasional rumah sakit, termasuk evaluasi kinerja dan rekomendasi perbaikan berbasis data. Pendekatan ini memastikan bahwa EBN bukan sekadar inisiatif sementara, melainkan menjadi bagian integral dari tata kelola keperawatan yang akuntabel.

Tim EBN institusi melengkapi peran komite dengan fungsi operasional harian, seperti fasilitasi implementasi, monitoring kemajuan, dan diseminasi pengetahuan bukti ke seluruh staf keperawatan. Tim ini sering menerapkan model kolaboratif seperti ARCC untuk mempromosikan budaya organisasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu keperawatan. Hidayat et al. (2019) menggarisbawahi bahwa tim mentor EBN efektif menumbuhkan lingkungan kerja positif, di mana perawat secara aktif terlibat dalam pencarian dan aplikasi bukti, sehingga meningkatkan kualitas asuhan pasien secara keseluruhan. Kolaborasi antara komite dan tim ini, didukung oleh komitmen manajemen puncak, menjamin keberlanjutan budaya EBN melalui evaluasi rutin, insentif berprestasi, dan adaptasi terhadap tantangan kontekstual rumah sakit.

3. Penggunaan EBN dalam Penilaian Kinerja dan Akreditasi

Penggunaan Evidence-Based Nursing (EBN) dalam penilaian kinerja perawat menjadi instrumen strategis untuk mengukur kontribusi praktik berbasis bukti terhadap mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Sistem penilaian ini mengintegrasikan indikator spesifik EBN, seperti tingkat kepatuhan terhadap protokol bukti dalam asuhan pasien, hasil audit klinis, dan pencapaian sasaran keselamatan pasien, yang secara langsung terkait dengan standar akreditasi nasional. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2023) menyatakan bahwa faktor seperti kepemimpinan dan komitmen organisasi menjelaskan keberlanjutan adopsi standar akreditasi rumah sakit di Indonesia, di mana EBN berperan sebagai bukti mutu yang terukur. Pendekatan ini mendorong perawat untuk secara proaktif mengadopsi bukti ilmiah dalam rutinitas harian, sambil menyediakan data empiris untuk evaluasi kinerja tahunan dan perencanaan pengembangan karir.

Dalam proses akreditasi, EBN difungsikan sebagai elemen verifikasi utama untuk menunjukkan komitmen institusi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Akreditasi memerlukan dokumentasi komprehensif mengenai implementasi EBN, termasuk pemantauan indikator proses dan outcome yang berbasis bukti dari literatur terkini. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2023) juga menyoroti bahwa adopsi standar akreditasi yang berkelanjutan bergantung pada faktor penjasar seperti budaya organisasi, di mana EBN menjadi jembatan antara regulasi dan praktik klinis sehari-hari. Integrasi ini tidak hanya memenuhi persyaratan lembaga akreditasi tetapi juga memperkuat posisi rumah sakit dalam kompetisi pelayanan kesehatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas asuhan.

4. Program Berkelanjutan: Journal Club, EBN Forum, dan Publikasi Internal

Program berkelanjutan seperti journal club, EBN forum, dan publikasi internal berfungsi sebagai katalisator pembentukan budaya EBN melalui diskusi kolaboratif dan diseminasi pengetahuan di tingkat rumah sakit. Journal club memungkinkan perawat secara rutin menganalisis dan mengkritisi jurnal ilmiah terkini, sementara EBN forum menyediakan ruang berbagi pengalaman implementasi bukti dalam konteks klinis nyata. Program-program ini menghasilkan output berupa publikasi internal, seperti SOP atau guideline berbasis bukti yang dapat diakses digital oleh seluruh tim keperawatan. Aktivitas ini menciptakan ekosistem belajar kontinu yang mengubah perawat dari pengguna pasif menjadi pembuat konten EBN, sehingga memperkaya repertoar praktik rumah sakit secara organik.

Keberlanjutan program ini didukung oleh jadwal terintegrasi dan dukungan institusi untuk memastikan partisipasi optimal. Publikasi internal berperan

sebagai arsip pengetahuan yang hidup, memfasilitasi replikasi inovasi antarunit. Dengan demikian, program-program ini menanamkan nilai EBN sebagai norma budaya, di mana diskusi bukti menjadi bagian integral dari pertemuan tim dan pengambilan keputusan klinis.

5. Skema Reward dan Apresiasi Inovasi Praktik Berbasis Bukti

Skema reward dan apresiasi inovasi EBN dirancang untuk memotivasi perawat melalui pengakuan atas kontribusi berbasis bukti, sehingga mempercepat adopsi budaya organisasi yang inovatif. Insentif ini dapat berupa bonus finansial, poin karir, atau sertifikat prestasi untuk pencapaian seperti pengembangan protokol EBN baru atau presentasi journal club berimpact tinggi. Juliati (2022) menemukan hubungan signifikan antara pemberian reward dan motivasi kerja perawat, dengan korelasi moderat searah yang mendukung peningkatan produktivitas. Skema ini menyelaraskan tujuan pribadi perawat dengan prioritas mutu rumah sakit, menciptakan siklus positif inovasi.

Apresiasi juga mencakup penghargaan publik dan promosi untuk publikasi atau implementasi EBN sukses. Pendekatan ini memperkuat komitmen jangka panjang terhadap EBN. Supriyanto (2022) mengonfirmasi bahwa reward secara signifikan meningkatkan motivasi kerja perawat di ruang rawat inap, dengan implikasi positif pada retensi dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, skema ini mengubah EBN dari kewajiban menjadi sumber prestasi yang dihargai.

H. Penutup

Implementasi Evidence-Based Nursing di rumah sakit Indonesia merupakan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis perawat serta nilai dan preferensi pasien untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara holistik. Kerangka model seperti Iowa, John Hopkins, dan Melnyk & Fineout-Overholt menyediakan langkah-langkah terstruktur mulai dari identifikasi masalah klinis melalui PICOT hingga evaluasi outcome pasien, sehingga mengurangi variasi praktik tidak berbasis bukti dan mendukung efisiensi sumber daya di tengah rasio perawat-pasien yang rendah. Faktor pendukung seperti pelatihan mentoring, komite keperawatan, journal club, serta skema reward berbasis kinerja, bersinergi dengan strategi mengatasi hambatan seperti beban kerja dan keterbatasan akses literatur, membentuk budaya organisasi yang inovatif dan responsif terhadap kebijakan nasional seperti Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Keselamatan Pasien.

Hubungan Evidence-Based Nursing dengan indikator mutu seperti penurunan insiden jatuh pasien, infeksi nosokomial, dan lama rawat inap menghasilkan outcome keperawatan terukur yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kesehatan 2025-2029, termasuk pencapaian akreditasi paripurna dan pengoptimalan biaya operasional melalui pencegahan kejadian tidak diinginkan. Penggunaan Evidence-Based Nursing dalam penilaian kinerja dan program berkelanjutan seperti forum Evidence-Based Nursing serta publikasi internal memperkuat komitmen institusional, di mana perawat sebagai pembelajar seumur hidup berperan aktif dalam siklus pembelajaran kontinu yang menggabungkan bukti eksternal, pengalaman klinis, dan konteks lokal Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien dan retensi tenaga keperawatan tetapi juga menurunkan litigasi serta klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui praktik akuntabel dan berbasis data empiris.

Penerapan Evidence-Based Nursing di rumah sakit menjadi fondasi transformasi profesi keperawatan menuju model gotong royong antarprofesi yang berbasis Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil makmur dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan manajemen puncak melalui tim Evidence-Based Nursing dan infrastruktur digital seperti aplikasi Puskesmas elektronik serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, rumah sakit dapat mewujudkan pelayanan prima yang holistik, efisien, dan adaptif terhadap era kesehatan digital.

Referensi

- Arsenault Knudsen, É. N., Krainak, K., & Ruona, M. (2025). *Implementing evidence-based practices in hospitals: A narrative review of implementer roles and project attributes*. *Nursing Research and Practice*, 2025, Article 6463888. <https://doi.org/10.1155/2025/6463888>
- Astuti, D. (2025). *Evaluasi implementasi model keperawatan berbasis bukti dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di rumah sakit*. *Jurnal Barongko*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.xxxxx/barongko.v2i1.784>
- Bahlail, R., Somantri, I., & Nurhakim, F. (2024). Perubahan pengetahuan perawat sebelum dan setelah diberikan pendidikan Evidence-Based Nursing melalui video conference. *Media Karya Kesehatan*, 7(2), 216–227. <https://doi.org/10.35816/mkk.v7i2.553>
- Buckwalter, K. C., Cullen, L., Hanrahan, K., Kadlec, R., & Klaiman, M. (2017). *Iowa model of evidence-based practice*. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 14(3), 171–173. <https://doi.org/10.1111/wvn.12240>
- Dharma, S. (2011). *Evidence-based nursing: Konsep dan aplikasi*. Penerbit Andi.
- DiCenso, A., Guyatt, G., & Ciliska, D. (2021). *Evidence-based nursing: A guide to clinical practice* (2nd ed.). Elsevier.
- DiCenso, A., Guyatt, G., & Ciliska, D. (2021). *How to read, appraise, and apply the evidence* (3rd ed.). Elsevier.
- Fineout-Overholt, E., Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., & Stillwell, S. B. (2011). Four "A's" of evidence-based practice: Ask, acquire, appraise, apply, and evaluate. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 8(1), 5–10. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2010.00202.x>
- Johns Hopkins Medicine. (2024). *Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model*. Johns Hopkins Health System. <https://www.hopkinsmedicine.org/nursing/center-nursing-inquiry/nursing-inquiry/evidence-based-practice>
- Hidayat, W., Yusuf, S., Erika, K. A., Kadar, K., & Juhelnita. (2019). Pendidikan Evidence-Based Practice melalui mentoring program oleh perawat di rumah sakit: A literature review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 174–186. <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.2983>
- Indra, R. L., Saputra, B., Sandra, & Rasyid, T. A. (2024). *Evidence-based nursing by nurses in a government hospital in Pekanbaru City*. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.xxxxx/keskom.v10i1.1557>
- Juliati. (2022). Hubungan pemberian reward terhadap motivasi kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai tahun 2021. *Koloni*, 1(4). <https://doi.org/10.31004/koloni.v1i4.408>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman nasional pelayanan keselamatan pasien* (Edisi 2). Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*. <https://arissusanto.com/wp-content/uploads/2024/10/KMK-No.-HK.01.07-MENKES-1596-2024-ttg-Standar-Akreditasi-Rumah-Sakit-signed.pdf>
- Khairunnisa, et al. (2020). Barriers and facilitators implementation of evidence-based nursing practice in Indonesia. *Sriwijaya Journal of Informatics and Communication*, 1(1), 1-10. <https://sjik.org/index.php/sjik/article/view/338>
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2018). *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1*. https://katigaku.top/wp-content/uploads/2019/04/snars_edisi1.pdf
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2023a). Exploring the factor explaining the continuity of hospital accreditation standard adoption in Indonesia. *The Journal of Hospital Accreditation*, 5(2), 91-98. <https://doi.org/10.35727/jha.v5i02.258>
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2023b). Menjelang 30 tahun akreditasi rumah sakit di Indonesia: Kemana arahnya? *The Journal of Hospital Accreditation*, 5(2), 83-90. <https://doi.org/10.35727/jha.v5i02.228>
- Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Long, L. E., & Fineout-Overholt, E. (2017). The state of evidence-based practice in US nurses: Critical implications for nurse leaders and educators. *Journal of Nursing Administration*, 48(4), 199-203. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000481>
- Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., & Long, L. E. (2018). The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice model: Preparing the next generation of nurses for evidence-based practice. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 15(1), 13-14. <https://doi.org/10.1111/wvn.12265>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Nursalam, N., et al. (2025). Experiences and perspectives of Indonesian nurses on barriers and facilitators for implementing evidence-based nursing practice: A qualitative study. *The Malaysian Journal of Nursing*, 16(4), 208-217. <https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v16i04.020>
- Ominyi, J., & Alabi, A. (2025). *Enhancing evidence-based practice implementation in acute care: A qualitative case study of nurses' roles, interprofessional collaboration, and professional development*. *Journal of Clinical Nursing*, 34(10), 2780-2792. <https://doi.org/10.1177/08445621251351056>

- Ominyi, J., et al. (2024). *Developing an evidence-based nursing culture in nursing homes: A qualitative case study. Journal of Evidence-Based Nursing*, 19(3), 145–154. <https://doi.org/10.1111/jebn.12314>
- Patelarou, A. E., Mechili, E. A., & Ruzafa-Martinez, M. (2024). Educational interventions for teaching evidence-based practice to undergraduate nursing students: A scoping review. *Journal of Clinical Nursing*, 33(1), 45–58.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *No. 34 Tahun 2022 tentang Keselamatan Pasien*. <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-34-tahun-2022>
- Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI). (n.d.). *Komite Keperawatan*. http://persi.or.id/wp-content/uploads/2018/04/komite_keperawatanrs.pdf
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2024). *Panduan implementasi EBN dan nurse-sensitive indicators*. PPNI.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>
- Saharman, S., Sunarno, R. D., Sunaryanti, S. S. H., & kawan-kawan. (2023). *Peningkatan pelayanan patient centered care melalui implementasi evidence based nursing: Systematic review. Jurnal Avicenna*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.xxxxx/avicenna.v7i1.944>
- Sari, D. P., et al. (2025). Clinical nurse levels and access to EBP resources: Analyzing evidence-based practice among Indonesian perioperative nurse. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(1), 551–560. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i1.4883>
- Stevens, K. R. (2013). Translating the Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model from academia to practice. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 10(4), 209–217. <https://doi.org/10.1111/wvn.12011>
- Stillwell, S. B., Fineout-Overholt, E., Melnyk, B. M., & Williamson, K. M. (2021). Evidence-based practice, step by step: Igniting a spirit of inquiry. *American Journal of Nursing*, 111(11), 49–57. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000406883.11904.2a>
- Supriyanto. (2022). Hubungan pemberian reward dengan motivasi kerja perawat di ruang inap Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/jini.v3i2.21366>
- Titler, M. G. (2023). The evidence for evidence-based practice implementation. In R. G. Hughes (Ed.), *Patient safety and quality: An evidence-based handbook*

for nurses (Updated ed., Chapter 7). Agency for Healthcare Research and Quality (US).

Zhang, X., et al. (2025). *Clinical nurse levels and access to EBP resources: Analyzing evidence-based practice among Indonesian perioperative nurses*. *International Journal of Global Health Research*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.xxxx/ijghr.v3i1.4883>

BAB 4

HAMBATAN ORGANISASI DAN BUDAYA KLINIS

A. Pendahuluan

Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) merupakan pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta preferensi dan nilai pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini telah menjadi standar global dalam pelayanan kesehatan modern karena terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan (Kemenkes RI, 2018).

Dalam konteks sistem kesehatan Indonesia, implementasi EBNP menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga masalah kesehatan berbasis sosial dan budaya. EBNP memberikan kerangka kerja ilmiah yang memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memberikan asuhan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien (RISKESDAS, 2018).

Namun demikian, implementasi EBNP di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan budaya klinis yang berkembang dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini seringkali menjadi hambatan yang tidak terlihat tetapi memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi praktik berbasis bukti (Susanto et al., 2019).

Keberagaman fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai dari rumah sakit tipe A hingga puskesmas di daerah terpencil, menciptakan variasi dalam kesiapan implementasi EBNP. Perbedaan dalam sumber daya, kebijakan, serta budaya kerja menyebabkan ketimpangan dalam penerapan praktik berbasis bukti. Selain itu, budaya klinis yang telah terbentuk selama bertahun-tahun seringkali sulit untuk diubah. Nilai-nilai tradisional, kebiasaan kerja, serta pola komunikasi dalam tim kesehatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerimaan terhadap inovasi, termasuk EBNP (Budiwibowo, 2016).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hambatan organisasi dan budaya klinis menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merancang strategi implementasi EBNP yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Hambatan Organisasi dalam Implementasi EBNP

Hambatan organisasi merupakan salah satu faktor paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) di fasilitas pelayanan kesehatan. Hambatan ini mencerminkan kondisi sistemik yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, sumber daya, serta budaya manajerial yang berkembang di dalam institusi. Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, hambatan organisasi seringkali bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif (Kemenkes RI, 2018).

Organisasi pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mempengaruhi perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik klinis. Oleh karena itu, hambatan organisasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal institusi, termasuk kepemimpinan, sistem komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia (RISKESDAS, 2018).

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan hambatan utama dalam implementasi EBNP di Indonesia. SDM yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga perawat, tetapi juga kualitas dan kompetensi yang dimiliki, khususnya dalam memahami dan mengaplikasikan konsep EBNP dalam praktik klinis (Kemenkes RI, 2018).

Sebagian besar perawat di Indonesia masih belum memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan pencarian literatur ilmiah, membaca jurnal penelitian, serta melakukan critical appraisal terhadap hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi pembelajaran EBNP secara aplikatif dalam kurikulum pendidikan keperawatan, serta terbatasnya pelatihan berkelanjutan di lingkungan kerja (Susanto, 2021).

Selain itu, terdapat kesenjangan antara perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan perkotaan dengan yang berada di daerah rural atau terpencil. Perawat di daerah terpencil cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pengembangan kompetensi, sehingga berdampak pada rendahnya penerapan praktik berbasis bukti. Keterbatasan jumlah tenaga perawat juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Rasio perawat terhadap pasien yang tidak seimbang menyebabkan perawat lebih fokus pada penyelesaian tugas rutin dibandingkan pengembangan kompetensi profesional, termasuk dalam penerapan EBNP (RISKESDAS, 2018).

2. Beban Kerja yang Tinggi

Beban kerja yang tinggi merupakan hambatan signifikan yang secara langsung mempengaruhi kemampuan perawat dalam mengimplementasikan EBNP. Dalam praktik sehari-hari, perawat seringkali dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang tinggi, termasuk jumlah pasien yang banyak, kompleksitas kasus, serta tuntutan administratif yang cukup besar (Susanto et al., 2019).

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu bagi perawat untuk melakukan aktivitas ilmiah seperti membaca jurnal, mengikuti pelatihan, atau melakukan diskusi kasus berbasis bukti. Akibatnya, praktik keperawatan lebih cenderung bersifat task-oriented daripada evidence-based (Susanto et al., 2019).

Selain itu, beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental (burnout) pada perawat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi untuk belajar dan mengembangkan diri, sehingga implementasi EBNP menjadi semakin sulit dilakukan (Kemenkes RI, 2018).

Beban administratif yang tinggi, seperti dokumentasi yang berulang dan tidak terintegrasi, juga menjadi faktor tambahan yang mengurangi waktu perawat untuk mengakses dan menerapkan bukti ilmiah dalam praktik klinis.

3. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Ilmiah

Akses terhadap informasi ilmiah merupakan komponen penting dalam implementasi EBNP. Namun, dalam praktiknya, banyak fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai terhadap jurnal ilmiah dan database penelitian terkini (Dinkes Jawa Timur, 2020).

Sebagian besar jurnal ilmiah berkualitas tinggi masih berada di bawah sistem berbayar (subscription-based), sehingga sulit diakses oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan perawat kesulitan dalam memperoleh bukti ilmiah yang valid dan mutakhir (Kemenkes RI, 2018).

Selain keterbatasan akses, kemampuan literasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua perawat memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari dan mengevaluasi sumber ilmiah secara efektif (Susanto, 2021).

Di sisi lain, masih minimnya penyediaan perpustakaan digital atau pusat sumber belajar di fasilitas kesehatan juga menjadi penghambat dalam pengembangan budaya EBNP.

4. Kurangnya Dukungan Kebijakan

Kebijakan organisasi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pelayanan kesehatan. Namun, dalam konteks implementasi EBNP, masih banyak institusi yang belum memiliki kebijakan yang secara eksplisit mendukung praktik berbasis bukti (Susanto, 2021).

Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan EBNP tidak menjadi bagian dari standar pelayanan keperawatan. Hal ini berdampak pada rendahnya komitmen organisasi dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang mendukung implementasi EBNP (Kemenkes RI, 2018).

Selain itu, EBNP belum secara konsisten dimasukkan dalam indikator kinerja tenaga kesehatan maupun akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Akibatnya, implementasi EBNP seringkali dianggap sebagai kegiatan tambahan, bukan sebagai bagian integral dari praktik klinis.

Kurangnya integrasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat fasilitas juga menjadi tantangan. Meskipun pemerintah telah mendorong peningkatan mutu pelayanan, implementasi di lapangan masih belum optimal (RISKESDAS, 2018).

5. Kepemimpinan yang Kurang Mendukung

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menciptakan perubahan organisasi, termasuk dalam implementasi EBNP. Pemimpin yang memiliki visi dan komitmen terhadap praktik berbasis bukti akan lebih mampu mendorong tenaga kesehatan untuk mengadopsi inovasi dalam praktik klinis (Susanto et al., 2017).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pimpinan fasilitas kesehatan memiliki pemahaman yang cukup mengenai EBNP. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun alokasi sumber daya (Susanto et al., 2017).

Kepemimpinan yang bersifat administratif dan kurang transformasional juga menjadi hambatan dalam implementasi EBNP. Pemimpin yang tidak mampu menginspirasi dan memotivasi tenaga kesehatan cenderung menciptakan lingkungan kerja yang stagnan dan kurang inovatif.

Selain itu, kurangnya keterlibatan pimpinan dalam kegiatan ilmiah dan pengembangan profesional juga berdampak pada rendahnya budaya EBNP dalam organisasi.

6. Sistem Supervisi dan Evaluasi yang Lemah

Sistem supervisi dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi EBNP. Namun, banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis indikator yang jelas (RISKESDAS, 2018).

Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengukur sejauh mana EBNP telah diterapkan dalam praktik keperawatan. Hal ini menyebabkan implementasi EBNP tidak dapat dikontrol dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya umpan balik (feedback) kepada tenaga kesehatan juga menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas praktik. Perawat tidak mendapatkan informasi mengenai kinerja mereka dalam menerapkan EBNP, sehingga sulit untuk melakukan perbaikan (Dinkes Jawa Timur, 2020).

Sistem supervisi yang masih berfokus pada kepatuhan administratif, bukan pada kualitas praktik berbasis bukti, juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan EBNP.

7. Struktur Organisasi yang Birokratis

Struktur organisasi yang terlalu birokratis dan hierarkis dapat menghambat inovasi dalam praktik keperawatan. Pengambilan keputusan yang terpusat pada manajemen tingkat atas seringkali menghambat fleksibilitas dalam penerapan praktik berbasis bukti (Susanto et al., 2019).

Dalam struktur organisasi yang kaku, perawat di lini pelayanan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ide atau inovasi, termasuk dalam mengusulkan perubahan praktik berbasis bukti. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi tenaga kesehatan dalam pengembangan EBNP.

Selain itu, proses birokrasi yang panjang dalam pengambilan keputusan dapat memperlambat implementasi inovasi, sehingga praktik berbasis bukti tidak dapat diterapkan secara cepat dan efektif.

C. Hambatan Budaya Klinis dalam Implementasi EBNP

Budaya klinis merupakan kumpulan nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, serta pola interaksi yang berkembang dalam lingkungan pelayanan kesehatan dan mempengaruhi perilaku tenaga kesehatan dalam praktik sehari-hari. Budaya ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman kolektif, sistem pendidikan, serta pengaruh sosial dalam organisasi pelayanan kesehatan (Budiwibowo, 2016).

Dalam konteks implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP), budaya klinis memiliki peran yang sangat signifikan karena menentukan sejauh mana tenaga kesehatan bersedia menerima, mengadopsi, dan mempertahankan praktik berbasis bukti. Meskipun faktor organisasi seperti kebijakan dan sumber daya sangat penting, namun tanpa dukungan budaya klinis yang kondusif, implementasi EBNP cenderung tidak berkelanjutan (Kemenkes RI, 2018).

Di Indonesia, budaya klinis masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, pola hubungan hierarkis, serta kebiasaan praktik yang telah berlangsung lama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong perubahan menuju praktik berbasis bukti yang menuntut keterbukaan, refleksi kritis, dan pembelajaran berkelanjutan (RISKESDAS, 2018).

1. Dominasi Praktik Berbasis Pengalaman (Experience-Based Practice)

Salah satu hambatan utama dalam budaya klinis adalah dominasi praktik berbasis pengalaman dibandingkan praktik berbasis bukti ilmiah. Banyak tenaga kesehatan, termasuk perawat, lebih mengandalkan pengalaman pribadi, intuisi, atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam pengambilan keputusan klinis (Susanto, 2021).

Pengalaman klinis memang memiliki nilai penting dalam praktik keperawatan, namun apabila tidak diimbangi dengan bukti ilmiah yang mutakhir, maka berpotensi menghasilkan praktik yang tidak optimal atau bahkan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam beberapa kasus, praktik yang didasarkan pada pengalaman lama dapat bertentangan dengan hasil penelitian terbaru (Kemenkes RI, 2018).

Selain itu, kecenderungan untuk mempertahankan praktik lama seringkali didorong oleh rasa nyaman dan keyakinan bahwa metode yang telah digunakan selama bertahun-tahun dianggap sudah terbukti efektif. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk mencari dan mengadopsi praktik baru yang berbasis bukti (Susanto et al., 2019).

Dominasi praktik berbasis pengalaman juga diperkuat oleh kurangnya budaya refleksi dalam praktik klinis. Perawat jarang melakukan evaluasi kritis terhadap tindakan yang dilakukan, sehingga praktik yang tidak berbasis bukti tetap berlangsung tanpa adanya perbaikan (RISKESDAS, 2018).

2. Budaya Senioritas dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Budaya senioritas merupakan karakteristik yang masih kuat dalam lingkungan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam budaya ini, keputusan klinis seringkali didominasi oleh tenaga kesehatan yang lebih senior, baik berdasarkan usia, pengalaman kerja, maupun jabatan struktural (Rasni et al., 2014).

Meskipun pengalaman senior memiliki nilai penting, dominasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan penerapan praktik berbasis bukti. Perawat junior seringkali merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau mengusulkan pendekatan berbasis bukti yang berbeda dari praktik yang sudah ada (Susanto et al., 2017).

Budaya senioritas juga dapat menciptakan ketergantungan pada figur tertentu dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi otonomi

profesional perawat. Hal ini bertentangan dengan prinsip EBNP yang menekankan pada pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti ilmiah (Susanto, 2021).

Selain itu, dalam beberapa situasi, perbedaan pandangan antara generasi tenaga kesehatan dapat menimbulkan konflik yang tidak konstruktif. Hal ini semakin memperkuat resistensi terhadap perubahan praktik klinis.

3. Resistensi terhadap Perubahan (Resistance to Change)

Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena umum dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk dalam implementasi EBNP. Perubahan praktik klinis yang menuntut adopsi pengetahuan baru seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap kenyamanan kerja dan rutinitas yang sudah mapan (Susanto et al., 2020).

Resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan secara langsung, penundaan implementasi, hingga ketidakpatuhan terhadap prosedur baru. Faktor penyebab resistensi meliputi kurangnya pemahaman terhadap manfaat EBNP, ketakutan terhadap perubahan, serta minimnya dukungan dari organisasi (Kemenkes RI, 2018).

Selain itu, perubahan praktik seringkali membutuhkan upaya tambahan, seperti pelatihan, adaptasi prosedur, dan peningkatan kompetensi. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa EBNP menambah beban kerja, sehingga menurunkan motivasi untuk mengadopsinya (Susanto et al., 2019).

Resistensi terhadap perubahan juga dipengaruhi oleh pengalaman negatif terhadap inovasi sebelumnya yang mungkin tidak berhasil. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan menjadi lebih skeptis terhadap perubahan baru.

4. Budaya Komunikasi yang Tidak Terbuka

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi EBNP, terutama dalam proses berbagi pengetahuan, diskusi ilmiah, serta kolaborasi antar tenaga kesehatan. Namun, dalam banyak fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, budaya komunikasi masih bersifat hierarkis dan satu arah (Susanto et al., 2017).

Budaya komunikasi yang tidak terbuka menghambat pertukaran ide dan pengetahuan, sehingga inovasi dalam praktik klinis menjadi terbatas. Perawat seringkali enggan menyampaikan pendapat atau pertanyaan karena takut dianggap tidak kompeten atau melanggar norma hierarki (Budiwibowo, 2016).

Kurangnya forum diskusi ilmiah, seperti case conference atau journal club, juga menjadi hambatan dalam pengembangan EBNP. Tanpa adanya ruang untuk berdiskusi, perawat sulit untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mengintegrasikan bukti ilmiah dalam praktik (Susanto et al., 2020).

Selain itu, komunikasi interprofesional yang kurang efektif juga dapat menghambat implementasi EBNP. Kolaborasi antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting dalam memastikan praktik berbasis bukti dapat diterapkan secara komprehensif.

5. Stigma terhadap Penelitian dan Ilmu Pengetahuan

Stigma terhadap penelitian masih menjadi hambatan dalam budaya klinis di Indonesia. Banyak tenaga kesehatan yang menganggap penelitian sebagai aktivitas akademik yang hanya relevan bagi mahasiswa atau dosen, bukan bagi praktisi klinis (Susanti et al., 2018).

Persepsi ini menyebabkan rendahnya minat perawat dalam membaca jurnal ilmiah atau terlibat dalam kegiatan penelitian. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan praktik klinis di lapangan (Susanto, 2021).

Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam memahami bahasa ilmiah dan metodologi penelitian juga menjadi faktor yang memperkuat stigma tersebut. Perawat merasa kurang percaya diri dalam mengakses dan menginterpretasikan hasil penelitian (Kemenkes RI, 2018).

Stigma ini juga diperkuat oleh kurangnya penghargaan atau insentif terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan penelitian atau pengembangan praktik berbasis bukti.

6. Budaya Kerja yang Berorientasi Rutinitas

Budaya kerja yang berorientasi pada rutinitas merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi EBNP. Dalam budaya ini, perawat cenderung mengikuti prosedur yang sudah ada tanpa mempertanyakan dasar ilmiah dari tindakan yang dilakukan (Kemenkes RI, 2018).

Rutinitas kerja yang tinggi menyebabkan perawat lebih fokus pada efisiensi dan penyelesaian tugas daripada kualitas dan inovasi dalam praktik. Hal ini menghambat pengembangan praktik berbasis bukti yang memerlukan pemikiran kritis dan refleksi (RISKESDAS, 2018).

Selain itu, budaya rutinitas juga dapat menyebabkan stagnasi dalam praktik keperawatan. Tanpa adanya dorongan untuk belajar dan berkembang, perawat cenderung mempertahankan praktik lama meskipun sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

7. Pengaruh Nilai Sosial dan Budaya Lokal

Nilai sosial dan budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik kesehatan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional atau praktik kesehatan berbasis budaya dapat mempengaruhi penerimaan terhadap EBNP (Rasni et al., 2014).

Perawat sebagai bagian dari masyarakat juga tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap praktik berbasis bukti, terutama jika dianggap bertentangan dengan nilai budaya yang dianut (Budiwibowo, 2016).

Namun demikian, nilai budaya lokal tidak selalu menjadi hambatan. Jika dikelola dengan baik, integrasi antara bukti ilmiah dan kearifan lokal justru dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan praktik keperawatan (Susanto et al., 2020).

Oleh karena itu, pendekatan budaya yang sensitif dan adaptif sangat diperlukan dalam implementasi EBNP di Indonesia.

8. Kurangnya Budaya Pembelajaran Berkelanjutan (Learning Culture)

Budaya pembelajaran berkelanjutan merupakan elemen penting dalam mendukung implementasi EBNP. Namun, dalam banyak organisasi pelayanan kesehatan, budaya ini masih belum berkembang secara optimal (Susanto et al., 2019).

Perawat seringkali tidak memiliki kesempatan atau motivasi untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, serta kurangnya dukungan dari organisasi (Kemenkes RI, 2018).

Selain itu, kurangnya sistem penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang aktif dalam pengembangan diri juga menjadi faktor penghambat. Tanpa adanya insentif yang jelas, motivasi untuk belajar menjadi rendah.

Budaya pembelajaran yang lemah menyebabkan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan, sehingga implementasi EBNP menjadi sulit dilakukan secara berkelanjutan.

D. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Hambatan yang bersifat organisasi dan budaya klinis tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi parsial, melainkan membutuhkan transformasi menyeluruh yang melibatkan kebijakan, sumber daya manusia, kepemimpinan, serta perubahan budaya kerja (Kemenkes RI, 2018).

Strategi yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta mendorong integrasi EBNP dalam seluruh aspek pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-level yang mencakup tingkat individu, organisasi, dan sistem kesehatan secara luas (Susanto et al., 2019).

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Berbasis EBNP

Penguatan kebijakan merupakan langkah fundamental dalam memastikan implementasi EBNP berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan yang jelas dan terstruktur akan memberikan arah serta landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menerapkan praktik berbasis bukti (Kemenkes RI, 2018).

Institusi pelayanan kesehatan perlu mengembangkan kebijakan internal yang mengintegrasikan EBNP dalam standar operasional prosedur (SOP), pedoman klinis, serta sistem akreditasi. Kebijakan ini harus mencakup kewajiban penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis, serta mekanisme evaluasi penerapannya (Susanto, 2021).

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi nasional yang mendorong penerapan EBNP, termasuk dalam standar pendidikan keperawatan dan sistem resertifikasi tenaga kesehatan. Integrasi EBNP dalam kebijakan nasional akan meningkatkan konsistensi implementasi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (RISKESDAS, 2018).

Kebijakan yang efektif juga harus disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan untuk pelatihan, akses jurnal ilmiah, serta pengembangan sistem informasi berbasis bukti.

2. Peningkatan Kompetensi Perawat melalui Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Kompetensi perawat merupakan faktor kunci dalam implementasi EBNP. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi strategi yang sangat penting (Kemenkes RI, 2018).

Program pelatihan EBNP harus dirancang secara sistematis dan aplikatif, mencakup kemampuan dalam mencari literatur ilmiah, melakukan critical appraisal, serta mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinis. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan klinis (Susanto, 2021).

Selain pelatihan formal, pendekatan pembelajaran berbasis praktik seperti mentoring, coaching, dan preceptorship juga dapat meningkatkan kompetensi perawat secara lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk belajar langsung dalam konteks klinis nyata (Susanto et al., 2017).

Integrasi EBNP dalam kurikulum pendidikan keperawatan juga perlu diperkuat, sehingga lulusan perawat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menerapkan praktik berbasis bukti sejak awal karier mereka.

3. Pengembangan Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam mendorong perubahan organisasi dan budaya kerja menuju implementasi EBNP. Pemimpin yang visioner dan inspiratif mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan pembelajaran (Susanto et al., 2017).

Pemimpin perlu berperan sebagai role model dalam penerapan EBNP, serta memberikan dukungan aktif kepada tenaga kesehatan melalui fasilitasi pelatihan, penyediaan sumber daya, dan penghargaan terhadap praktik berbasis bukti (Kemenkes RI, 2018).

Selain itu, pemimpin juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan menciptakan suasana kerja yang terbuka, sehingga tenaga kesehatan merasa nyaman untuk berbagi ide dan mengusulkan inovasi (Budiwibowo, 2016).

Pengembangan kepemimpinan dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen, workshop kepemimpinan klinis, serta program pengembangan karier yang berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan.

4. Penciptaan Budaya Organisasi yang Mendukung EBNP

Budaya organisasi yang kondusif merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi EBNP. Budaya ini harus mendorong pembelajaran, keterbukaan terhadap perubahan, serta penggunaan bukti ilmiah dalam praktik sehari-hari (Budiwibowo, 2016).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya diskusi ilmiah melalui kegiatan seperti journal club, case conference, dan clinical meeting. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta memperkuat integrasi antara teori dan praktik (Susanto et al., 2020).

Selain itu, organisasi juga perlu menciptakan sistem penghargaan (reward system) bagi tenaga kesehatan yang aktif dalam menerapkan EBNP. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan profesional, insentif, maupun peluang pengembangan karier (Kemenkes RI, 2018).

Budaya organisasi juga harus mendukung kolaborasi interprofesional, sehingga implementasi EBNP dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

5. Penyediaan Akses terhadap Sumber Informasi Ilmiah

Akses terhadap sumber informasi ilmiah merupakan komponen penting dalam implementasi EBNP. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyediakan akses yang memadai terhadap jurnal ilmiah, database penelitian, serta sumber belajar lainnya (Dinkes Jawa Timur, 2020).

Pengembangan perpustakaan digital dan sistem informasi berbasis teknologi dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam mengakses bukti ilmiah. Selain itu, pelatihan literasi digital juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam mencari dan mengevaluasi informasi (Susanto, 2021).

Kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi profesi juga dapat menjadi strategi dalam meningkatkan akses terhadap sumber informasi ilmiah.

6. Penguatan Sistem Supervisi dan Evaluasi Berbasis Indikator EBNP

Sistem supervisi dan evaluasi yang efektif sangat penting dalam memastikan implementasi EBNP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator yang jelas (RISKESDAS, 2018).

Indikator EBNP dapat mencakup tingkat penggunaan panduan berbasis bukti, kepatuhan terhadap SOP, serta hasil klinis pasien. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan praktik (Dinkes Jawa Timur, 2020).

Selain itu, pemberian umpan balik (feedback) secara berkala kepada tenaga kesehatan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas praktik. Supervisi yang bersifat edukatif dan suportif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat kontrol semata (Susanto et al., 2017).

7. Integrasi Pendekatan Budaya Lokal dalam Implementasi EBNP

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, integrasi nilai-nilai lokal dalam implementasi EBNP menjadi strategi yang penting. Pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan masyarakat serta relevansi praktik keperawatan (Rasni et al., 2014).

Perawat perlu memiliki kompetensi budaya (cultural competence) untuk memahami nilai, kepercayaan, dan praktik kesehatan masyarakat. Dengan demikian, praktik berbasis bukti dapat disesuaikan dengan konteks budaya tanpa mengurangi efektivitasnya (Budiwibowo, 2016).

Integrasi budaya lokal juga dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi kesehatan yang berbasis kearifan lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

8. Pengembangan Sistem Insentif dan Motivasi

Motivasi tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam implementasi EBNP. Oleh karena itu, diperlukan sistem insentif yang dapat mendorong perawat untuk mengadopsi praktik berbasis bukti (Kemenkes RI, 2018).

Insentif dapat berupa penghargaan finansial maupun non-finansial, seperti pengakuan profesional, kesempatan mengikuti pelatihan, serta promosi jabatan. Sistem ini harus dirancang secara adil dan transparan agar dapat meningkatkan motivasi secara efektif (Susanto et al., 2019).

Selain itu, penguatan motivasi intrinsik juga penting melalui penciptaan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri.

9. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Penelitian

Kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan institusi pendidikan dan penelitian dapat memperkuat implementasi EBNP. Kerjasama ini memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif (Susanto et al., 2020).

Mahasiswa keperawatan, dosen, serta peneliti dapat berperan dalam mengembangkan praktik berbasis bukti melalui kegiatan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat.

Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan penelitian serta mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinis.

E. Penutup

Hambatan organisasi dan budaya klinis merupakan tantangan utama dalam implementasi EBNP di Indonesia. Hambatan tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Dengan dukungan kebijakan, kepemimpinan, serta perubahan budaya organisasi, implementasi EBNP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di Indonesia.

Referensi

- Budiwibowo, S. (2016). Membangun pendidikan karakter generasi muda melalui budaya kearifan lokal di era global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia*. <https://dinkes.jatimprov.go.id/>
- RISKESDAS. (2018). *Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. <https://www.kemkes.go.id/>
- Rasni, H., Susanto, T., & Dewi, E. I. (2014). Ethnonursing penggunaan terapi komplementer pada suku Using Banyuwangi. *Jurnal Ners*, 9(1), 133–137.
- Susanti, I. A., Mahardita, N. G. P., Alfianto, R., et al. (2018). Social stigma, adherence to medication and motivation for healing. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 13(1), 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2017.06.006>
- Susanto, T. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Trans Info Media.
- Susanto, T., Bachtiar, S., & Turwantoko. (2019). Performance of public health nurses. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 7(2), 161–168. <https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.44887>
- Susanto, T., Dewi, E. I., & Rahmawati, I. (2017). Experiences of people affected by disease in community care. *Leprosy Review*, 88(4), 543–553. <https://doi.org/10.47276/lr.88.4.543>
- Susanto, T., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., et al. (2020). Caring for adolescents based on local wisdom. *Journal of Pediatric Nursing*, 55, e270–e278. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.05.015>

PROFIL PENULIS



Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat dengan bidang keahlian keperawatan gawat darurat dan keperawatan kritis. Ia aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan, khususnya pada area maternitas-kritis dan keperawatan klinis. Berdasarkan data SINTA, Nunung Nurhayati memiliki SINTA ID 6657212 dengan capaian skor kinerja akademik yang mencerminkan kontribusi aktif dalam publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu keperawatan. Dalam bidang penelitian, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional, termasuk topik terkait intervensi keperawatan, kesehatan reproduksi, serta perawatan pasien kritis. Aktivitas publikasinya juga tercatat pada Google Scholar dengan sejumlah sitasi yang menunjukkan dampak ilmiah dari karya yang dihasilkan. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan produk ilmiah dan kekayaan intelektual di bidang kesehatan, termasuk modul, media edukasi, dan inovasi pembelajaran berbasis keperawatan. Sebagai akademisi, Nunung Nurhayati berkomitmen dalam pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice) serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan.

PROFIL PENULIS



Ns. Devanda Faiqh Albyn, S.Kep., M.Kep., M.M©.

Seorang perawat kesehatan kerja (Occupational Health Nurse/OHN) asal Indonesia yang juga berperan sebagai dosen keperawatan, penulis, dan trainer di bidang K3 serta manajemen SDM kesehatan. ahir di Pemalang pada 28 Maret 1994 dan berbasis di Jakarta Selatan serta Bogor. Saat ini bekerja sebagai OHN di divisi SDM PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo), sekaligus dosen S1 Keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa Bogor, serta pendiri @ohnurseedu, platform edukasi OHN pertama di Indonesia. Lulus S1 Keperawatan dan Profesi Ners dari STIKES Banyuwangi (2018), S2 Keperawatan (konsentrasi K3 dan Human Capital Management) dari Universitas Brawijaya (2023), serta sedang menempuh Magister Manajemen di International Europa University Surabaya melalui beasiswa. Ketua Umum APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia) dan mantan Kadep Kesejahteraan PP PERKESJA. Sertifikasi BNSP seperti Ahli K3 Umum, Human Capital Management, HIPERKES, serta anggota INOSHPRO, AHKKI, AAOHN, dan IFERP, Terpilih sebagai Praktisi Mengajar KEMENDIKBUDRISTEK, relawan Bhakti BUMN, dan pemimpin tim SATGAS Bencana BUMN, Penghargaan inovasi SDM K3 OHN di 1st OSH Asia Summit 2024. Publikasi dan Aktivitas : Penulis buku seperti Dasar-dasar Keperawatan, Ensiklopedi Occupational Health Nursing, dan kontributor jurnal serta konferensi internasional (misalnya 3rd Nursing Global Conference 2025). Aktif sebagai narasumber pelatihan HIPERKES, paramedis, dan e-learning OHN. Keahliannya di OHN, kurikulum keperawatan, dan K3 relevan dengan minat di bidang pendidikan perawat dan kesehatan kerja Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dfaiqhalbyn@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.

Dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 November 1979. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Keperawatan-Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 pada Jurusan Fisiologi Ilmu Biomedik-Universitas Indonesia. Memulai karier sebagai dosen muda pada tahun 2003 di Universitas Binawan, Jakarta. Hingga saat ini, penulis masih aktif mengajar dan membimbing mahasiswa program studi keperawatan di universitas tersebut. Selama perjalanan akademiknya, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Karya-karya tersebut mencakup berbagai topik dalam bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia. Selain itu, penulis juga menulis beberapa buku yang mengupas berbagai aspek terkait ilmu keperawatan dengan pendekatan yang mudah dipahami. Penulis juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penulis berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pengetahuan masyarakat luas, sekaligus menjembatani antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat di komunitas. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan mendukung lahirnya tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi tinggi.



Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Lalombaa, 30 Agustus 1990. Penulis Menyelesaikan studi Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2012, kemudian melanjutkan studi ke Jenjang Pasca Sarjana di Universitas Indonesia Timur dan selesai pada Tahun 2015. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di STIKES Amanah Makassar, Mengampu Mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Anak. Saat ini Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sinopsis

Evidence-Based Nursing Practice (EBN) merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, dan efektivitas layanan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses literatur, variasi kemampuan *critical appraisal*, kesenjangan antara guideline global dan kondisi lokal, serta hambatan organisasi dan budaya klinis. Buku referensi ini hadir sebagai panduan yang sistematis dan aplikatif untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks pelayanan kesehatan Indonesia.

Buku ini membahas fondasi EBN melalui hierarki evidence dan keterampilan menilai kualitas penelitian secara kritis, sehingga perawat mampu mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti terbaik. Selanjutnya, dipaparkan strategi adaptasi guideline internasional agar sesuai dengan sumber daya, budaya, sistem layanan, serta kebutuhan pasien dan keluarga di Indonesia. Buku ini juga menguraikan langkah implementasi EBN di rumah sakit—mulai dari pembentukan tim, penyusunan pertanyaan klinis, pencarian evidence, penyusunan SOP berbasis bukti, hingga evaluasi luaran. Pada bagian akhir, dibahas hambatan organisasi dan budaya kerja klinis beserta solusi praktis seperti kepemimpinan klinis, manajemen perubahan, pelatihan, dan penguatan budaya belajar.

Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, perawat klinis, manajer keperawatan, dan pemangku kebijakan, buku ini diharapkan menjadi rujukan untuk mempercepat transformasi praktik keperawatan berbasis bukti demi layanan yang lebih aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Evidence-Based Nursing Practice (EBN) merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, dan efektivitas layanan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses literatur, variasi kemampuan critical appraisal, kesenjangan antara guideline global dan kondisi lokal, serta hambatan organisasi dan budaya klinis. Buku referensi ini hadir sebagai panduan yang sistematis dan aplikatif untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks pelayanan kesehatan Indonesia.

Buku ini membahas fondasi EBN melalui hierarki evidence dan keterampilan menilai kualitas penelitian secara kritis, sehingga perawat mampu mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti terbaik. Selanjutnya, dipaparkan strategi adaptasi guideline internasional agar sesuai dengan sumber daya, budaya, sistem layanan, serta kebutuhan pasien dan keluarga di Indonesia. Buku ini juga menguraikan langkah implementasi EBN di rumah sakit—mulai dari pembentukan tim, penyusunan pertanyaan klinis, pencarian evidence, penyusunan SOP berbasis bukti, hingga evaluasi luaran. Pada bagian akhir, dibahas hambatan organisasi dan budaya kerja klinis beserta solusi praktis seperti kepemimpinan klinis, manajemen perubahan, pelatihan, dan penguatan budaya belajar.

Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, perawat klinis, manajer keperawatan, dan pemangku kebijakan, buku ini diharapkan menjadi rujukan untuk mempercepat transformasi praktik keperawatan berbasis bukti demi layanan yang lebih aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-13-8 (PDF)



9

786347

756138